ORIENTACIÓN TÉCNICA
PARA LA GESTIÓN DE LA CONTACTABILIDAD DE USUARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DE LA RED DE SALUD PÚBLICA

Subsecretaría de Redes Asistenciales
División de Gestión de la Red Asistencial

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

REVISORES – SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

Osvaldo Salgado Zepeda	Subsecretario de Redes Asistenciales
Andrea Solis Aguirre	Jefa División de Gestión de la Red Asistencial (DIGERA)

RESPONSABLES TÉCNICOS DEL DOCUMENTO

Francisca Arriagada Gutiérrez	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento de Gestión Ambulatoria y Apoyo Diagnóstico. Referente de Contactabilidad y Navegadores en Red
Pablo Norambuena Mateluna	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento de Gestión Ambulatoria y Apoyo Diagnóstico. Coordinador de la Unidad de Gestión Ambulatoria
Silvana Gonzalez López	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento de Gestión de la Información
Maria Alicia Ribes Langevin	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento de Procesos Clínicos y Gestión Hospitalaria
Mónica Cortés Hidalgo	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento de Gestión de la Información
Irma Vargas Palavicino	División de Atención Primaria. Departamento de Gestión de Cuidados
María de los Ángeles Bravo Beristain	División de Atención Primaria. Departamento de Gestión de Cuidados
Felipe Cortés Leddy	División de Gestión y Desarrollo de las Personas (DIGEDEP). Director Nacional de Enfermería (DNE)
Juan Pablo Rubio Schweizer	Gabinete Ministerial. Comisión Reforma. Asesor
Flavio Ayala Díaz	Gabinete Ministerial. Comisión Reforma. Profesional asesor.
Leonardo Molina Fuentes	División de Gestión de la Red Asistencial. Unidad de Gestión de la Demanda. Departamento de Procesos Clínicos y Gestión Hospitalaria
Anamari Avendaño Arechavala	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento de Gestión Ambulatoria y Apoyo Diagnóstico

COLABORADORES INTERNOS DE MINSAL

Susana Fuentealba Cofré	División de Gestión de la Red Asistencial. Jefa Departamento de Gestión Ambulatoria y Apoyo Diagnóstico
José Ernesto Rosales Caniumil	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento de Gestión Ambulatoria y Apoyo Diagnóstico. Unidad de Odontología
Miguel Ulloa Espinoza	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento de Gestión Ambulatoria y Apoyo Diagnóstico
Sebastián Cortes Moreno	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento de Gestión Ambulatoria y Apoyo Diagnóstico
Maria Paulina Torrealba Jara	División de Gestión de la Red Asistencial. Departamento GES, Redes Complejas y Líneas Temáticas
Carmen Aravena Cerda	Jefa División de Atención Primaria (DIVAP)
María José Letelier	Jefa Departamento de Salud Digital
Eva Guzman Morales	Departamento de Salud Digital. Jefa Unidad de Hospital Digital
Nicolás Alfaro Duarte	Jefe Departamento de Asistencia Remota en Salud (DARS)
Victoria Carvallo	Gabinete Ministerial. Departamento de Asistencia Remota en Salud. Encargada de Proyectos

María José Araya Araya	Gabinete Ministerial. Departamento de Asistencia Remota en Salud. Profesional
José Manuel Villa Catalán	Gabinete Ministerial. Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Profesional
Nora Donoso Valenzuela	Gabinete Ministerial. Jefa Departamento de Participación Social y Gestión Usuaria
Lorena Donoso Abarca	Gabinete Ministerial. División Jurídica. Abogado

COLABORADORES DE LA RED ASISTENCIAL

Karina Gallegos Lagos	Servicio de Salud de Araucanía Sur
Laura Zambrano Peralta	Servicio de Salud de Araucanía Sur
Jonnathan Polanco León	Servicio de Salud de Magallanes
Margarita Cárdenas Coney	Servicio de Salud de Magallanes
Catalina Franco Peña	Servicio de Salud Metropolitano Central
Patricia Jara Sepúlveda	Servicio de Salud Metropolitano Central
Fidel Soto Badilla	Servicio de Salud Metropolitano Occidente
Nicolás Ramirez Aguilera	Servicio de Salud Metropolitano Occidente
Aura Romero Barrientos	Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Mariola Mestanza Yepes	Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Renata Espinosa Monsalve	Servicio de Salud de O´Higgins
Camila Cordero Cavieres	Servicio de Salud de O´Higgins
Mariette Escobar Erices	Hospital Intercultural Kallvu Llanka de Cañete
Ana Cruces Escobar	Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue
Eufemia Medina Velásquez	Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue
Marisol Navarro Alarcón	Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue
Priscila Zúñiga Castillo	Hospital San Vicente de Arauco
Fabiola Gatica Vásquez	Servicio de Salud Arauco
Debora Reid Aguilar	Servicio de Salud Coquimbo
Samuel Brinck Muñoz	Servicio de Salud Coquimbo
Carolina Amaro Romero	Servicio de Salud del Reloncaví
Roxana Bustos Olmos	Servicio de Salud del Reloncaví
Andrea Leiva Angulo	Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder
Daniela Huilipan Ronda	Complejo Hospitalario San José
Kenzo Shinya Cabrera	Complejo Hospitalario San José
Francisca Viñals Figueroa	Servicio de Salud Metropolitano Sur
Victor Revello Castillo	Servicio de Salud Metropolitano Sur
Juan Cáceres Ramirez	Hospital Dr. Sótero del Río
Alejandra Alarcón Espinoza	Hospital Dr. Sótero del Río
Paola Contreras Zúñiga	Servicio de Salud Viña del Mar Quillota
Carol Valencia Cano	Hospital Dr. Gustavo Fricke
Mireya Armijo Umaña	Hospital Dr. Gustavo Fricke
Beatriz Olivares Escobar	Servicio de Salud Viña del Mar Quillota

TABLA DE CONTENIDO

PRÓLOGO **6**

1. INTRODUCCIÓN **8**

2. OBJETIVOS **10**

2.1. OBJETIVO GENERAL 10

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10

3. ALCANCE **10**

3.1. UTILIZACIÓN DE LA CONTACTABILIDAD MULTICANAL 11

4. GLOSARIO Y CONCEPTOS RELEVANTES **12**

5. PROCESO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTACTABILIDAD **16**

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GENERAL 17

5.2. CONTACTABILIDAD DE VINCULACIÓN (INICIAL) 20

5.3. CONTACTABILIDAD DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 25

5.4. CONTACTABILIDAD PARA GESTIÓN DE CITA Y AGENDA 32

5.5. CONTACTABILIDAD POST ATENCIÓN 36

6. COMPROMISO DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN (COVICOM) COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EN LA GESTIÓN DE LA CONTACTABILIDAD **39**

7. SALIDAS DE SISTEMAS DE REGISTROS DE ESPERA PARA PRESTACIONES DE SALUD VÍA GESTIÓN DE CONTACTABILIDAD **40**

7.1. LISTA DE ESPERA NO GES 41

7.2. PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN Y CIERRE DE GARANTÍAS GES 42

7.2.1. CAUSALES DE EXCEPCIÓN DE GARANTÍAS 42

7.2.2. CAUSALES DE CIERRE DE GARANTÍAS 42

7.3. INFORMACIÓN BÁSICA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE SALIDAS DE REGISTROS DE ESPERA POR CONTACTABILIDAD 43

7.4. MODALIDADES DE CAPTURA DE INFORMACIÓN 45

8. GESTIÓN DE LA NO CONTACTABILIDAD **48**

8.1. GESTIÓN DE LA NO CONTACTABILIDAD CON COVICOM 50

8.2. GESTIÓN DE LA NO CONTACTABILIDAD SIN COVICOM 52

9. ANEXOS 54

9.1. ANEXO N°1: DESCRIPCIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS 54

9.2. ANEXO N°2: FACTORES A CONSIDERAR PARA EVALUAR LOS TIPOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN.... 59

9.3. ANEXO N°3: MATRIZ DE EVALUACION DE CANALES DE COMUNICACIÓN 62

9.4. ANEXO N°4: SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD..... 63

9.4.1. SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD PARA EL SUBPROCESO DE VINCULACIÓN 63

9.4.2. SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD PARA EL SUBPROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 78

9.4.3. SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD PARA EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE AGENDAS Y CITAS..... 90

9.4.4. SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD PARA EL SUBPROCESON DE POST ATENCIÓN.....116

9.4.5. SCRIPTS PARA LA GESTIÓN DE LA NO CONTACTABILIDAD 127

9.5. ANEXO N°5: FORMATO PARA EL COMPROMISO DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN (COVICOM).....147

9.6. ANEXO N°6: REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PORTALES PACIENTE.....150

9.7. ANEXO N°7: PROPUESTA DE CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA 156

9.8. ANEXO N°8: INDICADORES PARA EL PROCESO DE CONTACTABILIDAD 159

PRÓLOGO

En la actualidad, todas las organizaciones tienen una dependencia fundamental en la manera y el nivel de relación que establecen con sus clientes en el caso del sector privado, y los ciudadanos para las entidades públicas. La necesidad de conocerlos más certeramente y, particularmente, la posibilidad de poder contactarlos es crucial. Las bases de datos que contienen información de contacto de las personas tienen alto valor para las empresas privadas, ya que con esta información pueden ofrecer sus productos o servicios directamente a cada una de ellas. Es una herramienta principal en las estrategias de esas empresas a pesar de que, para la población, el uso de esta información muchas veces es rechazada.

En las organizaciones públicas, esta herramienta se ha utilizado de manera mucho menos intensiva y probablemente para la población, es mejor valorada en la medida que los mensajes que puede recibir son para la entrega gratuita de servicios necesarios para su bienestar.

En salud, existe una necesidad evidente de contactar a las personas para la entrega de mensajes, educación e información de variada índole tanto en la promoción, la prevención, el control de tratamientos, apoyo en la rehabilitación, etc., como una forma de apoyar en la continuidad de la atención. La capacidad de disponer de una comunicación activa a lo largo del tiempo puede marcar diferencias importantes en los resultados en salud.

En el caso de las listas de espera, es preocupante que un porcentaje alto de usuarios no pueda ser contactado en el momento que los establecimientos están en disponibilidad de entregar el servicio por el cual esperan. Es un contrasentido en relación a lo planteado anteriormente. Imaginemos una empresa privada, que tuviera este problema. Probablemente pasaría por serias dificultades de subsistencia en el mercado.

La contactabilidad, es decir, la posibilidad de establecer comunicación toda vez que sea necesario entre los usuarios, los funcionarios de salud y los establecimientos, es fundamental en salud. Esto requiere contar con información de cómo llegar a las personas por diferentes medios, adecuados a las diferentes características de estas.

Dada la importancia de este tema, la Subsecretaría de Redes Asistenciales conformó un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de contactabilidad que permitiera dar orientaciones técnicas a los Servicios de Salud y los establecimientos, en las distintas fases que implica este proceso.

El resultado de este trabajo es un modelo de contactabilidad en que no solo se trata de establecer el vínculo, esencial, por cierto, sino de manera principal, monitorear y acompañar a cada persona durante el tiempo de espera, estableciendo un plan especial dependiendo de sus características que puedan determinar cambios en la priorización, sustentados por el estado de salud de ellos. Esto debiera resolver uno de los principales motivos de molestia de los usuarios que implica no tener información durante todo el tiempo de espera. Además, la propuesta establece estrategias para maximizar las posibilidades de cumplir con el agendamiento, evitando la pérdida de la oportunidad en la prestación del servicio y, por último, la propuesta busca mantener el contacto después de la entrega del servicio, tanto para obtener una evaluación por parte del usuario, como para establecer mecanismos que aseguren la continuidad de la atención en caso de que requiera otros servicios. Durante todo el proceso se ha puesto especial atención a mantener la confidencialidad de los datos de las personas.

Estas orientaciones técnicas fueron elaboradas con la participación de numerosos profesionales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y otros departamentos del Ministerio, contando además con el aporte de profesionales de varios Servicios de Salud a lo largo del país.

Si bien las realidades del país son muy dispares y las dificultades de contactar a usuarios en zonas alejadas y de difícil acceso son diferentes a los de zonas urbanas, la participación en la elaboración de estas orientaciones técnicas de profesionales de distintos territorios debiera dar cuenta de esta disparidad. Sin embargo, las orientaciones técnicas pueden ser mejoradas o complementadas según las realidades y necesidades de cada equipo.

Estas orientaciones constituyen un hito en nuestro sector público de salud en la medida que enfrentan una falencia importante y permitirán asegurar un tránsito del usuario expedito por los distintos niveles de atención, favoreciendo de manera permanente la actualización de los datos de las personas, fortaleciendo significativamente la continuidad de la atención, mejorando la relación con los usuarios, la confiabilidad y valoración por parte de ellos y, lo más importante, mejorar la efectividad y los resultados en salud. Para el sistema, la posibilidad de contar con información sistematizada producto del proceso de contactabilidad, es de un valor muy alto ya que permitirá la mejor toma de decisiones por parte de las autoridades en todos los niveles.

Estas orientaciones buscan establecer en los actuales equipos del sector, procesos orientados a mejorar la relación con nuestra población y no pretende crear nuevas unidades. Implica un cambio cultural ya que se busca instalar en las prácticas habituales de todos, la importancia de la contactabilidad y, por ende, la necesidad de una comunicación efectiva y de la actualización de la información en cada contacto con nuestros usuarios. Este proceso debe ser acompañado de capacitación adecuada y permanente.

La invitación a los equipos es a ser partícipes de un salto cualitativo en este sentido, que sin dudas implicará un estímulo en el trabajo cotidiano en la medida que nuestros usuarios valorarán su esfuerzo y entregaremos una atención de mayor calidad, con mejores resultados, centrada en las personas, que es el objetivo principal de nuestro quehacer.

Finalmente, agradecemos a los profesionales que han participado en este importante documento, por su entrega, responsabilidad, solvencia técnica y por la capacidad de flexibilizar planteamientos en función de un bien común.

Dr. Osvaldo Salgado Zepeda

Subsecretario de Redes Asistenciales

1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la contactabilidad en el sistema de salud se ha enfocado principalmente en el agendamiento de citas, basándose en la disponibilidad de horas para la atención. Lo anterior, ha provocado que la instancia de comunicación con los usuarios se limite a la oferta de servicios disponibles, provocando consigo un problema en la continuidad de la atención. Como resultado, se produce una desactualización de la información de contacto, generando un aumento en la carga administrativa al intentar reconectar a los usuarios con su Red de Salud, concentrando los esfuerzos de atención en los usuarios con datos más recientes, lo que a su vez incrementa los tiempos de espera y reduce la eficiencia del sistema.

Sin embargo, hoy en día la gestión de la contactabilidad requiere dejar de ser observada como una tarea, y transformase en una estrategia, abarcando un proceso transversal mucho más amplio y continuo en el tiempo, con diversas actividades que mejoren la experiencia del usuario en el sistema de salud, proporcionando un acompañamiento constante que facilite su tránsito y optimice la adherencia a los tratamientos, la satisfacción y la vinculación con la red. Estas actividades incluyen no solo la asignación de citas, sino también el seguimiento proactivo, la reprogramación de citas, la entrega de recordatorios, la resolución de dudas y la orientación sobre el uso adecuado de los servicios de salud.

Adicionalmente, desde la perspectiva del usuario en su recorrido por el sistema de salud, existe una necesidad constante de mantenerse informado sobre el proceso, sus etapas y los tiempos estimados. Según lo identifica el PNUD (2017)[1], la espera es un factor crítico al medir el malestar con el Sistema Público de Salud: "La irritación con la espera está relacionada con sentirse desatendido mientras se aguarda (es decir, en las interacciones, o falta de ellas, dentro del hospital o centros de salud en ese lapso)". Cuando la espera es larga y los usuarios no cuentan con la información que necesitan, las consecuencias pueden ser el deterioro de su salud, la prolongación del sufrimiento y la erosión de la legitimidad del sistema. En cambio, cuando la espera se gestiona de forma proactiva y mejora la experiencia, se puede influir positivamente en la valoración subjetiva del servicio recibido y en los resultados objetivos de salud[2].

Dentro del modelo de continuidad de la atención, la contactabilidad efectiva se establece como un pilar esencial en las diferentes etapas de los procesos de atención clínicos y administrativos. Esta gestión se lleva a cabo a través de los diferentes niveles de la Red Asistencial, desde la atención primaria hasta la especializada, donde la integración, coordinación y colaboración son cruciales para superar los desafíos de la fragmentación de la red. **A través del modelo de gestión de RISS,** que guía el sistema de salud chileno y contempla procesos como la **referencia y contrarreferencia en red,** se ha mejorado la organización de la red de salud, promoviendo una atención más integrada y coordinada en todos los niveles de atención. Además, la **gestión eficiente de agendas y citas** asegura un mejor acceso a las prestaciones, mientras que la introducción de estrategias digitales facilita una comunicación bidireccional entre los usuarios y el sistema de salud, mejorando así la contactabilidad y la continuidad de la atención.

[1] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2017). Desigualdades: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile.

[2] Banco Interamericano de Desarrollo, 2020. Modelo de gestión de la espera a personas que esperan por atención en el sistema público de salud en Chile.

Del mismo modo, la legislación chilena ha evolucionado al proporcionar un marco normativo que apoya la mejora en la gestión de la contactabilidad y la atención sanitaria. La Ley 20.584[3], que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, establece principios fundamentales para garantizar una atención digna y oportuna, fomentando la responsabilidad compartida entre los usuarios y prestadores de servicios de salud. Esta ley asegura el derecho a la información, lo que es crucial para que los usuarios comprendan y participen activamente en su atención de salud. Por otro lado, la Ley 21.541[4], conocida como la ley de telemedicina, impulsa la digitalización y el uso de tecnologías de la información en la atención sanitaria, permitiendo una mayor accesibilidad y continuidad en el cuidado, especialmente en áreas remotas. Complementando estos avances, el Decreto N°6, que establece el Reglamento sobre Acciones Vinculadas a la Atención de Salud Realizada a Distancia[5], formaliza los procedimientos y estándares para la telemedicina, asegurando la calidad y seguridad de las atenciones realizadas a distancia. Este marco jurídico en su conjunto facilita la implementación de estrategias integrales de contactabilidad, promoviendo una comunicación efectiva y continua con los usuarios, lo que a su vez mejora la eficiencia del sistema de salud y la satisfacción del usuario.

Si bien no se ha implementado una estrategia sistemática de contactabilidad a nivel nacional, las redes asistenciales a nivel local y el Ministerio de Salud (MINSAL) de forma centralizada, han realizado diversos esfuerzos para optimizar la interacción con los usuarios y facilitar el acceso a las prestaciones de salud. Dentro de los diversos canales de comunicación implementados se reconocen aquellos con importantes impactos; centros telefónicos locales y la instalación del Departamento de Asistencia Remota en Salud (DARS) del MINSAL que permiten una comunicación bidireccional fluida de los usuarios con los establecimientos, portales de pacientes para facilitar la actualización de datos e información disponible, contactos mediante inteligencia artificial (IA) por mensajerías instantáneas que ha permitido generar contactabilidad masiva, visitas domiciliarias externalizadas con menor costo asociado en los establecimientos, planes comunicacionales para actualización de datos personales y sensibilización en la asistencia a las citas; entre otras. Sin embargo, aún permanecen importantes brechas en la comunicación efectiva y una limitada capacidad de seguimiento durante la espera.

Dado lo anterior, hoy es posible identificar la existencia de múltiples opciones para mejorar los procesos de comunicación, pero, sobre todo, que existe una gran oportunidad para optimizar la gestión de la contactabilidad, dada la disponibilidad de mayor y mejor tecnología y optimizando el trabajo de los funcionarios y funcionarias de la red a través de múltiples canales de comunicación. El relevar la contactabilidad a un nivel de gestión estratégico, con un enfoque en la comunicación efectiva, la personalización y la evaluación, permite fortalecer la relación con el sistema de salud, optimizar el uso de recursos y brindar una atención oportuna, personalizada y de alta calidad, acorde a los requerimientos para avanzar hacia la instalación de procesos en un estado moderno.

Adicionalmente, generar sistemas integrados de información para el seguimiento adecuado y la actualización oportuna de los datos de contacto, considerando que una persona puede estar en espera de múltiples prestaciones de salud y que su información de contacto es transversal y aplicable a todas las atenciones, permitirá disminuir la sobrecarga del personal administrativo. Sin protocolos

[3] Ministerio de Salud de Chile. (2012). Ley 20.584: Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 24 de abril de 2012.

[4] Ministerio de Salud de Chile. (2022). Ley 21.541: Modifica la normativa que indica para autorizar a los prestadores de salud a efectuar atenciones mediante telemedicina. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 22 de diciembre de 2022.

[5] Ministerio de Salud de Chile. (2020). Decreto N°6: Reglamento sobre Acciones Vinculadas a la Atención de Salud Realizada a Distancia, Mediante el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Diario Oficial de la República de Chile, 25 de agosto de 2020.

claramente definidos para la gestión de la información, se pueden duplicar esfuerzos y contactos, lo que lleva a una falta de coordinación, pérdida de oportunidades para realizar programaciones más eficientes, insatisfacción de los usuarios, uso poco eficiente de los recursos y, en definitiva, una disminución en la capacidad para ofrecer un servicio de calidad.

De esta forma, este documento viene a contribuir directamente a los procesos descritos en la "Orientaciones Técnicas para el Proceso de Gestión de Agendas en Atenciones Ambulatorias de Especialidad 2020"[6], mejorando la eficiencia y la trazabilidad desde la referencia hasta la contrarreferencia, estandarizando y optimizando la gestión de contactabilidad con los usuarios. Esto incluye la creación de múltiples canales de comunicación y la estandarización de datos necesarios para la gestión de contactos, lo que, en conjunto, unifica definiciones técnicas ya existentes, promueve un lenguaje común y mejora sustancialmente la interacción con los usuarios. Estas mejoras facilitan la implementación de la contactabilidad en toda la Red Asistencial y responden a la necesidad de definir procesos y estándares para una gestión de contactos más eficiente en las diversas etapas del proceso de atención, contribuyendo directamente a la mejora continua de la red.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Instalar un modelo de contactabilidad permanente en el tiempo, dinámico y bidireccional con los usuarios que demandan una prestación de salud, fortaleciendo el vínculo y la atención continua de sus necesidades, contribuyendo a la continuidad de su atención y a la optimización de la gestión de la espera.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer un proceso estándar de contactabilidad que permita contribuir y mantener el vínculo con los usuarios durante la espera de una prestación de salud.
2. Desarrollar modelos de trabajo para la comunicación bidireccional continua con los usuarios a lo largo del proceso de referencia y contrarreferencia en red.
3. Optimizar la eficiencia de los procesos de contactabilidad, a través de la multicanalidad, para mejorar la gestión de las interacciones con los usuarios.
4. Mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones clínicas y administrativas a través de un sistema de contactabilidad multicanal integrado.

3. ALCANCE

Documento de carácter interno dirigido a profesionales, técnicos y administrativos encargados de gestionar procesos clínicos y administrativos, asociados a la contactabilidad y vinculación con usuarios, en el marco de prestaciones de salud en establecimientos de salud de mediana y alta complejidad, y a todos quienes necesitan aplicar la trazabilidad como parte del proceso de contactabilidad de los usuarios en el proceso de Referencia y Contrarreferencia en Red.

Este documento da alcance a las normas, procedimientos y protocolos nacionales y locales que involucran diferentes instancias de contactabilidad con los usuarios.

[6] Ministerio de Salud & Subsecretaría de Redes Asistenciales. (2020). Orientaciones técnicas para el proceso de gestión de agendas en atenciones ambulatorias de especialidad.

3.1. UTILIZACIÓN DE LA CONTACTABILIDAD MULTICANAL

La contactabilidad en salud debe ser un proceso flexible y evolutivo, diseñado para atender las necesidades concretas de las personas y de la Red Asistencial. Hoy en día, la contactabilidad trasciende los límites locales, permitiendo que se puedan realizar gestiones de contactabilidad centralizadas con impacto directo en el ámbito territorial. Mientras que la contactabilidad local favorece una gestión operativa y personalizada, una gestión centralizada nacional permite una optimización de recursos y la creación de planes de trabajo que abarquen mayores poblaciones. Si se logra que ambos procesos funcionen de manera armónica y coordinada, la gestión local se vería favorecida, aumentando la capacidad de vincular y conectar a los usuarios con las redes de atención interna, además de aprovechar toda la oferta del sistema a través de la ocupación de las redes externas de atención, logrando una mayor eficiencia y oportunidad de derivación.

Para lograr esta integración entre la gestión local y centralizada, y asegurar una comunicación efectiva, es fundamental adoptar un enfoque de multicanalidad en la contactabilidad.

La multicanalidad en la contactabilidad en salud es reconocida por mejorar la experiencia de las personas y la eficiencia del sistema de salud. Este enfoque se basa en garantizar la accesibilidad y coherencia de la información a través de múltiples canales de comunicación, asegurando que los usuarios puedan interactuar con el sistema de salud a través del canal que mejor se adapte a sus necesidades y circunstancias, ya sea presencial o digital. Además, la multicanalidad permite personalizar las interacciones y asegurar la continuidad del servicio, adaptando las comunicaciones y los servicios a las necesidades individuales de cada usuario.

Para favorecer lo anterior, es imprescindible que el sistema reconozca la diversidad de canales existentes, incluyendo aquellas actividades presenciales, así como opciones a distancia, tanto sincrónicas (llamadas telefónicas, mensajería instantánea, o videollamadas) como asincrónicas (correos electrónicos, mensajes de texto o plataformas web), dentro de los flujos de procesos. Este reconocimiento de múltiples canales impulsará a los establecimientos de salud a lograr ofrecer información clara y accesible a los usuarios, y cuando corresponda, a sus representantes o cuidadores, independientemente del canal utilizado. Asimismo, dado los avances tecnológicos, es posible incorporar nuevas estrategias de contactabilidad masiva que consideren la diversidad de ámbitos de comunicación, aumentando la posibilidad de mejorar la trazabilidad y gestión de nuestros usuarios.

La complementariedad de estrategias permitirá avanzar rápidamente en la implementación de un nuevo modelo de contactabilidad, lo que a su vez requiere establecer un estándar, reglas y flujos de información integrados, donde todos los canales de comunicación estén interconectados, permitiendo que dicho proceso sea transversal y acompañe al usuario a través de los diferentes niveles de atención a nivel nacional.

Para avanzar en la implementación de la contactabilidad multicanal, es importante reconocer los desafíos que deben abordarse. Los canales deben permitir la **retroalimentación efectiva** de los usuarios, garantizar la **verificación de la identidad,** el **registro de actividades** de contactabilidad realizados, que la **información proporcionada se ajuste** al canal de comunicación seleccionado y **mantener la confidencialidad y protección de los datos** en todos los medios utilizados, abordando la universalidad y adaptación a las necesidades comunicativas de los usuarios y las particularidades de cada contexto. Todos estos aspectos han sido considerados en las presentes Orientaciones Técnicas, definiendo además que es crucial la implementación de **portales de pacientes** como parte

de los procesos de atención, con el fin de optimizar e instalar una vía formal de comunicación e información continua con las personas (para mayor detalle revisar Anexo N°2: factores a considerar para evaluar un medio de contacto y Anexo N°3: Matriz de contactabilidad).

En dicho contexto, especial consideración se ha tenido con los sistemas de gestión telefónica, que, dada la dificultad del manejo de la información, los sistemas deben asegurar algunos requisitos mínimos de acción y registro:

1. **Trazabilidad completa:** Los sistemas deben permitir registrar cada interacción, incluyendo la identidad del ejecutor de la llamada, fecha y hora, número de intentos, protocolos utilizados y el grado de adherencia a estos.

   En los casos en los que se utilice un proveedor externo al establecimiento de salud, se requiere además la implementación de medios de verificación y validación de las llamadas telefónicas, tales como: grabaciones y/o transcripciones; garantizando la confidencialidad y seguridad de la información, la cual debe quedar resguardada por un mínimo de cinco años. La gestión de un acto administrativo interno utilizando un proveedor externo requiere de un mayor nivel de respaldo de la información para permitir la transparencia y validez de dicho acto.

2. **Protocolos estandarizados:** De la misma forma, es obligatorio el uso de guiones (script) y protocolos validados que aseguren el cumplimiento de la normativa técnica vigente.

Si bien, las presentes orientaciones buscan estandarizar un modelo que favorezca la trazabilidad de los usuarios a través de la contactabilidad, favoreciendo la integralidad y disponibilidad de datos, la implementación de una estrategia multicanal requiere instalar herramientas tecnológicas que permitan la completa integración de la información que se genere mediante otras fuentes de información (fichas, registros de espera, licencias, urgencias, etc.). A pesar de estas dificultades, se identifica que la multicanalidad se establece como un pilar fundamental en el futuro para garantizar una gestión eficiente de la atención al usuario, del uso de los recursos y capacidades del sistema, acorde a los desafíos de un proceso modernización que busca mejorar la satisfacción de nuestra población[7].

4. GLOSARIO Y CONCEPTOS RELEVANTES

- **Bidireccional:** en el contexto del sistema de salud, describe un tipo de comunicación que fluye en dos direcciones: desde los establecimientos de la Red Asistencial hacia los usuarios, y viceversa. Este concepto potencia la importancia de un intercambio equitativo de información, donde se proporciona información a los usuarios sobre los servicios de salud prestados, tratamientos y procesos, además de valorar e incorporar activamente la retroalimentación de las preguntas y las preocupaciones de los usuarios en la Red Asistencial[8].

- **Caracterización de usuario:** se refiere a un conjunto de características específicas de cada usuario que influyen en su experiencia durante el transcurso de su espera, permitiendo adaptar los servicios y estrategias de comunicación para brindar un mejor apoyo y atención personalizada durante el periodo de espera[9]. Estas características pueden incluir dimensiones sociodemográficas y aspectos relacionados con su estado de salud, como el tipo de enfermedad,

[7] Gobierno de Chile. (2022). Transformación digital del Estado al servicio de las personas. https://digital.gob.cl/transformacion-digital/

[8] Epstein, R. M., & Street Jr, R. L. (2011). The values and value of patient-centered care. Annals of Family Medicine, 9(2), 100-103. doi:10.1370/afm.1239.

[9] Gerteis, M., Edgman-Levitan, S., Daley, J., & Delbanco, T. L. (Eds.). (1993). Through the patient's eyes: Understanding and promoting patient-centered care. Jossey-Bass.

la gravedad de los síntomas y las necesidades de tratamiento. Además, el perfil construido puede abarcar aspectos psicológicos y emocionales, como el nivel de ansiedad, la capacidad de tolerancia a la espera y las expectativas sobre la atención.

- **Categorización:** también conocida como estratificación de riesgo, es el proceso de clasificar a los usuarios en diferentes niveles de riesgo basándose en una combinación de datos objetivos y subjetivos. Este proceso permite a los proveedores de salud identificar a los usuarios que necesitan una atención más intensiva y personalizada, optimizando así los recursos y mejorando los resultados de salud. Los factores considerados en la estratificación de riesgo incluyen factores clínicos, sociales y de comportamiento, como la presencia de condiciones crónicas, determinantes sociales de la salud, y el apoyo familiar y social disponible.

- **Citación efectiva:** se refiere a aquella situación en que se tomó contacto directo con el usuario o su representante para la asistencia a una atención de salud. Las inasistencias a citaciones efectivas pueden generar motivos de salidas de los registros de espera según se indica en las normas aplicables de GES y no GES.

- **Compromiso de Vinculación y Comunicación (COVICOM):** en las presentes orientaciones, se refiere al registro y constancia escrita de la información comunicada a los usuarios (o, cuando corresponda, a sus representantes o a las personas bajo cuyo cuidado se encuentren) por los establecimientos de salud. De esta manera, se representa al usuario su responsabilidad en la gestión de contacto y se hace partícipe de los procesos de comunicación, fomentando su compromiso por mantener información vigente para el sistema de salud.

- **Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD):** es el conjunto de variables necesarias para el registro de los datos administrativos y clínicos que se capturan en diferentes etapas del proceso de atención de los usuarios en la Red de Servicios de Salud, según normativa vigente N°820 sobre Estándares de Información de Salud[10] y sus actualizaciones.

- **Contactabilidad:** concepto que enmarca el conjunto de acciones de comunicación que se establecen entre el establecimiento de salud y el usuario, con el objetivo de ubicarlo, vincularlo y acompañarlo durante su tránsito por el sistema de salud[11]. Las acciones se agrupan en eventos de contactabilidad que dependerán del proceso de atención en que se encuentre el usuario, requiriendo la validación o actualización de sus datos de contacto en cada evento realizado.

- **Continuidad de la atención:** desde la perspectiva de los usuarios, corresponde al grado en que una serie de eventos del cuidado de la salud, son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo[12]. Desde la perspectiva de los sistemas de salud, corresponde a la realización permanente de las acciones y prestaciones que correspondan a la persona desde el punto de vista clínico, funcional y profesional.

- **Datos de contacto:** datos personales del usuario, o, cuando corresponda, los datos de su representante o la persona bajo cuyo cuidado se encuentre, incluyendo: nombre completo[13]

---

[10] Departamento de Estadística e Información de Salud. (2023). Norma técnica 820. Estándares de Información de Salud. En www.bcn.cl/leychile.

[11] Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). (2014). Improving communication between providers and patients in the outpatient setting. Communication Toolkit. Retrieved from AHRQ.

[12] Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., Starfield, B. H., Adair, C. E., & McKendry, R. (2003). Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ, 327(7425), 1219-1221. doi:10.1136/bmj.327.7425.1219.

[13] Ministerio de Salud. Gobierno de Chile & Subsecretaría de Redes Asistenciales. Departamento de Participación y Derechos Humanos. (s. f.). Orientaciones técnicas para actualizar o elaborar Protocolo de trato y registro para personas trans, en el marco de la Circular N° 21.

considerando tanto el nombre registral, asignado al nacer según el sexo biológico e inscrito en el Registro Civil, como el nombre social, con el que la persona se identifica basado en su identidad de género y desea ser reconocida e identificada en los instrumentos públicos y privados que acreditan su identidad), RUN, dirección del domicilio (calle, número de departamento o casa, comuna y ciudad), correo electrónico y números de teléfono (fijo y móvil) según corresponda.

- **Datos sensibles:** Aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos, vida sexual, y aquellos que la normativa vigente defina[14].

- **Egresos:** Los egresos del registro de lista de espera no GES corresponden a los distintos motivos por los que un caso puede ser removido, abarcando tanto salidas administrativas como clínicas, definidas por la Norma Técnica N°118 vigente.

- **Garantías Explícitas en Salud (GES):** Garantías Explícitas en Salud, las cuales constituyen derechos en materia de salud relativos al acceso, oportunidad, protección financiera y calidad[15].

- **Garantía exceptuada:** En el proceso de gestión de garantías GES, podrían existir causas atribuibles al beneficiario o por fuerza mayor derivadas de su estado de salud, en las cuales sea imposible entregar la prestación en el plazo establecido, dando lugar a una nueva gestión del caso. Solo podrán exceptuarse las garantías GES que se encuentren en estado vigente[16].

- **Garantía cerrada:** Término del vínculo del beneficiario con una o más garantías exigidas en un determinado problema de salud. Dado que un beneficiario puede presentar varias garantías al mismo tiempo, el cierre de una garantía no implica el cierre de caso o de otra garantía abierta. El caso puede permanecer abierto, pudiendo el beneficiario recibir otras prestaciones garantizadas del mismo problema de salud[17].

- **Gestión de la demanda:** Un proceso operativo que tiene como objetivo evaluar, proveer, influir y equilibrar la demanda de servicios de salud frente a la capacidad disponible (planificación). Este proceso implica la utilización de datos, análisis de tendencias, y la implementación de políticas y prácticas para optimizar el acceso y la utilización de recursos sanitarios.

- **Gestión de la espera:** En las presentes orientaciones, la gestión de la espera se centra en acompañar y mantener informados a los usuarios sobre los detalles clínicos y administrativos de su proceso de atención. Su propósito es identificar y mitigar riesgos potenciales, evaluar el estado de salud y responder a nuevas necesidades que surjan durante la espera[18].

---

[14] Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (1999). Ley 19.628: Sobre protección de la vida privada. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

[15] Decreto N° 72 del 2022, Aprueba Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías en Salud.

[16] Superintendencia de Salud, (2024) Compendio de Normas sobre Procedimientos Capítulo XI Procedimientos Relativos a las Garantías Explícitas en Salud.

[17] Aprueba normas de carácter técnico médico y administrativo para el cumplimiento de las garantías explícitas en salud de la Ley N°19.966, Decreto N° 53 del 2019.

[18] NHS England. (2019). Delivering same-sex accommodation. Improving patient experience.

- **Inteligencia Artificial (IA):** es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que, normalmente, requieren inteligencia humana. En las presentes orientaciones, la contactabilidad utilizando IA implica emplear sistemas automatizados y algoritmos para facilitar y mejorar la comunicación entre los establecimientos y los usuarios.

- **Lista de espera no GES:** conjunto de personas que en un momento dado se encuentran en espera de ser atendidas para una consulta de especialidad, para un procedimiento de apoyo diagnóstico y terapéutico o para una intervención quirúrgica electiva, solicitada por un profesional médico, odontólogo u otro profesional según corresponda, que no está incluida en GES (Norma Técnica del registro de demanda y tiempos de espera no GES).

- **Log:** en informática y tecnología de la información corresponde a un archivo o registro que contiene un historial de eventos, actividades o mensajes generados por un sistema, aplicación, servidor u otro dispositivo. Estos registros son útiles para el seguimiento, diagnóstico, solución de problemas y auditoría de eventos en un sistema informático[19].

- **Necesidad adicional de salud:** se refiere a aquellos requerimientos esenciales para ofrecer una atención integral y centrada en el usuario, pero que no están directamente vinculados a la atención clínica principal que espera recibir. Estas necesidades pueden incluir servicios de apoyo, asesoramiento o cualquier otra intervención que sean consideradas relevantes y que pueden aumentar el daño en la espera si no son consideradas[20].

- **Multicanalidad:** Hace referencia a utilizar todos los canales de comunicación que estén disponibles para interactuar con los usuarios. Dentro de los canales se encuentran: llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, mensajería instantánea, mensajería de texto, medios digitales, entre otros[21].

- **Prestación de salud:** corresponde a las acciones de salud necesarias que se requieren para el tratamiento o diagnóstico de una determinada patología. Lo anterior incluye atención de especialidad médica y odontológica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, intervenciones quirúrgicas menores y mayores.

- **Prestaciones complementarias:** se refieren a servicios adicionales relacionados con la atención principal del usuario. Estas prestaciones son requeridas para la preparación, así como derivadas del tratamiento principal, pudiendo ser ajustadas a las características del usuario. Pueden incluir, pero no se limitan a, servicios de diagnóstico, terapias de apoyo, rehabilitación y asesoramiento[22].

- **Registro de espera:** en las presentes orientaciones, se refiere al conjunto de datos que documentan y organizan la información de los usuarios que se encuentran aguardando una prestación de salud. Estos registros se dividen en dos categorías principales: los no GES, que incluyen a personas esperando una prestación de salud no cubierta por las Garantías Explícitas en Salud, y los GES, que abarcan a quienes requieren atención para condiciones cubiertas por estas garantías, con plazos máximos establecidos por ley.

---

[19] Stallings, W. (2017). Operating systems: internals and design principles. Pearson. doi:10.1109/MSP.2003.1159024

[20] Marmot, M., & Wilkinson, R. (2005). Social determinants of health. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof/9780198565895.001.0001.

[21] Health Affairs. (2019). Patient engagement strategies in healthcare. Health Affairs. https://www.healthaffairs.org/.

[22] Bodenheimer, T., Wagner, E. H., & Grumbach, K. (2002). Improving primary care for patients with chronic illness: The chronic care model, Part 2. JAMA, 288(15), 1909–1914. doi:10.1001/jama.288.15.1909.

- **Salida de registro de espera:** se refiere al proceso mediante el cual un caso es dado de baja de forma permanente en los registros de espera, implicando un cambio de estado que refleja la conclusión o resolución del motivo por el cual estaba en espera. Este proceso puede incluir egresos, excepciones o cierres de garantía, y se realiza mediante la verificación y validación adecuada de la información, asegurando que la finalización del proceso sea válido y documentado.

- **Script:** en las presentes orientaciones, se refiere al texto o guion diseñado para ser utilizado en cada evento de contactabilidad con los usuarios. Su objetivo principal es recopilar información detallada y relevante, utilizando un listado de preguntas estandarizadas, para caracterizar al usuario de forma integral y paulatina en cada contacto, identificando factores relevantes para su atención y manejo dentro del Sistema de Salud. Esta integración de información permite un adecuado seguimiento y gestión de la espera y atención.

- **Segmentación:** se refiere al proceso de separar a los usuarios en espera de atención en diferentes grupos según características específicas disponibles, facilitando así la priorización clínica, optimizando la asignación de recursos[23]. Este proceso permite a los sistemas de salud diseñar intervenciones más específicas y efectivas para cada grupo. La segmentación puede basarse en factores como la complejidad de comorbilidades, el comportamiento del usuario, y los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, la segmentación puede identificar subgrupos de usuarios con enfermedades crónicas complejas que requieren un manejo más intensivo y coordinado

- **Ubicable:** en las presentes orientaciones, se refiere a la capacidad de la Red Asistencial de ubicar y mantener actualizada la información de contacto del usuario a lo largo de su trayecto de atención. Esto se logra a través de diversas instancias de contactabilidad, asegurando así su conexión con el sistema de salud.

- **Vincular:** se refiere al proceso de establecer y mantener conexiones bidireccionales entre los usuarios y la Red Asistencial. Esto facilita la comunicación fluida de información relevante para el proceso de atención, implicando no solo informar a los usuarios y proporcionarles acceso a canales de comunicación, sino también incentivar y acoger la retroalimentación[24].

5. PROCESO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTACTABILIDAD

Un proceso óptimo de contactabilidad requiere de una comunicación bidireccional integral en todas las fases de la gestión clínica y administrativa, desde la preparación para recibir una prestación de salud hasta la contrarreferencia tras el alta. La información de contacto es transversal y relevante para todas las atenciones de salud que el usuario pueda requerir en la red de atención.

Dada la complejidad y dinamismo que ocurren durante la vinculación con los usuarios, abordaremos la contactabilidad considerando las instancias más representativas y críticas del recorrido por el sistema de salud. Es importante destacar que en muchas ocasiones la naturaleza de la contactabilidad y sus objetivos específicos, se definirán en el momento en que se establece el contacto con el usuario o las personas encargadas de su cuidado, por lo cual, es crítica la adecuada preparación de los equipos internos. Dado lo anterior, si bien en este documento se define el mínimo de las

[23] Kotler, P. (2000). Marketing Management. Millennium Edition. Prentice-Hall, Inc. doi:10.2307/1250103.

[24] O'Malley, A. S., & Cunningham, P. J. (2009). Patient experiences with coordination of care: The role of primary care as the usual source of care. Journal of General Internal Medicine, 24(3), 345-352. doi:10.1007/s11606-008-0878-5.

actividades a realizar, la adecuación del presente proceso estará vinculado a las realidades locales y operativas del día a día.

Es importante destacar que, aunque la contactabilidad se articula desde un acto administrativo, su propósito y alcance requieren una perspectiva clínica. Asegurar esto implica que quienes participen en el proceso posean formación en el ámbito de la salud, ya sea en un rol administrativo, técnico o profesional. Establecer una relación con usuarios que demandan una prestación requiere una combinación de competencias, incluidas habilidades emocionales, que permitan asesorar a los usuarios, acogerlos y brindar respuestas desde una mirada sanitaria. Además, se debe considerar que, si se identifica un riesgo grave a la salud del usuario en cualquier momento del proceso, el personal deberá indicar inmediatamente que la persona debe dirigirse al servicio de urgencia más cercano para ser atendido.

Estos requisitos son esenciales debido a la naturaleza técnica de las comunicaciones, que involucran temas como diagnósticos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos y la evolución de condiciones de salud. En el caso específico de los egresos y garantías exceptuadas o cerradas, este perfil cobra aún mayor relevancia, en donde el criterio clínico es fundamental para identificar situaciones en las que, a pesar de cumplir con criterios administrativos de salidas de registro, un usuario podría aún requerir alguna prestación. Además, desde la perspectiva de la satisfacción del usuario, la interacción con personal con formación en el ámbito de la salud marca una diferencia significativa en la calidad del servicio.

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GENERAL

El proceso de contactabilidad se ha estructurado en cuatro instancias distintas (subprocesos de contactabilidad), a fin de garantizar la continuidad de la atención, mejorar la experiencia del usuario, la gestión eficiente de recursos y la obtención de resultados de salud favorables. Estos subprocesos no son necesariamente secuenciales y cada uno debe permitir salidas de registro por la no contactabilidad según las normativas vigentes.

Etapa inicial: búsqueda ampliada de información de contacto

Antes de iniciar el proceso de vinculación y posterior a la evaluación de pertinencia clínica y administrativa de las interconsultas (SIC) u órdenes de atención (OA), se recomienda realizar una búsqueda ampliada de información de contacto en bases de datos de otras instituciones estatales, como el Registro Civil, BancoEstado, Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), policías, entre otras, respetando siempre los protocolos de confidencialidad y protección de datos. Esta etapa previa permite optimizar las posibilidades de localización de los usuarios, especialmente en casos de información desactualizada o incompleta. Asimismo, se sugiere explorar la participación de organizaciones comunitarias, principalmente en el proceso de gestión de la no contactabilidad, las cuales pueden actuar como facilitadoras en la localización de usuarios, particularmente en contextos de vulnerabilidad social o en zonas de difícil acceso. Esta colaboración con actores comunitarios debe realizarse bajo estrictos criterios de confidencialidad y respeto por la privacidad de los usuarios.

Una vez recopilada la información de contacto, se procede a las siguientes etapas del proceso de contactabilidad:

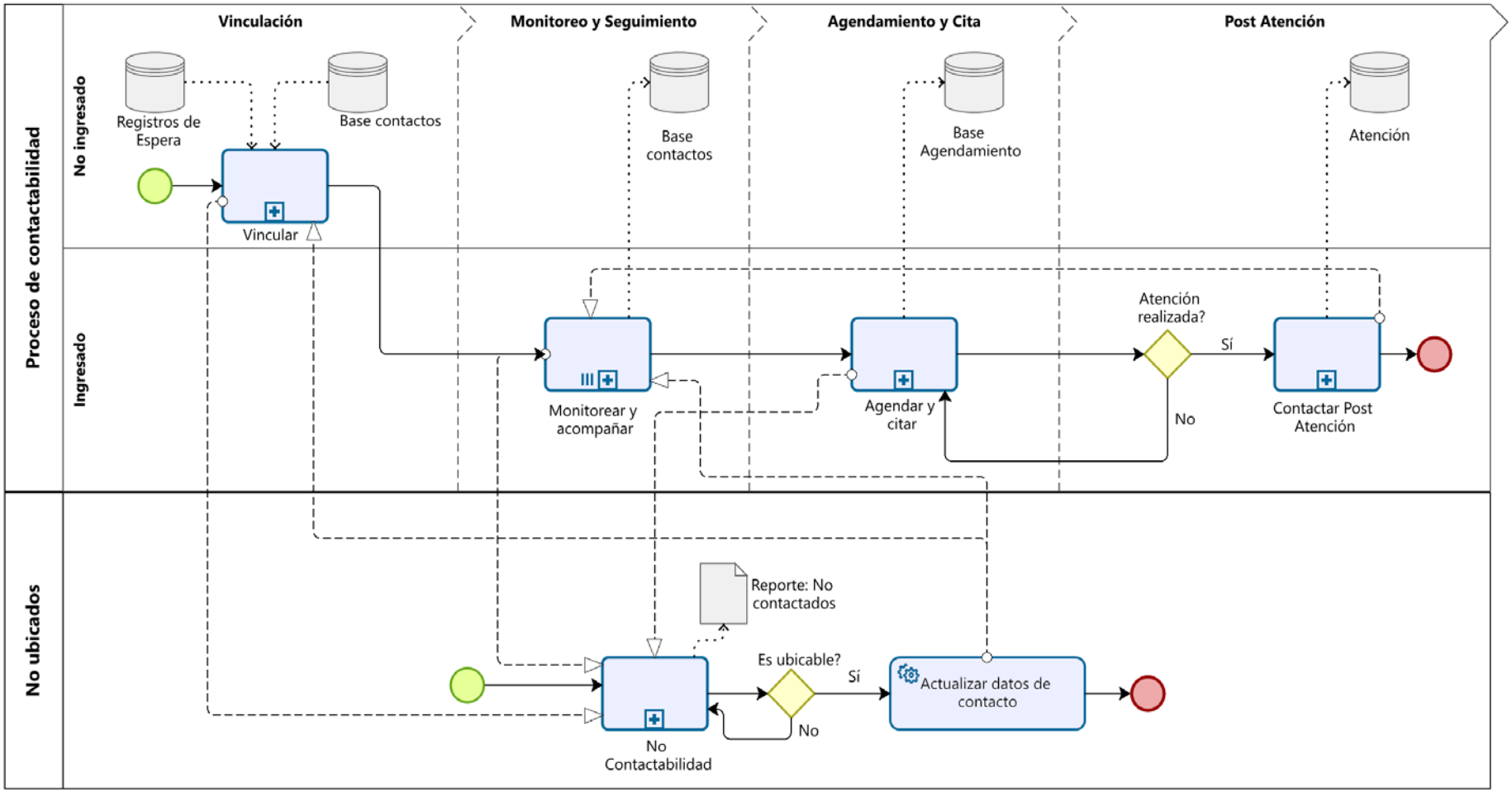
1. **Vinculación:** los usuarios que se encuentran en espera de una prestación de salud ingresarán a un proceso de contactabilidad inicial, con el objetivo de vincular al usuario con la Red Asistencial. Esto permite optimizar el uso de los recursos al mantener un sistema de registro

de espera de prestaciones actualizado y egresar o exceptuar o cerrar las garantías de los usuarios que no requieran la prestación o a los que no pueda otorgarse la prestación por alguna de las razones previstas en estas orientaciones facilitando así la gestión de usuarios que estén disponibles para iniciar el proceso de atención. Los usuarios que no lograron ser ubicados seguirán un proceso de gestión de la no contactabilidad en base a las presentes orientaciones y normativa vigente.

2. **Monitoreo y seguimiento:** de aquellos usuarios vinculados, se lleva a cabo el seguimiento y monitoreo durante su espera, donde se busca mantener una comunicación continua y bidireccional para brindar apoyo, resolver dudas, recopilar y proporcionar información relevante sobre su prestación de salud. Este seguimiento garantiza que el usuario se sienta acompañado, que se detecten riesgos de daño asociados a la espera y que sus necesidades sean atendidas de manera integral. En esta etapa corresponde llevar a cabo la gestión activa de casos, por lo que se incorpora la realización del subproceso de gestión de la espera, el cual busca la preparación de la persona para recibir su atención.
3. **Agendamiento y cita:** corresponde a la etapa en que se coordina la realización de las prestaciones requeridas por los usuarios. Esta fase requiere la gestión de los recursos disponibles para asegurar la eficiencia del sistema, la equidad en la oportunidad y la calidad de la atención. Si la persona no se presenta (NSP), se continúa con el flujo de contactabilidad para volver a agendar la hora o se realiza el proceso de egreso o excepción o cierre de garantías por inasistencias reiteradas de acuerdo con la OOTT para el Proceso de Gestión de Agendas y Citas6 y Normativas de las Garantías Explícitas en Salud (GES) vigentes.
4. **Post atención:** tras recibir una prestación de salud, se inicia la fase de contactabilidad post atención, donde se puede continuar la comunicación para resolver dudas adicionales, brindar seguimiento a tratamientos o procedimientos prescritos, con la posibilidad de evaluar la satisfacción del usuario con el servicio recibido. Esta etapa es crucial para garantizar una atención continua, potenciar los resultados sanitarios y una experiencia positiva para el usuario en todo su proceso de atención en salud.

De forma transversal, es fundamental recopilar la información necesaria en cada interacción para avanzar en los procesos administrativos y asistenciales pertinentes, destacando la importancia de mantener actualizados los datos de contacto de los usuarios, como teléfonos, correo electrónico y domicilio. Además, se pueden incorporar escalas de evaluación a los scripts, incluyendo variables que permitan caracterizar a las personas, y recopilar información útil que facilite los procesos de agendamiento y atención posterior, adaptándose a la prestación en espera y la especialidad correspondiente. **Toda la información generada durante este proceso de contactabilidad debe permitir la integración con los sistemas que lo requieran y con los distintos niveles de atención, favoreciendo la continuidad de la atención.** Para facilitar este proceso en los establecimientos de mediana y alta resolutividad, es relevante que los usuarios conozcan los procesos de la red asistencial, entregándoles información en los primeros niveles de atención durante su derivación.

IMAGEN N°1: FLUJO GENERAL DE LA CONTACTABILIDAD[25]



[25] Los símbolos utilizados en los diagramas de flujo siguen la notación estándar de Bizagi. Para una referencia detallada de los signos y su significado, consulta la documentación oficial en: https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/bpmn_shapes.htm#top.

5.2. CONTACTABILIDAD DE VINCULACIÓN (INICIAL)

Este primer contacto marca el inicio del vínculo bidireccional con la persona que demanda una prestación en el sistema de salud, y puede llegar a ser gatillado en todo el viaje del usuario por el sistema de salud. En general, se considera como fase inicial del proceso de contactabilidad, durante la cual se proporcionan al usuario detalles sobre los canales disponibles de comunicación y se entrega información general sobre el proceso que debe seguir.

TABLA N°1: FICHA DEL SUBPROCESO DE CONTACTABILIDAD DE VINCULACIÓN

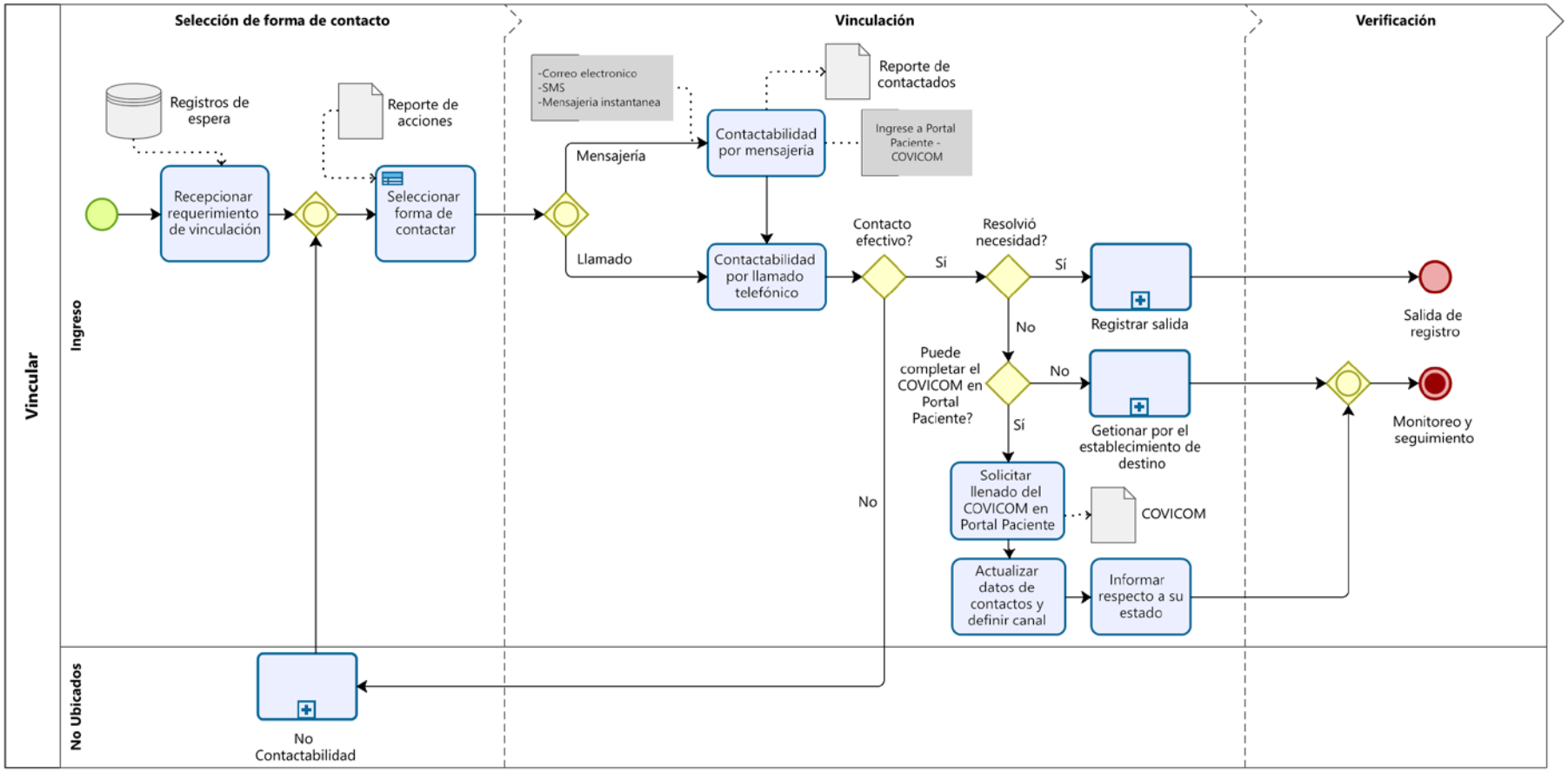
CONTACTABILIDAD DE VINCULACIÓN	
Responsable	Para el evento de vinculación, se deben utilizar preferentemente medios de contacto automatizados y masivos, sin la necesidad de recurso humano. En el caso de no contar con medios automatizados, la vinculación puede ser realizada por un equipo administrativo con formación en el ámbito de la salud, o personal técnico o profesional.
Objetivo	Mantener un registro actualizado de usuarios en espera para prestaciones de salud con datos de contactabilidad vigentes. La vinculación con el usuario es una etapa esencial en el proceso integral de atención, permitiendo una identificación precisa de quienes estén disponibles para ser atendidos en las siguientes instancias de contactabilidad, facilitando la gestión de casos durante la espera. En este primer contacto, el mensaje transmitido debe ser claro, informando los canales de comunicación con el establecimiento y solicitando información para comprender el estado general del usuario.
Entradas	Se implementa de forma prioritaria posterior a que el usuario sea referido para recibir una prestación de salud en establecimientos de mediana o mayor resolutividad a partir del proceso de referencia, y la generación de interconsultas u órdenes de atención. Considerando que el trayecto de los usuarios para recibir una prestación de salud no está estructurado linealmente, debido a las diversas puertas de entradas del sistema, la vinculación puede ocurrir como inicio para los diferentes eventos, ya sea para monitorear el estado de salud o en el momento de realizar la agenda, entre otros. Por lo tanto, la contactabilidad inicial y vinculación se instala en cualquier momento del trayecto del usuario, el script básico de vinculación, que se replica en cada instancia. Sin embargo, se define esta contactabilidad de vinculación como un evento independiente y no sujeta a otros procesos de contactabilidad, permitiendo asegurar planes masivos de contactabilidad y mantener un registro de espera de prestaciones y datos de contacto de los usuarios actualizados en los establecimientos. Dicha independencia permite establecer unidades de atención telefónica ya sea internos o externos a los establecimientos, que aseguren la existencia de usuarios vinculables para recibir atención.
Vías de contactabilidad	La selección del método de contacto debe basarse en las características de la persona y la disponibilidad de los medios en el establecimiento, de los cuales se encuentran los medios para entrega de información y acercamiento inicial (correos electrónicos, mensajes de texto y mensajería instantánea) y las llamadas telefónicas. Se debe incluir el enlace al portal de paciente, a fin de permitir una retroalimentación constante en el tiempo. En caso de no ser posible vincular al usuario por los medios descritos, se aplican estrategias más segmentadas y de mayor costo (visitas domiciliarias, cartas certificadas, etc.) según el flujo del capítulo 8: “Gestión de la No Contactabilidad”.

Salidas	Usuario efectivamente vinculado con requerimientos de prestación: Independiente de la priorización dada, todos los usuarios continuarán a las instancias de monitoreo y seguimiento o agendas y citas, según la categorización del tipo de usuario.	
	Usuario contactado que no requiere la prestación: egreso del caso, excepción o cierre de garantía, lo que permite mantener un registro de espera para prestaciones de salud actualizada y vigente, en concordancia con la aplicación de la normativa vigente, y lo señalado en el capítulo 7: "Salidas de sistemas de registros de espera para prestaciones de salud vía gestión de contactabilidad" de las presentes OOTT.	
	Usuario no contactado: revisar capítulo 8: "Gestión de la No Contactabilidad" de las presentes OOTT.	
Registros	El registro del proceso de contactabilidad deberá incluir los siguientes antecedentes para permitir la verificación y auditoría del proceso: (a) datos del receptor del contacto, ya sea el usuario del registro de espera (RUN y dv, nombres, apellidos, domicilio, teléfonos y correo electrónico) o su representante (RUN y dv, nombres, apellidos, relación con el usuario, teléfonos y correo electrónico); (b) Información sobre el canal de contacto utilizado (modalidad de captura, fecha y hora del contacto); (c) requerimiento de la prestación en espera; (d) motivo del contacto (vinculación inicial); (e) cuando corresponda, la descripción de los motivos del usuario para el no requerimiento de la atención que validen una causal de egreso, excepción o cierre de garantía; (f) detalles del contacto efectuado y confirmación de comprensión de la información entregada por el usuario o su representante; e (g) información del responsable del respaldo (nombre, cargo y unidad en la que se desempeña".	
Participantes	Centros de llamados (preferentemente)	
	Unidades de gestión de admisión	
	Unidades de gestión de la demanda	
	Unidades de soporte para la gestión del contacto multicanal	
	Todas aquellas unidades que requieran gestionar procesos de vinculación entre el establecimiento de salud y el usuario	
Actividades del subproceso de Vinculación		
Actividades	**Tarea**	**Descripción**
	Recepcionar requerimiento de vinculación	Recepción y procesamiento de la solicitud inicial para establecer contacto con un usuario que haya sido referido para recibir una prestación de salud en establecimientos de mediana o mayor resolutividad a partir del proceso de referencia, y la generación de interconsultas u órdenes de atención.

	Seleccionar forma de contactar	Determinar el método más adecuado multicanal para establecer comunicación con el usuario, y elegir el método más apropiado y costo eficiente, según las características de acceso a los canales comunicacionales de los usuarios, que pueden incluir correo electrónico, mensaje de texto, mensajería instantánea, llamada telefónica, entre otros. El proceso comienza con una revisión detallada de la información disponible de la persona, incluyendo las preferencias de contacto e historial de intentos contactos previos, si existen. A continuación se diseña una estrategia de ejecución del proceso de contacto, considerando las características personales del usuario y medios tecnológicos disponibles tanto en el establecimiento como aquellos con los que cuenta el usuario. Una vez realizado esto se ingresa la información en la planificación de las tareas de contactabilidad.
	Realizar contactabilidad por mensajería multicanal	Realizar la contactabilidad mediante mensajería (correo electrónico, mensaje de texto o mensajería instantánea) utilizando scripts predefinidos. Esta actividad permite confirmar la información de contacto y entregar información general a la persona, sin revelar datos sensibles. Mediante un mensaje automatizado, se solicita a la persona actualizar su información, en el portal paciente, indicándole los pasos que debe seguir para ello. 1. Si el usuario responde a la comunicación inicial, se debe verificar si la persona actualizó su información en el portal paciente y registrar la vigencia del número telefónico. 2. Si el usuario no actualiza su información, no responde o se determinó no utilizar la mensajería de forma inicial, pasar a la contactabilidad por llamado telefónico.
	Realizar contactabilidad por llamado telefónico	Establecer contacto con el usuario a través de llamados telefónicos según script definido. El objetivo de la llamada es establecer un vínculo bidireccional con el usuarios, actualizando su información de contacto y verificando la vigencia de la necesidad de salud.
	Identificar la persistencia de la necesidad de salud	Evaluar si la necesidad de salud del usuario persiste y mantiene su vigencia, lo cual determina la continuidad del proceso de atención. En el caso de que haya resuelto su necesidad, se procede a registrar la salida del registro.
	Solicitar llenado del Compromiso de Vinculación y Comunicación (COVICOM) en portal paciente	Consultar al usuario si puede completar el COVICOM en línea, en el portal paciente y, en el caso que señale que no es posible, solicitar autorización para llenarlo en su nombre por el funcionario. En este caso, se deberá digitalizar y agregar el documento al portal paciente.

	Actualizar datos de contactos y definir canales de comunicación	Realizar la verificación y actualización de datos de contacto: verificar si los datos de contacto del usuario (teléfonos, correo electrónico, dirección) se encuentren actualizados y correctos. En caso de ser necesario, se procede a actualizar la información. La actualización de datos de contacto debe ser regular, al menos una vez cada 6 meses, incluyendo aquella información asociada a números telefónicos, correo electrónico y dirección; conforme a la Norma Técnica Nº 820 y sus actualizaciones. • Verificar la disponibilidad para recibir la prestación: evaluar si el usuario tiene la disponibilidad y las condiciones necesarias para recibir la prestación de salud solicitada. • Consultar y registrar el canal de contacto bidireccional más adecuado para mantener un contacto efectivo entre el usuario y el establecimiento de Salud. • Consultar y consignar las preferencias y necesidades comunicativas del usuario (idioma, diversidad cultural, capacidades sensoriales, etc).
	Informar al usuario respecto a su estado de espera y pesquisar necesidades	Informar a la persona sobre las fases de su proceso de espera: • Proporcionar al usuario información detallada disponible sobre las diferentes fases o etapas de su proceso de espera para recibir la prestación de salud, fortaleciendo la relación entre el usuario y el sistema de atención. • Resolver dudas del usuario: Atender y resolver dudas que la persona pueda tener en cualquier momento del proceso de atención. • Pesquisar requerimientos de prestaciones complementarias y/o necesidades adicionales. • Identificar y recopilar los requerimientos del usuario en cuanto a prestaciones complementarias o necesidades adicionales en relación con su prestación de salud en espera, según indicaciones.
Herramienta	Script de contactos disponibles para la vinculación	Aplicar los Scripts N°1 para estandarizar la comunicación (anexo N°4), según el canal utilizado: • Script 1.1: correo electrónico IA. • Script 1.2: correo electrónico gestionado por una persona. • Script 1.3: mensajería instantánea IA. • Script 1.4: mensajería instantánea gestionada por una persona. • Script 1.5: mensajería de texto (SMS). • Script 1.6: llamado telefónico automatizado por IA. • Script 1.7: llamado telefónico gestionado por una persona. • Script 1.8: portal paciente.

IMAGEN N°2: FLUJO DEL SUBPROCESO DE CONTACTABILIDAD DE VINCULACIÓN



5.3. CONTACTABILIDAD DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Es crucial que para hacer eficiente esta fase se disponga de un universo de usuarios ya vinculados bidireccionalmente y con información actualizada sobre su estado para recibir la atención. Se centra en monitorizar y realizar un seguimiento activo del usuario hasta el subproceso de contactabilidad de agendas y citas. A lo largo de esta etapa, se recopilan datos esenciales para caracterizar al usuario y establecer un plan de gestión de la espera personalizado, dependiendo de la prestación a recibir y la especialidad.

Para lograr lo anterior, se requiere incorporar un script específico que permita la construcción de una caracterización del estado global de salud del usuario, considerando las siguientes dimensiones:

1. **Clínica:** enfoque en el estado de salud del usuario, con énfasis en la multimorbilidad y su manejo, especialmente en personas con múltiples condiciones crónicas (G3), según la Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas con Enfoque de Riesgo (ECICEP)[26].
2. **Autoeficacia:** habilidad del usuario para gestionar su salud, incluyendo el seguimiento de tratamientos y la adopción de estilos de vida saludables.
3. **Red de Apoyo:** conjunto de personas y recursos disponibles para apoyar al usuario en el manejo y afrontamiento de su condición de salud.
4. **Psicosocial:** conjunto de factores sociales y emocionales que afectan la experiencia del usuario y su bienestar mientras espera una prestación de salud.
5. **Tiempos de Espera:** periodo que la persona lleva esperando desde que es derivada a una atención de salud.

La metodología y la aplicación de variables para caracterizar a los usuarios deben alinearse con la necesidad de construir perfiles de usuarios según las definiciones técnicas propias de las especialidades y mejorar los procesos de priorización. Si bien esta OOTT permite establecer un marco de trabajo general, profundizar en la implementación de un proceso de monitoreo puede requerir integrar más información y desarrollar protocolos para cada especialidad, incluyendo directrices sobre cómo medir y evaluar cada dimensión mencionada.

TABLA N°2: FICHA DEL SUBPROCESO DE CONTACTABILIDAD DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

CONTACTABILIDAD DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	
Responsable	Personal técnico o profesional.
Objetivo	Realizar el monitoreo y seguimiento activo de los usuarios que demandan una prestación de salud, ya vinculados con el sistema de salud y que cuentan con información actualizada sobre su proceso de atención. Este subproceso previo a la atención se centra en preparar al usuario para la atención, informándole sobre los canales de comunicación bidireccionales futuros. Durante esta etapa se recopila una mayor cantidad de datos para perfilar al usuario y propiciar la toma de decisiones posteriores, para favorecer una mejor priorización, mediante la aplicación de scripts específicos para evaluar su estado de salud y gestión de su espera.

[26] Ministerio de Salud (2020). Estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en contexto de multimorbilidad (1ª ed.). División de Atención Primaria, División de Prevención y Control de Enfermedades.

Entradas	Su implementación incluye a usuarios ya vinculados, que aún requieran la prestación. A fin de optimizar las capacidades internas, se debe incluir un conjunto de características específicas basadas en las dimensiones señaladas, que permitan abordar universos de casos más segmentados, y que incluyan elementos de priorización que sean definidos (ejemplo: antigüedad, estratificación, edad, etc.)
Vías de contactabilidad	Las vías de contactabilidad preferentes en principio serán las señaladas por el usuario como el medio bidireccional más eficiente que se encuentre disponible en el establecimiento. En caso de no ser posible vincular al usuario por los medios descritos, se aplican estrategias más segmentadas y de mayor costo (visitas domiciliarias, cartas certificadas, etc.) según el flujo del capítulo 8: "Gestión de la No Contactabilidad".
Salidas	Usuario contactado con su caracterización actualizada para la gestión de su prestación de salud, informado sobre su estado y tiempo probable de espera o plazos garantizados por ley y bajo un plan de gestión de la espera según definiciones de riesgo identificadas.
	Usuario contactado que no requiere la prestación: Egreso del caso, excepción o cierre de garantía, lo que permite mantener un registro de espera para prestaciones de salud actualizada y vigente, en concordancia con la aplicación de la normativa vigente, y lo señalado en el capítulo 7: "Salidas de sistemas de registros de espera para prestaciones de salud vía gestión de contactabilidad" de las presentes OOTT.
	Usuario no contactado: revisar capítulo 8: "Gestión de la No Contactabilidad" de las presentes OOTT.
Registros	El registro del proceso de contactabilidad deberá incluir los siguientes antecedentes para permitir la verificación y auditoría del proceso: (a) datos del receptor del contacto, ya sea el usuario del registro de espera (RUN y dv, nombres, apellidos, domicilio, teléfonos y correo electrónico) o su representante (RUN y dv, nombres, apellidos, relación con el usuario, teléfonos y correo electrónico); (b) información sobre el canal de contacto utilizado (modalidad de captura, fecha y hora del contacto); (c) requerimiento de la prestación en espera; (d) motivo del contacto (monitoreo y seguimiento); (e) cuando corresponda, la descripción de los motivos del usuario para el no requerimiento de la atención que validen una causal de egreso, excepción o cierre de garantía; (f) detalles del contacto efectuado y confirmación de comprensión de la información entregada por el usuario o su representante; e (g) información del responsable del respaldo (nombre, cargo y unidad en la que se desempeña.
Participantes	Unidades de gestión de casos (navegadores, gestores GES, otros gestores)
	Centros de llamados
	Unidades de gestión de la demanda
	Unidades de soporte para la gestión del contacto multicanal
	Todas aquellas unidades que requieran gestionar y preparar usuarios para recibir una prestación de salud

Actividades del subproceso de Monitoreo y Seguimiento		
Actividades	**Tarea**	**Descripción**
	Subproceso de gestión de la espera del usuario	Este subproceso se aborda desde el análisis clínico administrativo del proceso ambulatorio de especialidad. Se describe **en términos generales, como una etapa de organización de información inicial, sin que sea parte de la gestión de contactabilidad propiamente tal.** En forma ideal, este subproceso debería contener las siguientes actividades: 1. Inicio y estratificación: el subproceso de gestión de la espera inicia con la recepción de solicitud de atención, para posteriormente verificar si la persona se encuentra categorizada por algún nivel de riesgo y prioridad: - Si está estratificada: se categoriza/prioriza según riesgo. - Si no está estratificada: se segmenta según características disponibles. - Es fundamental recopilar y analizar las diversas características de los usuarios con el fin de crear categorías que permitan su estratificación, lo cual facilitará una priorización efectiva. Durante el proceso de contactabilidad, se debe procurar la recolección integral de información, aprovechando todas las fuentes disponibles para obtener una visión completa del usuario. 2. Evaluar y asignar un Plan de Gestión de la Espera personalizado: lo anterior debe ser protocolizado según definiciones locales, considerando estratificación de riesgo del usuario, complejidad del caso, preferencias de comunicación y acciones de acompañamiento. De forma adicional se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse a los scripts dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, autoeficacia, etc.). En los casos menos complejos podrán considerarse medios más masivos y de carácter más automatizado, a fin de mantener una comunicación sostenida en el tiempo. Es importante reforzar que el monitoreo menos frecuente debe ser a lo menos cada 6 meses. 3. Gestionar requerimiento: realizar la revisión de criterios requeridos para la prestación en espera, verificando que el usuario cumpla con los criterios y prerrequisitos específicos para cada prestación según definiciones de protocolos de referencia y contrarreferencia locales y según orientaciones técnicas definidas, necesarios para recibir la atención de forma eficiente. De acuerdo a la información obtenida se sugiere generar las coordinaciones que permitan gestionar los requerimientos que permitan preparar al usuario para su atención de acuerdo a las definiciones y directrices de la especialidad. 4. Confirmar y asignar el método de contacto: el cual puede ser mediante mensajería (correo electrónico, mensajería instantánea, SMS) o por llamado telefónico, considerando capacidad local y preferencias del usuario. Este subproceso genera un reporte de personas a contactar.

	Realizar el seguimiento y monitoreo en plazos definidos, mediante mensajería y/o llamado telefónico	Una vez generados los componentes de organización de la demanda para la contactabilidad, se puede dar ejecución al seguimiento y monitoreo personalizado de los usuarios ingresados a un registro de espera mediante mensajería y/o llamado telefónico, dependiendo de lo definido en el Plan de Gestión de la Espera. Esta actividad implica la actualización continua de los planes de gestión de la espera adaptados a cada persona, estableciendo frecuencias de contacto en grupos segmentados, según plazos establecidos relacionados a los planes de gestión de la espera. Un plan de monitoreo intenso requerirá a lo menos contactabilidad mensual, siempre considerando la preferencia que entregue el usuario y aceptación de dicho seguimiento.
	Identificar la persistencia de la necesidad de salud	En cada contacto se debe evaluar si la necesidad de salud del usuario persiste y mantiene su vigencia, lo cual determina la continuidad del proceso de atención.
	Realizar la verificación y actualización de datos de contacto	En cada contacto se debe verificar si los datos de contacto del usuario (teléfonos, correo electrónico, dirección) se encuentren actualizados y correctos. En caso de ser necesario, se procede a actualizar la información.
	Verificar la existencia del COVICOM	Verificar la aplicación previa del COVICOM, y aplicarlo en el caso de que no exista.
	Verificar la disponibilidad para recibir la prestación	Evaluar si el usuario tiene la disponibilidad y las condiciones necesarias para recibir la prestación de salud solicitada.
	Determinar los canales de comunicación bidireccionales más apropiados	Selección y registro de los canales de comunicación más adecuados para mantener una interacción bidireccional efectiva entre el usuario y el establecimiento en un proceso de monitoreo, considerado tanto las preferencias del usuario como la capacidad del establecimiento.
	Pesquisar requerimientos de prestaciones complementarias y/o necesidades adicionales	Identificar y recopilar los requerimientos del usuario en cuanto a prestaciones complementarias o necesidades adicionales relacionadas a su prestación en espera, según indicaciones.
	Informar a los usuarios detalles sobre las fases de su proceso de espera	Proporcionar al usuario información detallada disponible sobre las diferentes fases o etapas de su proceso de espera para recibir la prestación de salud.
	Realizar el seguimiento y monitoreo en plazos definidos	Ejecutar el seguimiento y monitoreo personalizado de los usuarios ingresados a un registro de espera, mediante la segmentación de casos considerando la estratificación de riesgo. Esta actividad implica la actualización continua de los planes de gestión de la espera adaptados a cada persona, estableciendo frecuencias de contacto en grupos segmentados, según plazos establecidos relacionados a los planes de gestión de la espera. Un plan de monitoreo intenso requerirá a lo menos contactabilidad mensual.
	Resolver dudas del usuario	Atender y resolver dudas que la persona pueda tener en cualquier momento del proceso de espera, asegurando un estándar de calidad de entrega de información clara y oportuna sobre su proceso de atención.

Herramienta	Script de contactos disponibles para el monitoreo y seguimiento	Aplicar los Scripts N°2 para estandarizar la comunicación (anexo N°4), según el canal utilizado: - Script 2.0: correo electrónico gestionado por una persona. - Script 2.1: mensajería instantánea gestionada por una persona. - Script 2.2: mensajería de texto (SMS). - Script 2.3: llamado telefónico gestionado por una persona. - Script 2.4: portal paciente.

IMAGEN N°3.1: FLUJO DEL SUBPROCESO DE CONTACTABILIDAD DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

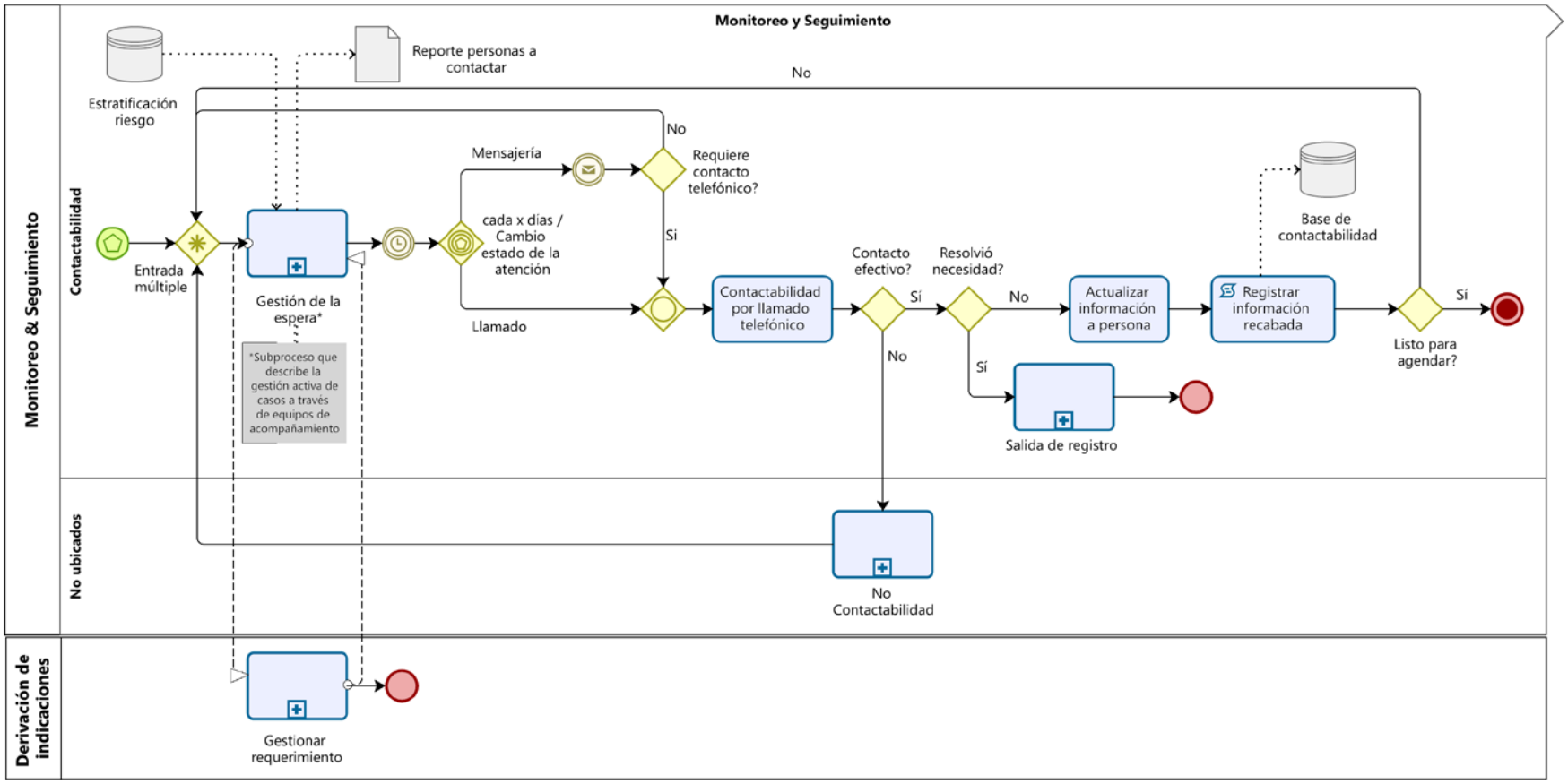
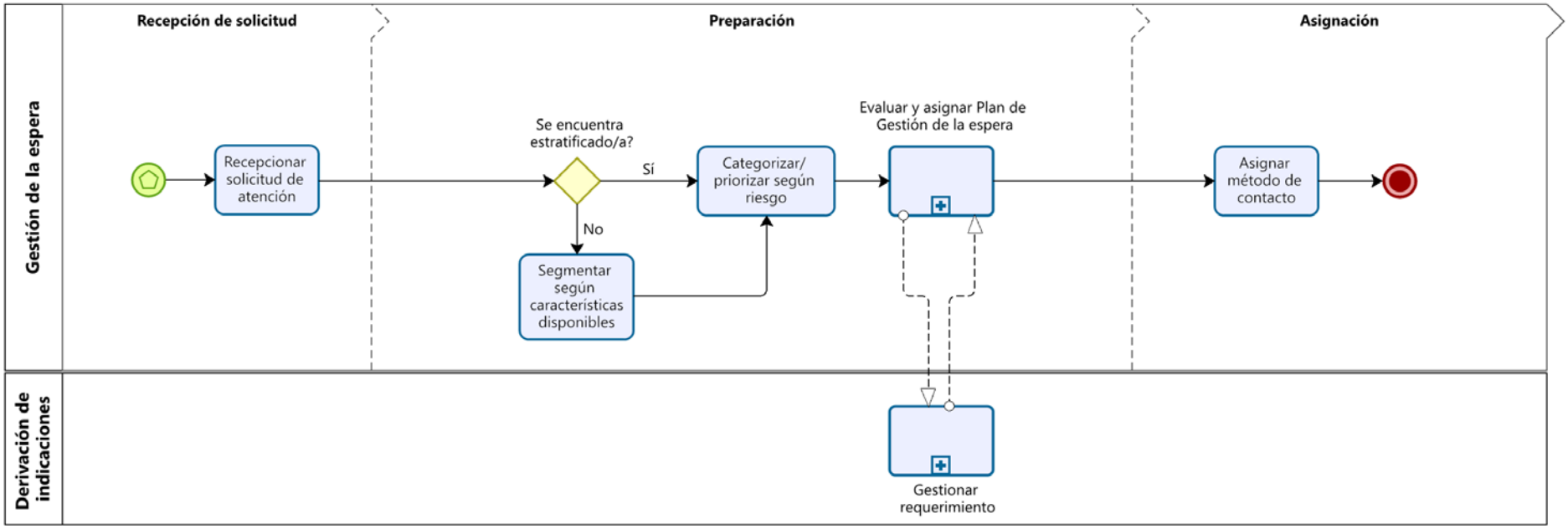


IMAGEN N°3.2: FLUJO DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LA ESPERA



5.4. CONTACTABILIDAD PARA GESTIÓN DE CITA Y AGENDA

La contactabilidad para la gestión de citas y agenda engloba diversas estrategias destinadas a garantizar que los usuarios reciban una prestación de salud de manera eficiente y con criterios de equidad en la oportunidad. De esta forma, esta instancia de contactabilidad tiene las siguientes características:

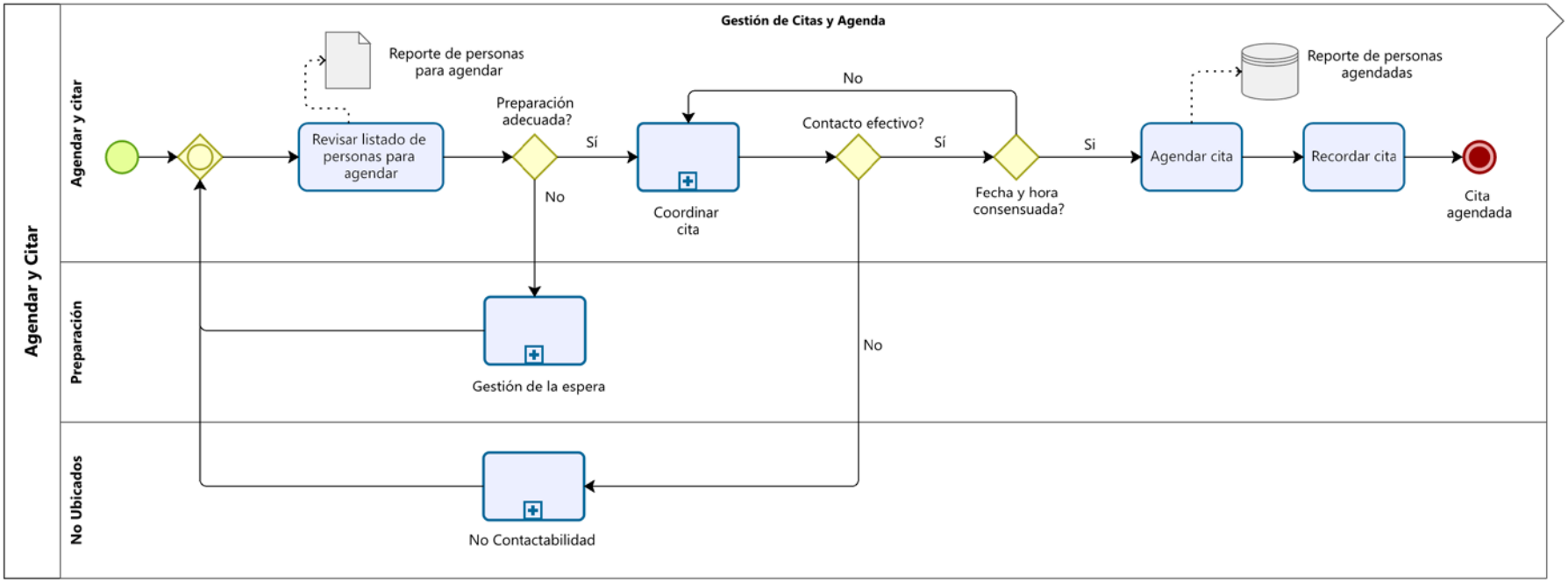
TABLA N°3: FICHA DEL SUBPROCESO DE CONTACTABILIDAD DE GESTIÓN DE CITA Y AGENDA

CONTACTABILIDAD DE GESTIÓN DE CITA Y AGENDA	
Responsable	Equipo administrativo con formación en el ámbito de salud, técnico o profesional. Para la confirmación de citas, se deben utilizar preferentemente medios informáticos automatizados y masivos, sin la necesidad de recurso humano.
Objetivo	Asegurar una coordinación efectiva de citas y agendas, gestionando adecuadamente los recursos disponibles y aplicando medidas para garantizar la asistencia a las citas programadas, permitiendo una atención eficiente y oportuna para los usuarios. En este evento de contactabilidad se requiere asegurar lo siguiente: • Coordinación efectiva de citas y agendas: consensuar la cita de atención y garantizar una atención oportuna y de calidad al usuario. • Gestión eficiente de tiempos y recursos: optimizar la utilización de los recursos disponibles, propiciando información para permitir un proceso adecuado de priorización local. • Reprogramación de citas: seguir el flujo de contacto para reprogramar citas en caso de inasistencias, bloqueos de agendas, etc. • Proceso de egreso o excepción o cierre de garantía: en el caso de inasistencias reiteradas, aplicar el proceso de egreso o excepción o cierre de garantía GES, según la normativa vigente.
Entradas	Su realización incluye a usuarios priorizados de acuerdo con su estratificación de riesgo disponible. Además, cuando corresponda, se consideran las características establecidas para la gestión de la espera.
Vías de contactabilidad	Para el proceso de agendamiento las vías de contactabilidad preferentes deben permitir una comunicación bidireccional, tales como llamadas telefónicas y mensajería instantánea de forma directa incorporando el portal paciente. Para el proceso de confirmación de citas, de forma preferente, se consideran vías que nos permitan contar con una comunicación masiva, a través de mensajería instantánea o correo electrónico, considerando la preferencia señalada por el usuario.
Salidas	Usuario contactado y con la asignación de la fecha y hora de su prestación de salud consensuada y agendada.
	Usuario contactado que no requiere la prestación: Egreso del caso, excepción o cierre de garantía, lo que permite mantener un registro de espera para prestaciones de salud actualizada y vigente, en concordancia con la aplicación de la normativa vigente, y lo señalado en el capítulo 7: "Salidas de sistemas de registros de espera para prestaciones de salud vía gestión de contactabilidad" de las presentes OOTT.
	Usuario no contactado: revisar capítulo 8: "Gestión de la No Contactabilidad" de las presentes OOTT.

Registros	El registro del proceso de contactabilidad deberá incluir los siguientes antecedentes para permitir la verificación y auditoría del proceso: (a) datos del receptor del contacto, ya sea el usuario del registro de espera (RUN y dv, nombres, apellidos, domicilio, teléfonos y correo electrónico) o su representante (RUN y dv, nombres, apellidos, relación con el usuario, teléfonos y correo electrónico); (b) información sobre el canal de contacto utilizado (modalidad de captura, fecha y hora del contacto); (c) requerimiento de la prestación en espera; (d) motivo del contacto (cita y agenda); (e) cuando corresponda, la descripción de los motivos del usuario para el no requerimiento de la atención que validen una causal de egreso, excepción o cierre de garantía; (f) detalles del contacto efectuado y confirmación de comprensión de la información entregada por el usuario o su representante; e (g) información del responsable del respaldo (nombre, cargo y unidad en la que se desempeña.	
Participantes	Unidades de gestión de agenda y admisión	
	Centros de llamados	
	Unidades de gestión de la demanda	
	Unidades de soporte para la gestión del contacto multicanal	
	Todas aquellas unidades que requieran gestionar agendas y citas.	
Actividades del subproceso de Gestión de Cita y Agenda		
Actividades	**Tarea**	**Descripción**
	Revisar el listado de personas para agendar	Tarea mediante la cual se obtiene los registros de espera de usuarios de acuerdo con la disponibilidad de información del proceso de gestión de la demanda y estratificación, permitiendo un proceso de priorización de agenda.
	Evaluar la oferta para el agendamiento	Revisar y evaluar la oferta disponible para agendar la prestación de salud.
	Realizar la revisión de criterios requeridos para la prestación en espera y entrega de indicaciones	Verificar que el usuario cumpla con los criterios y prerrequisitos específicos para cada prestación según definiciones de protocolos de referencia y contrarreferencia locales y según orientaciones técnicas definidas, necesarios para recibir la atención de forma eficiente (preparación).
	Definir la vía de contactabilidad mediante multicanal	Definir las vías de contactos por mensajerías o llamado: Establecer contacto con el usuario a través de los diferentes canales de comunicación disponibles, considerando vías de contactos que aseguren que se produzca la vinculación bidireccional con la persona que demanda una prestación, y un proceso de coordinación de agenda eficiente (llamados, mensajes, IA, etc).
	Identificar la persistencia de la necesidad de salud	Evaluar si la necesidad de salud del usuario persiste y mantiene su vigencia, lo cual determina la continuidad del proceso de atención.
	Realizar la verificación y actualización de datos de contacto	Verificar si los datos de contacto del usuario (teléfonos, correo electrónico, dirección) se encuentren actualizados y correctos. En caso de ser necesario, se procede a actualizar la información.
	Verificar la disponibilidad para recibir la prestación	Evaluar si el usuario tiene la disponibilidad y las condiciones necesarias para recibir la prestación de salud en la agenda propuesta.

	Resolver dudas del usuario	Atender y resolver dudas que la persona pueda tener en cualquier momento del proceso de atención.
	Coordinar la cita, realizando el agendamiento de la hora consensuada	Realizar la programación de la hora en consenso con el usuario según el tipo prestación de salud y considerando las preferencias del usuario, según OOTT de Gestión de agendas en atenciones ambulatorias de especialidad.
	Efectuar la confirmación y recordatorio de la cita	Realizar la confirmación de cita agendada con el usuario, a través de los canales de comunicación disponibles, asegurando la asistencia a la atención registrada mediante el envío de recordatorios, y según las preferencias del usuario. En relación con los días previos, se recomienda realizar la confirmación entre 24 a 72 horas hábiles antes del día de la atención, lo cual dependerá de la capacidad del establecimiento para reasignar horas anuladas y agendar una nueva cita en los cupos disponibles, junto con mantener disponible la ficha clínica del usuario en el día de la atención[6]. Se considera que los recordatorios debiesen ser los de mayor masividad y menor costo posible, priorizando la mensajería instantánea como la de mayor costo-eficiencia.
Herramienta	Script de contactos disponibles para la gestión de agendas y citas	Implementar los Scripts N°3 (anexo N°4) para la contactabilidad de agendamiento: • Script 3.0: correo electrónico gestionado por una persona. • Script 3.1: mensajería instantánea gestionada por una persona. • Script 3.2: mensajería de texto (SMS). • Script 3.3: llamado telefónico gestionado por una persona. • Script 3.4: portal paciente. Implementar los Scripts N°4 (anexo N°4) para la contactabilidad de confirmación de citas: • Script 4.0: correo electrónico IA. • Script 4.1: correo electrónico gestionado por una persona. • Script 4.2: mensajería instantánea IA. • Script 4.3: mensajería instantánea gestionada por una persona. • Script 4.4: mensajería de texto (SMS). • Script 4.5: llamado telefónico automatizado por IA. • Script 4.6: llamado telefónico gestionado por una persona. • Script 4.7: portal paciente.

IMAGEN N°4: FLUJO DEL SUBPROCESO DE CONTACTABILIDAD DE AGENDAS Y CITAS



5.5. CONTACTABILIDAD POST ATENCIÓN

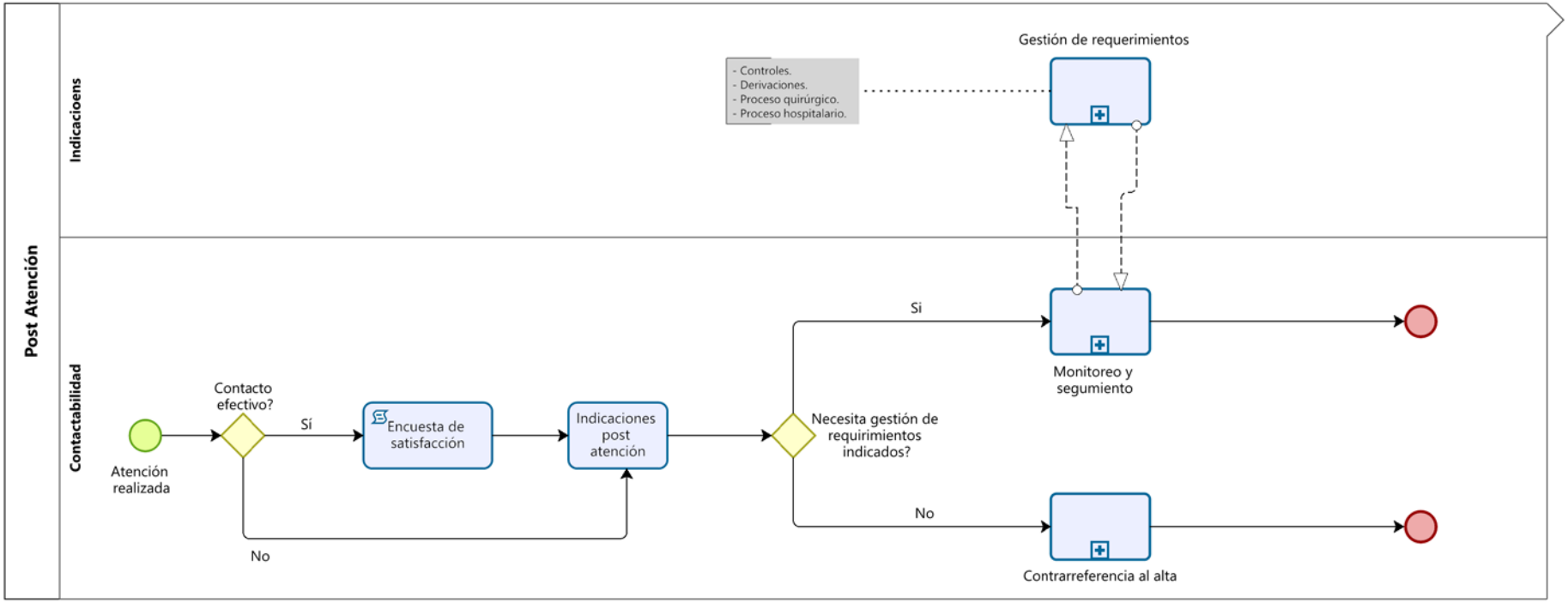
Se establece un plan de gestión de contactabilidad post prestación de salud, desde la realización de esta, hasta su contrarreferencia al alta, optimizando los mecanismos de atención más resolutivos y oportunos.

TABLA N°4: FICHA DEL SUBPROCESO DE CONTACTABILIDAD POST ATENCIÓN

CONTACTABILIDAD POST ATENCIÓN	
Responsable	Personal técnico o profesional.
Objetivo	Realizar un seguimiento al usuario para resolver dudas, verificar cumplimiento de indicaciones, gestionar las acciones y prestaciones que permitirán dar continuidad del cuidado post atención y medir la satisfacción del usuario con el servicio entregado.
Entradas	Su realización incluye a los usuarios que fueron citados cuya fecha de atención ya fue realizada. Dado lo anterior, profundizar en este proceso requiere información de la prestación e indicaciones entregadas.
Vías de contactabilidad	Las vías de contactabilidad preferentes consideran vías que nos permitan contar con una comunicación bidireccional como llamadas telefónicas, mensajería instantánea y correos electrónicos directos. De igual forma, si el usuario indicó preferencias de contacto anteriormente, se deben considerar según la disponibilidad.
Salidas	Usuario contactado que fue atendido y monitorizado post atención: el usuario puede ser contrarreferido al alta a su establecimiento de origen o continuar con instancias posteriores de vinculación con el establecimiento de destino debido a indicación de controles, procedimientos, intervenciones, entre otros.
	Usuario contactado que no fue atendido: Se debe aplicar el protocolo de NSP según lo descrito en la OOTT para el Proceso de Gestión de Agendas y normativas GES vigentes.
	Usuario no contactado: cierre de su proceso de contactabilidad.
Registros	El registro del proceso de contactabilidad deberá incluir los siguientes antecedentes para permitir la verificación y auditoría del proceso: (a) datos del receptor del contacto, ya sea el usuario del registro de espera (RUN y dv, nombres, apellidos, domicilio, teléfonos y correo electrónico) o su representante (RUN y dv, nombres, apellidos, relación con el usuario, teléfonos y correo electrónico); (b) información sobre el canal de contacto utilizado (modalidad de captura, fecha y hora del contacto); (c) requerimiento de la prestación en espera; (d) motivo del contacto (post atención); (e) cuando corresponda, la descripción de los motivos del usuario para el no requerimiento de la atención que validen una causal de egreso, excepción o cierre de garantía; (f) detalles del contacto efectuado y confirmación de comprensión de la información entregada por el usuario o su representante; e (g) información del responsable del respaldo (nombre, cargo y unidad en la que se desempeña.
Participantes	Unidades de satisfacción usuaria
	Centros de llamados
	Unidades de gestión de la demanda, navegadores, gestores de casos
	Unidades de soporte para la gestión del contacto multicanal

Actividades del subproceso de Post Atención		
Actividades	**Tarea**	**Descripción**
	Realizar la contactabilidad multicanal post atención	Establecer contacto con el usuario a través de los diferentes canales de comunicación disponibles, para mantener el vínculo bidireccional con la persona que recibió una atención, según el siguiente procedimiento: • Seleccionar el método de contacto: priorizar medios automatizados y masivos para el envío de encuestas. • Aplicar encuesta de satisfacción usuaria: se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación automatizadas, como encuestas breves, que pueden integrarse a los scripts dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera. • Realizar la verificación y actualización de datos de contacto: verificar si los datos de contacto registrados mantienen su vigencia y, en caso de proceder, actualizar los que corresponda. • Resolver dudas del usuario: en el caso de que se identifiquen dudas del usuario por medio de un canal masivo (ej.: correo electrónico, mensajería instantánea), estas deben ser derivadas al equipo administrativo-clínico disponible para su revisión y respuesta. • Pesquisar requerimientos de prestaciones complementarias y/o necesidades adicionales: identificar y recopilar los requerimientos del usuario en cuanto a prestaciones complementarias o necesidades adicionales, según indicaciones posteriores a la atención.
	Realizar la revisión de las indicaciones entregadas post atención	Revisar que el usuario haya comprendido y recibido adecuadamente las indicaciones proporcionadas con posterioridad a la atención.
	Subproceso de gestión de indicaciones	En el caso de que se generen requerimientos post atención, se debe realizar la revisión y gestión de dichas indicaciones mediante un nuevo **subproceso de monitoreo y seguimiento**, con énfasis en el acompañamiento de usuarios con características de mayor riesgo (por ejemplo: patologías oncológicas). Desde este evento de contactabilidad se pueden realizar las coordinaciones internas necesarias para asegurar la gestión efectiva de las indicaciones según las definiciones y directrices de la especialidad. Este subproceso puede incluir la gestión de medicamentos, procedimientos, exámenes, cirugías, entre otros requerimientos específicos derivados de la atención recibida.
	Contrarreferencia al alta	Informar y orientar al usuario sobre los hitos y pasos a seguir posteriores a la atención recibida, asegurando la comprensión de las indicaciones entregadas, así como las instrucciones relacionadas con su contrarreferencia al establecimiento de origen o al que asegure la continuidad del caso. Además, se deben entregar todas las instrucciones relevantes para garantizar la continuidad de la atención.
Herramienta	Script de contactos disponibles para post atención	Aplicar los Scripts N°5 para estandarizar la comunicación (anexo N°4), según el canal utilizado: • Script 5.0: correo electrónico gestionado por una persona. • Script 5.1: mensajería instantánea gestionado por una persona. • Script 5.2: mensajería de texto (SMS). • Script 5.3: llamado telefónico gestionada por una persona. • Script 5.4: portal paciente

IMAGEN N°5: FLUJO DEL SUBPROCESO DE CONTACTABILIDAD DE POST ATENCIÓN



6. COMPROMISO DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN (COVICOM) COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EN LA GESTIÓN DE LA CONTACTABILIDAD

La implementación de un "Compromiso de Vinculación y Comunicación" (COVICOM), ya sea en formato físico o digital, tiene como objetivo documentar la información proporcionada al usuario o su representante, en el contexto de la contactabilidad. Así, se explicita al usuario o persona bajo el cuidado de su responsabilidad en la gestión de contacto y se hace partícipe de los procesos de comunicación, fomentando su compromiso por mantener información vigente para el sistema de salud. Dado lo anterior, es importante considerar la disponibilidad del COVICOM en diversos formatos y traducciones, según las características y necesidades de la población atendida en cada establecimiento.

Es importante que este documento quede disponible para su registro y vinculación con otros procesos de la Red de Atención para mejorar la información, identificación de características e interés del usuario, por ejemplo, para la interoperabilidad.

El formato para el COVICOM debe incluir diferentes secciones (en detalle en el anexo N°5: formato para el compromiso de vinculación y comunicación):

1. Sección informativa:

- Información disponible sobre los procesos de gestión de los registros de espera, tiempos estimados de respuesta, y/o solicitudes.
- Detalle de los canales de comunicación bidireccionales disponibles con el establecimiento (teléfonos, correo, mensajería, presencial, etc.). En base a la normativa vigente Ley N°21.541, (artículo 8°, letra "e") las características y condiciones de uso de las tecnologías que empleará para las prestaciones de salud digital como, asimismo, los medios tecnológicos y conectividad con que deberá contar y las acciones que deba realizar el usuario para comunicarse correctamente con el prestador respectivo, a través de un lenguaje o medios que faciliten su comprensión[14].
- Los derechos y deberes de los usuarios en relación con las actividades vinculadas con su atención de salud cualquiera sea la forma en que esta se preste, presencialmente o realizada a distancia o por telemedicina apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones (Artículo N°1), de acuerdo con lo establecido en la Ley N°20.584[3] incluyendo información respecto al correcto uso de datos personales y el deber de entregar información veraz acerca de su sintomatología, identidad y dirección.
- Uso de información personal para realizar actos necesarios para determinar u otorgar beneficios de salud y cumplir objetivos sanitarios en base a la Ley N°19.628, artículo 10°[15].

2. Sección de confirmación y consentimiento: el registro debe ser digital y en el caso que esto no sea factible, se llenará en un formato físico que con posterioridad deberá ser digitalizado. Esta sección debe dar cuenta que el usuario fue informado y comprendió sus deberes en el ámbito de la gestión de la contactabilidad,y por tanto entiende que es de su responsabilidad declarar y mantener actualizados, a través de este documento, sus datos de contactos actualizados (nombre asignado al nacer, nombre social, teléfonos, correo electrónico, domicilio, preferencias de contacto y uso de mensajería instantánea u otro). Asimismo, se debe informar respecto al uso de su información personal para determinar u otorgar beneficios de salud y cumplir objetivos sanitarios, incluyendo la

posibilidad que dicha información sea utilizada para la gestionar atenciones en diferentes prestadores de la red tanto públicos como privados. Igualmente, es importante señalar si el usuario está dispuesto a recibir atención digital mediante telemedicina sincrónica y/o asincrónica, facilitando las gestiones posteriores que se puedan desarrollar en la Red Asistencial, sin embargo, no reemplaza el proceso de aceptación o desistimiento de atención digital definidos bajo dicha modalidad.

El registro debe ejecutarse, de forma preferencial, al momento de vinculación y debe realizarse **individualmente por cada prestación en espera que tenga la persona.** En el caso que no se realice al inicio, puede efectuarse en los eventos de contactabilidad posteriores. La información recabada debe quedar debidamente documentada en el historial del usuario en el sistema local, disponible y resguardado durante todo el proceso de referencia y contrarreferencia en red.

Cabe destacar que para aquellos casos que no logran ser ubicados, la aplicación del COVICOM permitirá, **en el caso de usuarios en Lista de espera no GES**, proceder con un flujo de contactabilidad menos extenso para el egreso en la gestión de la no contactabilidad.

Es importante enfatizar que, si bien el Compromiso de Vinculación y Comunicación, permite establecer un marco de responsabilidad de los usuarios para los eventos de comunicación, en consideración a la relevancia de este proceso, es necesario que la Red Asistencial mantenga regularmente actualizado, tanto el COVICOM, como los datos de contacto de los usuarios, a fin de captar las preferencias de comunicación y atención. Con lo anterior, se busca promover la participación y responsabilidad de los usuarios y de la Red Asistencial en los procesos de contactabilidad.

7. SALIDAS DE SISTEMAS DE REGISTROS DE ESPERA PARA PRESTACIONES DE SALUD VÍA GESTIÓN DE CONTACTABILIDAD

Las salidas del registro de espera comprenden diversos motivos que determinan la condición del egreso, excepciones o cierre de garantías GES, ya sean administrativos o clínicos. Las causales administrativas que no requieren evaluación clínica pueden optimizarse mediante un modelo de recopilación de información estandarizada y el uso de múltiples canales.

Por consiguiente, los antecedentes que confirmen la existencia de una salida de registro de espera podrán obtenerse mediante las formas de contacto establecidas, ya sean presencial o a distancia. Es obligatorio que la recopilación de esta información sea completa y de alta calidad, asegurando siempre la privacidad y la protección de los datos confidenciales del usuario.

Los registros utilizados para generar causales de egreso, excepción o cierres de garantías GES deben ser verificables y documentarse en el registro clínico y en cualquier soporte validado (sistemas información de la Red Asistencial y/o plataformas centralizadas para estos efectos), para el cumplimiento de la normativa vigente. En este sentido, para la implementación adecuada de la multicanalidad, en referencia a los canales de comunicación a distancia, estos deben respaldar el registro correspondiente o log de la información recopilada, que conste cronológicamente de los acontecimientos que se han realizado, incluyendo datos de la fuente y el receptor, motivo del contacto y descripción de la causal de salida de registro, entre otros.

7.1. LISTA DE ESPERA NO GES

El egreso del sistema de registro de Lista espera no GES puede ocurrir debido a diversas causales, definidas en la Norma Técnica N°118 y sus actualizaciones, algunas de las cuales pueden ser aplicadas y validadas mediante la gestión de la contactabilidad, asegurando siempre la documentación completa y justificación de cada caso para mantener la transparencia y la correcta gestión de los registros de espera.

Para efectos de la gestión de contactabilidad, se pueden identificar tres categorías de causales de salidas:

1. Motivos que requieren un proceso de verificación interna: Estos se pueden detectar durante el proceso de contactabilidad de manera circunstancial e incluyen situaciones donde el usuario ya no requiere su prestación de salud o esta no corresponde. Ejemplos incluyen:

- Usuario ya ha sido atendido.
- La patología del usuario ya no forma parte del registro de espera definido.
- No corresponde su asegurador.
- Usuario ha fallecido.
- La condición clínica del usuario ha cambiado.
- Usuario no requiere la prestación registrada inicialmente.
- Usuario requiere traslado a otro establecimiento.

En estos casos, se debe registrar, revisar internamente e incorporar documentación de respaldo, incluyendo un conjunto mínimo de datos para dicho evento.

2. Motivos que puede ser considerados solo por la contactabilidad realizada: Esto se traduce cuando vía contactabilidad se detecta que el usuario no requiere recibir su prestación. En general se pueden incluir situaciones como:

- Usuario fue atendido en extrasistema.
- Usuario rechaza la prestación.
- Usuario se recuperó de su problema de salud.

En estos casos, se puede utilizar como verificable el registro de la contactabilidad y respaldo del conjunto mínimo de datos para dicho evento.

3. Motivo por no contactabilidad: En el caso de que no se logre establecer contacto a través de los medios registrados, el caso se egresa con los respaldos requeridos en la gestión de la no contactabilidad. Para más detalles se puede revisar el capítulo 8 de Gestión de la no Contactabilidad de la presente OOTT.

Para detalles de causales de egresos de registro de Lista de espera no GES se debe consultar norma técnica actualizada.

7.2. PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN Y CIERRE DE GARANTÍAS GES

Los procedimientos de excepción y cierre de garantías se encuentran regulados mediante el Compendio de Normas sobre Procedimientos de la Superintendencia de Salud[27] y las Normas de carácter técnico médico y administrativo para el cumplimiento de las garantías explícitas en salud de la ley N°19.966, Decreto N° 53 del 2019, y sus actualizaciones[28]. De lo anterior es posible identificar cambios de estado de garantías, las cuales pueden ser exceptuadas o cerradas.

7.2.1. CAUSALES DE EXCEPCIÓN DE GARANTÍAS

En el proceso de gestión de garantías GES, existen causas atribuibles al beneficiario o por fuerza mayor derivadas de su estado de salud, en las cuales sea imposible entregar la prestación en el plazo establecido, dando lugar a una nueva gestión del caso. Solo podrán exceptuarse las garantías GES que se encuentren en estado vigente. De lo anterior es posible identificar cambios de estado de garantías **transitorias y permanentes.**

Para efectos de la gestión de contactabilidad, se pueden identificar tres categorías de cambio de estado:

1. Motivos que requieren un proceso de verificación interna: Durante el proceso de contactabilidad pueden ocurrir de manera circunstancial que se detecten casos en que el usuario señale que, por fuerza mayor de su estado de salud indicado por el profesional tratante, ya no requiere su prestación de salud en forma permanente **(exclusión)** o que no es posible otorgar la prestación en ese momento **(postergación)**. En ambos casos, solo corresponde informar, ya que es una decisión justificada del profesional tratante y requieren registro de verificables en la ficha clínica.

2. Motivos que puede ser considerados solo por la contactabilidad realizada: Esto se traduce cuando vía contactabilidad se detecta que el usuario no requiere o no asiste a recibir su prestación. Incluye el rechazo del usuario al prestador designado o prestación, debiendo constar por escrito según el medio utilizado de contacto. También abarca la inasistencia injustificada a dos citaciones efectivas para el otorgamiento de una prestación de salud garantizada.

3. Motivo por no contactabilidad: En el caso de que no se logre establecer contacto a través de los medios registrados, durante la vigencia de la garantía, se considera el motivo de "contacto no corresponde". Para su validación como garantía exceptuada, deben haberse agotado las gestiones descritas según normativa GES vigente y factibles para llevar a cabo la citación efectiva, debiendo ello constar en los registros que las acrediten. Esta es una excepción permanente y se considera por no contactabilidad.

7.2.2. CAUSALES DE CIERRE DE GARANTÍAS

Término del vínculo del beneficiario con una o más garantías exigidas en un determinado problema de salud. Dado que un beneficiario puede presentar varias garantías al mismo tiempo, el cierre de una garantía no implica el cierre de caso o de otra garantía abierta. El caso puede permanecer abierto, pudiendo el beneficiario recibir otras prestaciones garantizadas del mismo problema de salud.

Para efectos de la gestión de contactabilidad, se pueden identificar tres categorías de causales de cierre de garantía GES:

---

[27] Superintendencia de Salud, (2024) Compendio de Normas sobre Procedimientos Capítulo XI Procedimientos Relativos a las Garantías Explícitas en Salud.

[28] Aprueba normas de carácter técnico médico y administrativo para el cumplimiento de las garantías explícitas en salud de la ley n°19.966, Decreto N° 53 del 2019.

1. Motivos que requieren un proceso de verificación interna: durante el proceso de contactabilidad pueden ocurrir de manera circunstancial que se detecten casos en que el usuario señale el cambio de sistema previsional, o que por indicación del profesional tratante no cumple con los criterios de acceso, o que ha recibido la entrega de la totalidad de las intervenciones sanitarias garantizadas e indicadas por el profesional tratante para ese problema de salud. También en esta categoría se incluye el fallecimiento del beneficiario. Todo lo anterior solo corresponde informar internamente de estos hallazgos, ya que corresponde realizar un proceso de revisión interna y la generación de los registros faltantes por las unidades técnicas responsables.

2. Motivos que pueden ser considerados solo por la contactabilidad realizada: esto se traduce cuando vía contactabilidad, se detecta que el usuario no requiere continuar con su garantía GES. Incluye el rechazo del usuario al prestador designado o prestación, debiendo constar por escrito, así como la inasistencia injustificada, que se da cuando el beneficiario no acude a tres citaciones efectivas para el otorgamiento de una prestación de salud garantizada.

3. Motivo por no contactabilidad: en el caso que no se logre establecer contacto a través de los medios registrados, se considera el motivo de "contacto no corresponde". Esto ocurre cuando no es posible efectuar la citación efectiva al beneficiario, porque los datos de contacto entregados por el usuario a través de los distintos registros habilitados para este fin no corresponden. Califica como "contacto no corresponde" un usuario al cual se ha intentado ubicar utilizando todas las modalidades descritas para lograr una citación efectiva.

7.3. INFORMACIÓN BÁSICA Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE SALIDAS DE REGISTROS DE ESPERA POR CONTACTABILIDAD

En el proceso de registrar y documentar una salida de los sistemas de registros de espera mediante gestiones de contactabilidad se requiere la acreditación documental específica, que incluya diferentes datos del emisor y del receptor del contacto. Es esencial verificar la identidad del usuario y garantizar la integridad, autenticidad y confidencialidad del mensaje en cada medio de obtención de la información. Esto implica lo siguiente:

1. Comprobación de los siguientes datos:

a. Identidad del receptor del contacto: usuario o a su representante o la persona bajo cuyo cuidado se encuentre.

b. Corroboración y actualización de datos personales del usuario para el proceso de contactabilidad, según normativa vigente N°820 (conjunto mínimo básico de datos)[11], los cuales incluyen, al menos lo siguiente:

   (1) RUN.

   (2) Condición del RUN: si es definitivo o transitorio.

   (3) Nombres.

   (4) Primer apellido.

   (5) Segundo apellido.

   (6) Consultar si la persona desea ser identificada por un nombre social.

   (7) Fecha de nacimiento.

   (8) Previsión y PRAIS.

(9) Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número. En zonas rurales o de difícil acceso considerar referencias para la ubicación.

(10) Teléfono fijo.

(11) Teléfono móvil.

(12) Correo electrónico.

(13) Prestación de salud en espera.

c. Seguridad del medio de comunicación utilizado, que garantice la integridad, autenticidad y confidencialidad del mensaje. No se deben utilizar medios de contacto sin confidencialidad de los datos (ejemplo: redes sociales). Además, debe permitir identificar y autenticar tanto al emisor como al receptor.

d. La generación de la evidencia que permita comprobar la comunicación, su contenido y su conservación. Todos estos datos, indicados en el punto II a continuación, deben quedar anexados localmente a la historia clínica o en los sistemas oficiales. Esta información debe conservarse por al menos quince años, según la Ley N°20.584 párrafo 6°: De la reserva de la información contenida en la ficha clínica[3].

2. Datos requeridos para la salida de registros de espera (toda la información debe quedar anexada a la ficha clínica del usuario y en cualquier soporte validado):

a. Datos del receptor del contacto:

(1) Si corresponde al usuario del registro de espera:

» RUN.

» Nombres.

» Primer apellido.

» Segundo apellido.

» Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.

» Teléfonos fijo y móviles.

» Correo electrónico

(2) Si corresponde al representante o la persona bajo cuyo cuidado se encuentre el usuario:

» RUN.

» Nombres.

» Primer apellido.

» Segundo apellido.

» Relación con el usuario.

» Teléfonos fijo y móviles.

» Correo electrónico.

b. Información sobre el canal de contacto utilizado:

(1) Modalidad de captura de información (canal multicanal utilizado).

(2) Fecha del contacto.

(3) Hora del contacto.

c. Requerimiento de la prestación en espera.

d. Motivo del contacto.

e. Descripción de los motivos del usuario para el no requerimiento de la atención que validen una causal de egreso, excepción o cierre de garantía.

f. Detalles del contacto efectuado y confirmación de comprensión de la información entregada por el usuario o su representante.

g. Información del responsable del respaldo: nombre, cargo, unidad en la que se desempeña.

7.4. MODALIDADES DE CAPTURA DE INFORMACIÓN

La obtención de la información para la salida del registro de espera mediante contactabilidad puede realizarse a través de distintas modalidades de contacto, requiriendo del respaldo verificable para que se genere la salida del registro de espera de manera válida:

1. Concurrencia del usuario: la interacción directa permite registrar y verificar la información de forma sincrónica, asegurando una comunicación clara y precisa. Se debe:

- Verificar los datos indicados en el ítem I. Comprobación de datos.
- Comprobar y registrar adecuadamente los datos requeridos para el respaldo de la salida de registros, indicados en el ítem II. Datos requeridos para la salida de registros de espera.
- El registro del egreso, excepción o cierre de garantía debe efectuarse dejando constancia en los archivos locales correspondientes del establecimiento.

2. Visitas domiciliarias: tanto las visitas institucionales como externalizadas pueden validar la pesquisa de un egreso, excepción o cierre de garantía de forma presencial. Se debe:

- Verificar los datos indicados en el ítem I. Comprobación de datos.
- Comprobar y registrar adecuadamente los datos requeridos para el respaldo de la salida del registro indicados en el ítem II ítem II. Datos requeridos para la salida de registros de espera. Se debe considerar que en la visita externalizada no se puede compartir información sensible, y debe ir acompañada del enlace al portal paciente o medio de contacto con el establecimiento para que el usuario actualice la información de su prestación en espera.
- El verificable de registro corresponde a la bitácora de la visita realizada con su resultado. Esta bitácora deberá contar información del responsable del respaldo: nombre, cargo, unidad y establecimiento en el que se desempeña.
- Una visita que no se concreta (domicilio incorrecto, vivienda deshabitada, no acepta la visita, dirección inexistente, entre otros), debe seguir el flujo indicado en la "Gestión de la No Contactabilidad".

3. Correos electrónicos: se establece una comunicación por vía electrónica con los usuarios, desde una casilla institucional, sin constituir por sí solo un medio verificable de salida de registros de espera. Consideraciones:

- Por este medio no se deben compartir datos sensibles, tales como, los estados de salud físicos o psíquicos.
- Mediante esta vía de contacto se puede detectar que el usuario no requiere la prestación de salud, pero no constituye un medio verificable para la salida del registro. Para verificar la información de los ítems: I. Comprobación de Datos y II. Datos requeridos para la salida de

registros de espera, se debe redirigir al usuario al portal paciente correspondiente para realizar la validación de identidad y el flujo correspondiente.

- Se debe mantener un registro de los correos electrónicos enviados y recibidos como constancia de la comunicación (trazabilidad).

4. Mensajería instantánea: utilización de mensajería instantánea, manteniendo un registro de las interacciones, sin constituir por sí solo un medio verificable de egreso, excepción o cierre de garantía. Debe corresponder a una cuenta de mensajería instantánea institucional. Consideraciones:

- Por este medio no se deben compartir datos sensibles, tales como, los estados de salud físicos o psíquicos.
- Mediante esta vía de contacto se puede detectar que el usuario no requiere la prestación de salud, pero no constituye un medio verificable para el egreso, excepción o cierre de garantía. Para verificar la información de los ítems: I. Comprobación de Datos y II. Datos requeridos para la salida de registros de espera, se debe redirigir al usuario al portal paciente correspondiente para realizar la validación de identidad y el flujo correspondiente para la salida de registro.
- Se debe registrar y almacenar los logs de las conversaciones para llevar un control y trazabilidad.
- A la fecha, no constituye un medio de contacto para gestión de citas efectivas en GES.

5. Llamadas telefónicas: pesquisa del egreso, excepción o cierre de garantía, a través de llamadas telefónicas de forma directa. Debe corresponder a un teléfono de uso institucional. Se debe:

- Verificar los datos indicados en el ítem I. Comprobación de datos.
- Comprobar y registrar adecuadamente los datos requeridos para el respaldo de la salida del registro, indicados en el ítem II. Datos requeridos para la salida de registros de espera.
- El medio validador es la bitácora de llamados más el registro electrónico de su realización, y en el caso que la llamada sea realizada por un externo, se debe incorporar la transcripción y/o grabación de la llamada.

6. Portal paciente: uso de sistemas informáticos de salud centrados en la persona, que permitan informar el egreso, excepción o cierre de garantía, de forma segura y accesible. Consideraciones:

- Debe implementarse con un sistema de validación de identidad y medidas de seguridad avanzadas de protección de información sensible, conforme a las normativas vigentes (ingreso mediante clave única).
- Mantener un registro de todas las interacciones y acciones realizadas en la cuenta de un usuario.
- Para validar una salida del registro informada por el usuario por esta vía, se debe seguir el siguiente procedimiento:
  - Envío de correo electrónico a la cuenta informada por el usuario solicitando confirmación del no requerimiento de la atención registrada, con un plazo de hasta 5 días para que el usuario confirme o niegue la salida del registro informada en el portal paciente.
  - Además, se realizarán dos llamadas telefónicas a los teléfonos registrados en el portal paciente por el usuario para verificar la salida del registro de espera. Las llamadas deben realizarse en un plazo máximo de cinco días desde informada la salida del registro por el usuario en el portal.

  - Si, tras los intentos de contacto mediante correo electrónico y llamadas telefónicas en el plazo establecido de 5 días, no se logra ubicar al usuario, se procederá a egresar o exceptuar o cerrar la garantía considerando lo informado previamente por el usuario en el portal paciente.
- El link del portal paciente puede ser enviado y adjuntado a otros canales de contacto (correos electrónicos, mensajería instantánea, entre otros).
- La plataforma deberá permitir:
  - Actualizar datos de contacto y antecedentes de salud.
  - Informar de atenciones ejecutadas, rechazos de la prestación y el envío de mensajes seguros.
  - Proporcionar sistemas de respuesta para comunicarse con el establecimiento.
- Para mayor detalle de los requerimientos mínimos que debe contener un portal paciente, se pueden consultar en el anexo N°6: requisitos mínimos para la implementación de portales paciente.

7. Llamados radiales: envío de mensajes mediante radiodifusión. Consideraciones:

- Debe ser utilizado en casos excepcionales, y solo aplica el verificable para egresar en el caso de gestión de contactabilidad en agendas y citas como citación extraordinaria vía radial.
- Por este medio se deben resguardar la protección de datos sensibles, tales como, los estados de salud físicos o psíquicos de las personas.
- El medio de respaldo para la salida del registro en la gestión de contactabilidad corresponde a la grabación de la emisión radial o la bitácora de la radio.

8. Carta certificada: envío de correo certificado a los domicilios que se encuentran registrados en el establecimiento en el proceso de Gestión de la No Contactabilidad. Consideraciones:

- El uso de carta certificada para el proceso egresos de lista de espera no GES se considera solo en el flujo de no contactabilidad, al no ser factible obtener una respuesta directa por parte del usuario. La carta debe notificar al usuario sobre la necesidad de actualización de sus datos y los medios de contacto para comunicarse con el establecimiento y continuar con su proceso de atención. El plazo máximo de 30 días corridos para que el usuario establezca contacto comienza a partir de la fecha en que se hace entrega de la carta certificada al usuario, lo que debe quedar respaldado oficialmente por la institución que distribuye la carta.
- Dados los plazos para su gestión y respuesta del usuario, no es una vía útil para la contactabilidad de usuarios con garantías GES.

8. GESTIÓN DE LA NO CONTACTABILIDAD

Las acciones relacionadas con las salidas de registro, por falta de contactabilidad deben estar respaldadas por una gestión efectiva de los procesos de contactabilidad de los usuarios. Esta gestión considera la realización de múltiples intentos de comunicación. Todos estos intentos deben quedar registrados detalladamente y, si después de un plazo máximo no se logra establecer contacto, el caso puede ser egresado del registro de espera o su garantía exceptuada o cerrada. Dado lo anterior, las redes deben disponer de un canal abierto y permanente, tal como un **portal paciente**, para que el usuario pueda tomar contacto con el establecimiento en un plazo establecido, además de disponer trazabilidad en las indicaciones respecto a las comunicaciones realizadas. De esta forma, se garantiza que se han ejecutado todos los esfuerzos posibles para establecer contacto con los usuarios de manera eficiente y oportuna.

Dentro del mismo contexto, toma especial relevancia la realización del COVICOM en forma previa, ya que la toma de conocimiento permite reducir las acciones de contactabilidad requeridas, tales como visitas domiciliarias o cartas certificadas. En el caso de aquellos que no tengan cursado el COVICOM, se deben extender las gestiones de vinculación, incluyendo las visitas domiciliarias o cartas certificadas. Dada las opciones disponibles para la realización de visitas domiciliarias, es posible considerar el protocolo de aplicación a través de las unidades de participación de los diferentes establecimientos que componen la Red Asistencial. Sin embargo, para su ejecución se requiere de acuerdos en red firmados a través de resoluciones locales, designando los responsables, resguardando el respaldo administrativo correspondiente, siempre y cuando sea un funcionario público quien lo ejecute.

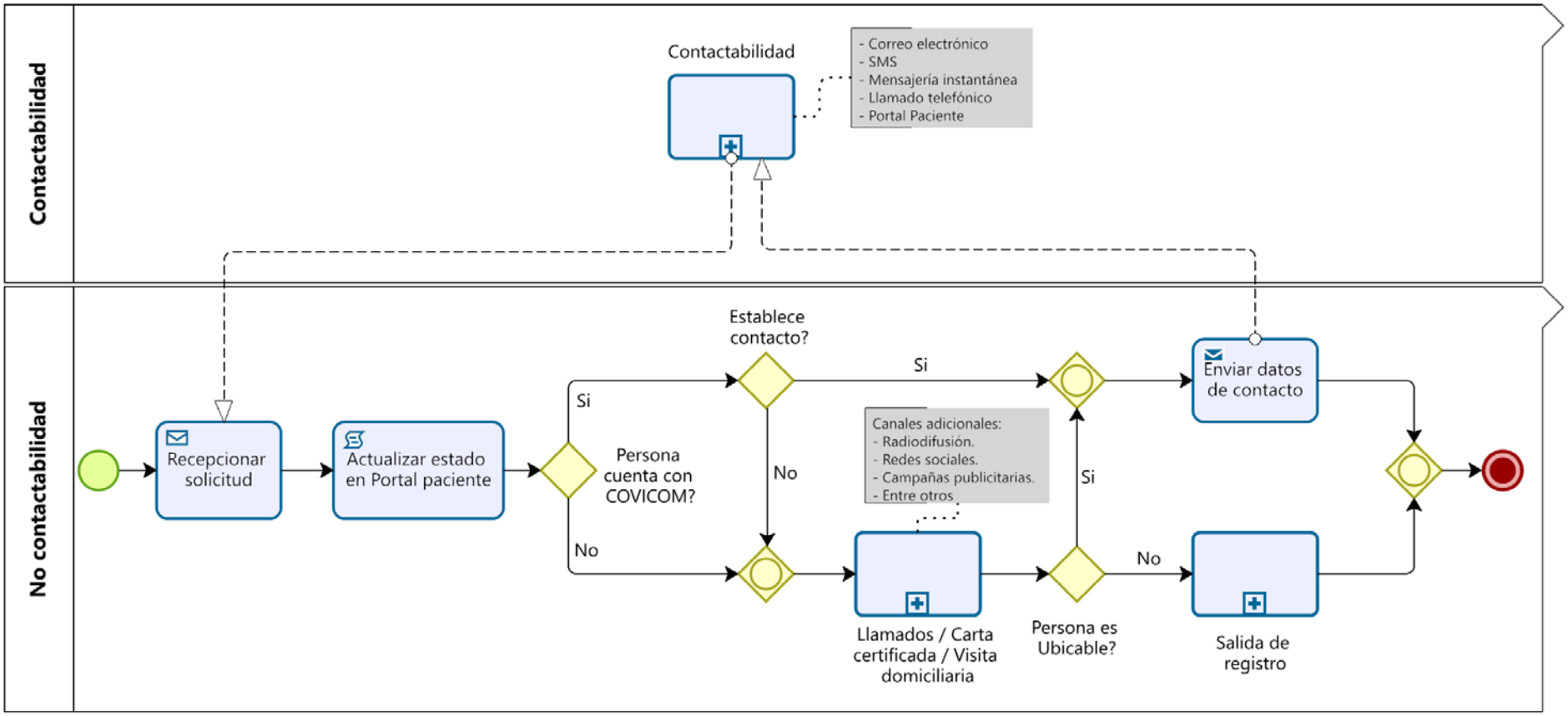
Es importante señalar que la participación de distintos representantes de las organizaciones sociales que integran los Consejos de Desarrollo Local en APS, Consejos Consultivos de Usuarios en hospitales y Consejos de la Sociedad Civil en las direcciones de los SS, pueden ser un recurso complementario como un canal de comunicación e información, siendo una alternativa válida para lograr alcanzar la población no contactada por otros medios, siempre que sea en coordinación con los encargados de participación social y gestión usuaria. Sin embargo, se recomienda proteger la información sensible de los usuarios tal como se expresa en la descripción de la actividad realizada por representantes de las organizaciones comunitarias y no constituye un medio válido para respaldar una salida de registro por no contacto. Para mayor detalle revisar el script N°6.9: contacto vía organizaciones comunitarias. Para la definición de los plazos de contacto por los diferentes canales, deberán considerarse los plazos de las garantías oportunidad definidas en el decreto GES vigente, asegurando las gestiones que permitan la excepción de las garantías con todos los verificables requeridos.

Los scripts N°6 definidos para la gestión de personas no ubicables (anexo N°4.5: scripts para la gestión de la no contactabilidad) son los siguientes:

- Script 6.0: correo electrónico.
- Script 6.1: mensajería instantánea.
- Script 6.2: mensajería de texto.
- Script 6.3: llamado telefónico gestionado por una persona.
- Script 6.4: portal paciente
- Script 6.5: visitas domiciliarias institucionales.
- Script 6.6: visitas domiciliarias externalizadas.
- Script 6.7: carta certificada.
- Script 6.8: radiodifusión.

De forma adicional se pueden implementar estrategias de vinculación en apoyo con el uso de redes sociales, campañas publicitarias, y otros enlaces comunitarios tales como; juntas de vecinos, bomberos, carabineros, etc.

IMAGEN N°6: FLUJO DE LA GESTIÓN DE LA NO CONTACTABILIDAD PARA USUARIOS DE REGISTROS DE ESPERA NO GES



8.1. GESTIÓN DE LA NO CONTACTABILIDAD CON COVICOM

Como parte fundamental de la gestión de contactabilidad, se destaca la implementación del Compromiso de Vinculación y Comunicación (COVICOM) para usuarios que acceden a un determinado registro de espera o en la contactabilidad de vinculación. Este documento garantiza que el usuario reciba información clara y comprensible sobre su proceso de espera, estableciendo su responsabilidad de mantener actualizada su información de contacto, respetando su privacidad y preferencias individuales.

Al realizar la contactabilidad de este grupo de usuarios, se utilizarán canales de comunicación que incluyen medios masivos y personalizados, sin recurrir obligatoriamente a cartas certificadas o visitas domiciliarias. El proceso contempla múltiples intentos de contacto a través de diversos canales, tanto informativos como bidireccionales, efectuados en momentos diferentes y comenzando con los de más bajo costo y de mayor masividad. El objetivo es establecer una comunicación efectiva dentro de un marco temporal definido, con una fecha límite para la vinculación efectiva del usuario con el establecimiento. En caso de que alguno de los medios de contacto no esté disponible (correo electrónico, mensajería instantánea), se procederá según el protocolo de gestión de No Contactabilidad.

De esta forma, la **gestión de No Contactabilidad** con COVICOM se debe realizar siguiendo el siguiente procedimiento:

1. **Correos electrónicos:**
    a. Se enviarán al menos dos correos electrónicos dentro de un mes, con diferencia entre cada correo de a lo menos de una semana en el caso de registro de espera No GES.
    b. La frecuencia en el caso de usuarios con garantías GES dependerá del plazo de la garantía de oportunidad.
    c. Hay que considerar que por este medio no debe compartirse información sensible y por lo tanto, debe incorporarse el enlace al portal paciente para que el usuario actualice su información e informar la necesidad de que el usuario se contacte con el establecimiento.
2. **Mensajería instantánea o Mensajes de Texto (SMS):** utilización de la aplicación de mensajería instantánea para enviar mensajes directos.
    a. Considera el envío de dos mensajes dentro de un mes, con diferencia entre cada mensaje a lo menos de una semana en el caso de registro de espera No GES.
    b. La frecuencia en el caso de usuarios con garantías GES dependerá del plazo de la garantía de oportunidad.
    c. Por este medio no debe compartirse información sensible, y por lo tanto debe incorporarse el enlace al portal paciente para que el usuario actualice su información e informar la necesidad de que el usuario se contacte con el establecimiento.
3. **Llamado telefónico gestionado por persona:** el llamado telefónico directo es un método crucial en la gestión de contacto con los usuarios.
    a. Realizar al menos tres intentos de llamada, a todos los números telefónicos registrados del usuario y/o persona responsable de sus cuidados, en días y horarios diferentes. Considerando un llamado en horario inhábil para maximizar las probabilidades de establecer contacto efectivo.

b. En caso de disponer de un sistema de grabación de llamada u otro medio validador de la llamada, este deberá conservarse como respaldo.

c. En el caso de llamados por externos, es necesario resguardar la grabación o la transcripción de dicha llamada, a disposición y respaldo en los registros locales.

4. **Portales de Pacientes:**

   a. Publicar en portal del paciente la necesidad de su vinculación. Adicionalmente, todos los medios utilizados deben poder dirigir al usuario al portal para actualizar su información y vincularse con el establecimiento.

   b. El portal debe permitir la publicación de notificaciones relacionadas con la necesidad de vinculación, informando al usuario sobre los medios de contacto disponibles del establecimiento. Además, las áreas encargadas de la contactabilidad deben tener acceso a la información actualizada y proporcionada por los usuarios en el portal. La publicación de la necesidad de vinculación por no contactabilidad en el portal paciente durante 30 días permite establecer un nuevo hito temporal para salidas de registro no GES, cuyo verificable de notificación debe quedar para consulta en los registros clínicos electrónicos.

Si luego de 30 días desde iniciado el proceso de contactabilidad a los medios que constan en el COVICOM no se ha logrado establecer contacto, se procederá a egresar el caso sin obligatoriedad de realizar el envío de cartas certificadas o visitas domiciliarias. **Esta indicación no es aplicable a usuarios con garantías GES según normativa vigente. A pesar del COVICOM, todos los usuarios deberán tener gestión de visita domiciliaria para asegurar el contacto y gestión de citas.**

Es importante señalar que en el periodo de gestión de la No Contactabilidad, es posible utilizar otras vías de comunicación, siempre respetando los límites legales y éticos de la gestión de datos personales. Sin embargo, estas no son obligatorias, y concurren solo en caso de ser necesarias considerando el contexto local:

1. **Llamados radiales:** emisión de anuncios radiales, el medio de verificación es la grabación de la emisión radial, considerando 3 llamados radiales, realizados al menos uno en horario inhábil. Uso principalmente en el contexto de ruralidad y zonas extrema con difícil acceso. En el contexto de agendas y citas, la vía radial puede validar una causal de egreso con el respaldo de la citación extraordinaria en casos de ruralidad.

2. **Redes sociales:** utilizar las redes sociales para intentar el contacto efectivo, resguardando rigurosamente la confidencialidad y protección de datos sensibles. Su implementación debe considerar el uso de un perfil institucional del cuál se enviará un mensaje de notificación para que el usuario ingrese al portal de paciente disponible o se comunique con el establecimiento, sin compartir información personal. Es crucial disponer de teléfonos actualizados u otros medios de contacto que sean conocidos y accesibles para los usuarios a través de la mesa central de cada establecimiento. Las redes sociales no pueden ser utilizadas para validar un egreso o excepción o cierre de garantía GES.

3. **Campañas publicitarias:** se pueden utilizar diversos tipos de campañas publicitarias que incluyan información relevante para los usuarios con el fin de informarles sobre la búsqueda activa de su atención, asegurándose de que todos los anuncios cumplan con las regulaciones publicitarias éticas aplicables. Es crucial disponer de teléfonos actualizados u otros medios de contacto que sean conocidos y accesibles para los usuarios a través de la Mesa Central

de cada establecimiento. Las campañas publicitarias no pueden ser utilizadas para validar un egreso o excepción o cierre de garantía GES.

En caso de lograr establecer contacto con el usuario o un representante a través de alguno de los medios previamente mencionados, se deberá proceder con el proceso de vinculación y gestión de su caso. Esto implicará las siguientes acciones:

1. Modificar el estado del usuario en los registros y sistemas de información correspondientes al registro de espera, consignado que se ha establecido contacto exitoso. Actualizar el COVICOM, validando los datos de contacto del usuario (domicilio, números telefónicos, correo electrónico, etc.) para garantizar una comunicación efectiva en el futuro. Si el contacto es con un tercero, verificar si conoce al usuario y si se encuentra autorizado para recibir notificaciones en su nombre y solicitar información de medios de contacto posibles con el usuario (teléfonos, correo electrónico, domicilio).
2. Proporcionar al usuario información disponible sobre los servicios, citas o trámites que tiene pendientes, así como las instrucciones y requisitos necesarios para acceder a ellos. Si corresponde, reagendar las citas o procedimientos pendientes en conjunto con el usuario, dejando constancia de las nuevas fechas acordadas.
3. De ser necesario, brindar las facilidades u opciones disponibles (horarios preferenciales, transporte, etc.) para promover y asegurar el acceso oportuno del usuario a la atención de salud requerida.
4. En el caso de usuarios con garantías GES, deberán priorizarse las gestiones que permitan el otorgamiento de la prestación dentro de los plazos garantizados o en su defecto contar con los respaldos para una excepción o cierre de garantía.

8.2. GESTIÓN DE LA NO CONTACTABILIDAD SIN COVICOM

Si no se ha efectuado el Compromiso de Vinculación y Comunicación anteriormente, la gestión de la No Contactabilidad requerirá la implementación de medidas de contacto de mayor costo en un plazo definido, para asegurar que se hagan todos los esfuerzos necesarios para establecer contacto con los usuarios de forma eficiente, oportuna y con tiempo acotado. **Es importante señalar, además, que este flujo es el único aplicable en la gestión de la No Contactabilidad para las personas con garantías GES, ya que, según la normativa vigente, todos los usuarios deberán tener gestión de visita domiciliaria para asegurar el contacto y gestión de citas.**

Adicional a lo señalado en el 8.1 de la estrategia multicanal para la no contactabilidad con COVICOM (correos electrónicos, mensajería instantánea, SMS, llamados telefónicos), y en el caso de que no se logra vincular al usuario, se deben implementar **al menos uno de los siguientes medios.** Su aplicación dependerá de las características del territorio:

1. **Visita domiciliaria institucional o externalizada:** implica que personal autorizado (funcionarios de establecimientos de salud, redes asistenciales, representantes de consejos de desarrollo local o empresas externas autorizadas) acuda al domicilio registrado del usuario para verificar si efectivamente reside en esa dirección y entregar personalmente información sobre su atención pendiente, recabando datos de contacto actualizados del usuario. La visita debe respaldarse mediante un certificado de contacto que debe contener el detalle de los datos de identificación del usuario, dirección, día y horario de la visita, junto con la firma del usuario o datos del responsable.

2. **Carta certificada o entrega de documento de visita:** debe contener los datos de identificación del usuario, motivo por el cual se busca contactarlo y las instrucciones claras para que este se ponga en contacto con el establecimiento, por los medios que se le indique. La carta certificada permite tener un comprobante de envío y entrega, dejando constancia del intento de contacto por parte del establecimiento. Dados los plazos para su gestión y respuesta del usuario, se sugiere no utilizar la carta certificada para la contactibilidad de usuarios con garantías GES.

En los casos anteriores, se debe informar al usuario o al responsable, que existe una fecha límite para ponerse en contacto con el establecimiento y continuar su proceso de atención, de lo contrario, si luego de 30 días desde iniciado este segundo proceso de contactabilidad no se obtiene contacto, se procederá a egresar el caso.

En caso de lograr establecer contacto con el usuario o un representante a través de alguno de los medios previamente mencionados, se deberá proceder con el proceso de vinculación y gestión de su caso. Esto implicará las siguientes acciones:

1. Actualizar el estado del usuario en los registros y sistemas de información correspondientes al registro de espera, consignando que se ha establecido contacto exitoso y actualizar los datos de contacto del usuario (domicilio, números telefónicos, correo electrónico, etc.) para garantizar una comunicación efectiva en el futuro.
2. Si el contacto es con un tercero, verificar si conoce al usuario y en ese caso, solicitar información de medios de contacto posibles con el usuario (teléfonos, correo electrónico, domicilio), dejando constancia del contacto y posteriormente se procederá a intentar ubicar al usuario dependiendo de la información recabada desde el tercero contactado.
3. Proporcionar al usuario información disponible sobre los servicios, citas o trámites que tiene pendientes, así como las instrucciones y requisitos necesarios para acceder a ellos. Si corresponde, reagendar las citas o procedimientos pendientes en conjunto con el usuario, dejando constancia de las nuevas fechas acordadas o asignadas para garantías GES.
4. En el caso de usuarios con garantías GES, deberán priorizarse las gestiones que permitan el otorgamiento de la prestación dentro de los plazos garantizados o en su defecto contar con los respaldos para una excepción o cierre de garantía.
5. Brindar de ser necesario, las facilidades u opciones disponibles (horarios preferenciales, transporte, etc.) para promover y asegurar el acceso oportuno del usuario a la atención de salud requerida.
6. Registro detallado de todas las gestiones realizadas, actualizando constantemente el estado del usuario en los sistemas correspondientes, a fin de garantizar un seguimiento adecuado y brindar un servicio eficiente.
7. De ser posible, realizar el COVICOM, a fin de garantizar procesos más expeditos en el futuro.

9. ANEXOS

9.1. ANEXO N°1: DESCRIPCIÓN DE CANALES DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS

La evaluación de cada forma de contacto es crucial para diseñar estrategias eficientes de contactabilidad y gestión de la espera. Este análisis detallado considera las ventajas y desafíos de cada modalidad, desde la atención presencial hasta los métodos más tecnológicos y masivos. El objetivo es identificar la opción más adecuada en cada situación, contribuyendo a una experiencia integral para los usuarios, fortaleciendo la integración de los servicios de salud.

Cada canal de comunicación debe ajustarse a las particularidades específicas de su uso, es decir, al momento concreto en que el usuario es contactado. Para evaluar la utilización de un medio de contacto en comparación con otro, es necesario considerar los aspectos contextuales que influyen en las modalidades de contacto y las formas de gestión del contacto.

Estas formas de contacto pueden variar en su naturaleza y pueden incluir medios tanto tradicionales como digitales, los cuales se describen a continuación:

1. Presencial:

1.1. Concurrencia del usuario: requiere que el usuario acuda a un punto de atención de forma presencial en el establecimiento y unidad que corresponda, lo que permite una alta personalización y bidireccionalidad en el contacto. El objetivo principal es servir como un punto centralizado de contacto donde los usuarios puedan recibir atención administrativa, asistencia y canalizar sus inquietudes o necesidades relacionadas con su atención en espera.

El lugar físico al que el usuario puede acudir debe estar estratégicamente diseñado para canalizar eficientemente la información y ofrecer una atención de calidad, evitando congestionar otros procesos. De esta forma, se debe optimizar el proceso de atención presencial a espacios físicos capaces de resolver dudas y consultas del usuario y se actualicen de forma recurrente los datos personales para futuros contactos.

En general, los usuarios concurren físicamente a diversos espacios de la red de atención, tales como:

a. OIRS (Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias): la OIRS es un punto de atención donde los usuarios pueden realizar consultas, presentar reclamos o hacer sugerencias sobre los servicios de salud. Es un mecanismo diseñado para recibir y gestionar la retroalimentación de los usuarios, contribuyendo así a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de salud. La OIRS se enfoca en aspectos relacionados con la atención, información, trámites y calidad percibida por los usuarios.

b. Ventanillas de atención: espacios designados para proporcionar servicios de atención al usuario en diferentes servicios clínicos. Sin embargo, la concurrencia a este espacio puede generar congestión y aumentar la demanda de servicios.

c. Unidades de gestión de admisión: estas unidades son responsables de gestionar los procesos administrativos necesarios para garantizar el acceso de los usuarios a las atenciones médicas y prestaciones de especialidades requeridas, asegurando que se cumplan los flujos establecidos para la asignación de citas, derivaciones y coordinación entre niveles de atención.

d. Postas Rurales: centros de atención primaria ubicados en áreas geográficas remotas. Desempeñan un papel crucial en el acceso a la atención médica para aquellos que residen en zonas rurales, ofreciendo servicios de atención básicos.

Esta forma de contacto requiere considerar el recurso humano encargado de brindar la atención presencial, quienes deben contar con las herramientas necesarias para proporcionar una atención integral que se ajuste a las características y necesidades individuales de cada usuario.

1.2. Visita domiciliaria institucional: esta modalidad consiste en la visita física de profesionales de salud al domicilio del usuario como intento de contacto con este, con el respaldo de la acción en bitácora de los móviles institucionales. Aunque destaca por la eficiencia en términos de entrega de mensajes y servicios personalizados, la masividad se ve limitada por la inversión de tiempo, información de domicilios actualizados y recursos necesarios para llevar a cabo cada visita.

1.3. Visita domiciliaria externalizada: implica la visita física de personal externo o agencias especializadas al domicilio del usuario, usualmente contratado por el establecimiento de salud, dejando respaldos de la acción en la bitácora de los móviles. Debido a que estos actores externos no tienen acceso a datos sensibles de los usuarios (como historiales clínicos o diagnósticos), su rol se limita a funciones administrativas básicas, como verificar la residencia, entregar información general o registrar intentos de contacto, dejando constancia de la acción en la bitácora de los móviles.

2. A Distancia:

2.1. Llamado telefónico: consiste en contactar con el usuario o persona responsable de sus cuidados mediante una llamada de un ejecutivo telefónico a través de un teléfono de uso institucional, que abarca diversos ámbitos de seguimiento, aclaración de dudas y asesoramiento, permitiendo recoger información más precisa sin la necesidad de desplazamiento por parte del usuario. Si bien es una forma de contactabilidad muy efectiva y personalizada, que permite una comunicación bidireccional en tiempo real sincrónico, cada llamada consume horas de recurso humano capacitado, limitando a las horas de contrato disponible en cada establecimiento. Además, requiere de números de teléfonos válidos y vigentes, y de un operador capacitado que ejecute la llamada, y por consecuencia, su universo a contactar es reducido. Deben realizarse al menos tres intentos de contactabilidad, a todos los números telefónicos registrados, en días y horarios diferentes, considerando un intento de contacto inhábil.

2.2. Mensajería instantánea: la mensajería instantánea es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas que están conectados a internet o a una red local. A través de aplicaciones o plataformas, los usuarios pueden enviar y recibir mensajes de texto, imágenes, videos, documentos y realizar llamadas de voz o video. Entre las aplicaciones más utilizadas se encuentran: WhatsApp y Telegram, entre otras. En este contexto, esta forma de contacto ofrece una interacción directa con personal capacitado, lo que garantiza una atención personalizada y eficaz.

Sin embargo, este no es un canal habilitado para compartir información sensible. En su lugar, se debe proporcionar al usuario un enlace al portal paciente, donde pueda actualizar o gestionar su información de manera segura. Además, las cuentas utilizadas deben corresponder exclusivamente a cuentas de uso institucional, configuradas con medidas de seguridad robustas para proteger la información y garantizar la confidencialidad. Las aplicaciones de mensajería utilizadas deben cumplir con estándares de seguridad adicionales que incluyan el uso de cifrado de extremo a extremo, tales como plataformas de mensajería instantáneas para empresas (como por ejemplo WhatsApp Business), autenticación en dos pasos para cuentas institucionales, control de acceso limitado a personal autorizado, mensajes temporales, restricción de copias de seguridad en servicios no cifrados y capacitación del personal para el manejo seguro de la mensajería y la identificación de amenazas.

2.3. Correo electrónico: este canal proporciona la capacidad de enviar y recibir información a un grupo específico de usuarios a través de sus direcciones de correo electrónico, todo gestionado por personal capacitado. Proporciona una vía de comunicación directa de forma asincrónica con

el personal clínico o administrativo, lo que facilita la obtención de respuestas a las consultas o requerimientos de los usuarios. Hay que considerar que por este medio no debe compartirse información sensible, y, por lo tanto, debe incorporarse el enlace al portal paciente para que el usuario actualice su información. Para garantizar la seguridad en el uso del correo electrónico, las casillas deben ser estrictamente institucionales y configuradas con medidas como cifrado de extremo a extremo (TLS), autenticación en dos pasos, control de acceso limitado a personal autorizado, escaneo automático de archivos adjuntos y enlaces, restricción de reenvíos no autorizados y políticas de retención y eliminación segura de correos.

2.4. Mensajería de texto SMS (Servicio de mensajes cortos): permite enviar y recibir mensajes de texto breves entre teléfonos móviles. Esta forma de contacto ofrece una interacción directa con un ejecutivo capacitado, lo que garantiza una atención personalizada y eficaz. Hay que considerar que por este medio no debe compartirse información sensible y, por lo tanto, debe incorporarse el enlace al portal paciente para que el usuario actualice su información. Además, los números de contacto utilizados deben ser exclusivamente institucionales, por lo que se recomienda implementar medidas como autenticación del remitente (SMS Sender ID – nombre o número que se muestra en la pantalla del teléfono del destinatario para identificar quién envió el mensaje), protección de dispositivos con PIN o biometría y monitoreo de actividad para garantizar un uso seguro.

2.5. Carta certificada: es un tipo de envío postal que se utiliza para enviar documentos importantes o correspondencia legal de manera segura y con una confirmación de entrega. La eficiencia en la entrega es alta, pero depende de contar con una dirección actualizada. Su masividad y el impacto son limitados por los altos costos y tiempos de envío.

2.6. Mensajería de texto SMS (Servicio de mensajes cortos) por IA (Inteligencia artificial): permite enviar y recibir mensajes de texto breves entre teléfonos móviles de forma masiva y automatizada a un amplio número de usuarios con alta eficiencia y a bajo costo, aunque la personalización y bidireccionalidad son limitadas. Hay que considerar que por este medio no debe compartirse información sensible, y, por lo tanto, debe incorporarse el enlace al portal paciente para que el usuario actualice su información. Debe corresponder a un teléfono de uso institucional.

La seguridad en el uso de mensajería SMS con IA debe incluir medidas como la autenticación del remitente (SMS Sender ID), encriptación de los sistemas de gestión y un filtrado riguroso de respuestas automatizadas para evitar el intercambio de información sensible. Además, es fundamental implementar monitoreo continuo para detectar comportamientos anómalos y prevenir ataques como el adversarial machine learning que manipula el modelo de IA (posibles manipulaciones o datos de entrada a un algoritmo entrenado, que un atacante ha modificado para provocar que el algoritmo cometa un error en la predicción). Los modelos deben ser evaluados periódicamente para asegurar su precisión y evitar sesgos que comprometan la calidad del servicio. Además, se debe garantizar que los modelos de IA operen bajo estrictas políticas de privacidad y cumplan con normativas vigentes. Finalmente, es esencial realizar pruebas de resiliencia para detectar vulnerabilidades en los sistemas de IA antes de que sean explotadas, asegurando que las interacciones sean seguras y cumplan con los estándares de protección de datos.

2.7. Correo electrónico por IA: ofrece la capacidad de enviar información detallada a un gran número de usuarios simultáneamente a través de sus direcciones de correo electrónico de forma automatizada, con la posibilidad de personalizar mensajes a grupos específicos. Hay que considerar que por este medio no debe compartirse información sensible y, por lo tanto, debe incorporarse el enlace al portal paciente para que el usuario actualice su información. Debe corresponder a una casilla de correo de uso institucional.

En cuanto a la seguridad y el uso de modelos de IA en el correo electrónico, es esencial implementar medidas como la autenticación del remitente (para garantizar la identidad institucional), encriptación de los sistemas de gestión de correo para proteger los datos almacenados y transmitidos y filtrado de respuestas automatizadas para evitar el intercambio de información sensible. Además, el uso de IA puede estar expuesto a ataques como el "adversarial machine learning", por lo que se debe implementar monitoreo continuo para detectar anomalías y pruebas de resiliencia que aseguren que los modelos sean robustos y fiables. Los modelos de IA deben operar bajo estrictas políticas de privacidad, asegurando el cumplimiento de ley de protección de datos.

2.8. Mensajería Instantánea por IA: la mensajería instantánea mediante IA permite a los usuarios enviar y recibir mensajes personalizados y automatizados mediante inteligencia artificial, ofreciendo una experiencia de alta masividad y personalización. Hay que considerar que por este medio no debe compartirse información sensible, y, por lo tanto, debe incorporarse el enlace al portal paciente para que el usuario actualice su información. Además, la cuenta utilizada para este servicio debe ser exclusivamente institucional y configurada con medidas de seguridad adecuadas.

La seguridad en el uso de IA en mensajería instantánea requiere medidas específicas para mitigar los riesgos asociados con el procesamiento masivo de datos. Estas incluyen la autenticación de la cuenta institucional, asegurando que solo el personal autorizado pueda interactuar con los usuarios a través de la plataforma. Además, el uso de cifrado de extremo a extremo es esencial para proteger la privacidad de las comunicaciones y garantizar que los datos no sean accesibles durante su transmisión. Se debe implementar un filtrado de mensajes automatizados para evitar el intercambio de información sensible, así como monitoreo continuo de las interacciones para detectar comportamientos inusuales o posibles vulnerabilidades en el sistema. Las plataformas de mensajería deben cumplir con normativas de privacidad, asegurando el manejo adecuado de los datos personales. Finalmente, es necesario realizar pruebas de resiliencia para garantizar que los modelos de IA sean seguros y confiables, minimizando los riesgos de manipulación o fallos del sistema.

2.9. Llamado telefónico por IA: utiliza sistemas automatizados para realizar llamadas telefónicas, permitiendo una cierta personalización en los mensajes y la capacidad de gestionar respuestas básicas. Debe corresponder a un teléfono de uso institucional. Se debe garantizar que las llamadas se realicen exclusivamente desde teléfonos de uso institucional, asegurando que los usuarios reciban una atención adecuada.

2.10. Portal paciente: proporciona un espacio digital centrado en la persona en donde los usuarios pueden acceder y compartir su información de salud de forma segura y confidencial[29]. En este espacio el usuario, con previa validación de su identidad, encuentra una alta personalización y bidireccionalidad comunicacional, que les permite interactuar, actualizar datos, informar nuevos antecedentes y solicitar información complementaria de manera asincrónica. Para mayores detalles revisar anexo N°6: requisitos mínimos para la implementación de portales paciente.

2.11. Información por vía radial: se lleva a cabo mediante convocatoria radial (difusión local). Su finalidad es lograr que el usuario actualice su información por los canales disponibles o se acerque al establecimiento para entregarle información sobre su prestación de salud. Se utiliza principalmente en territorios con difícil acceso y que no tienen coberturas de otros medios de

[29] Pan American Health Organization. (2021). Secure, Interoperable Patient Portals with Quality Data. https://iris.paho.org/handle/10665.2/55407

contacto. El medio de respaldo es la grabación de la emisión del mensaje o la bitácora de la radio. Solo en el caso de agendas y citas puede ser utilizado como medio validador de egreso de registros de espera No GES, cuando se han efectuado los intentos de contacto por los demás medios. La entrega de información mediante difusión por vía radial debe ser limitada a contextos muy específicos y entornos donde el alcance de otros medios de comunicación se ven limitados.

2.12. Videollamadas: las videollamadas permiten una interacción cara a cara virtual, combinando la comodidad de la comunicación no presencial con un alto nivel de personalización y bidireccionalidad. La eficiencia de contacto es alta, ya que se pueden abordar dudas, realizar diagnósticos visuales y proporcionar asesoramiento en tiempo real sin las barreras geográficas.

2.13. Campañas masivas de información: maximizan la masividad al difundir información general y no personalizada a través de diversos medios publicitarios, tales como: medios impresos (periódicos y revistas), redes sociales, sitios web, entre otros.

2.14. Redes sociales: las redes sociales permiten facilitar la interacción y el intercambio de información entre individuos, grupos y organizaciones. Dado el riesgo de seguridad de información su propósito principal debería considerar captar atención y educar a la comunidad, responder consultas públicas y promover eventos o campañas de salud. Debe corresponder a una cuenta institucional.

3. Sobre los Modelos de IA

Es imprescindible que los modelos de inteligencia artificial (IA) implementados en los canales automatizados para la contactabilidad cuenten con condiciones contractuales claras que garanticen una respuesta oportuna y eficaz ante incidentes. Estas cláusulas deben detallar los procedimientos específicos para gestionar fallos del sistema, brechas de seguridad u otros incidentes que comprometan la operación o la protección de los datos. Además, los contratos deben establecer de manera explícita las responsabilidades, los plazos de respuesta y las medidas correctivas necesarias para resolver cualquier problema de forma efectiva.

Contar con estas disposiciones asegura que los proveedores de IA asuman compromisos claros de soporte, protejan la continuidad del servicio y garanticen la seguridad de los datos sensibles. Asimismo, permite establecer mecanismos legales que respalden a las organizaciones para exigir cumplimiento en caso que los incidentes no sean gestionados adecuadamente, minimizando riesgos y fortaleciendo la confianza en la operación de los sistemas automatizados.

Es igualmente crucial incorporar medidas específicas para mitigar los riesgos asociados al procesamiento masivo de datos, incluyendo el monitoreo continuo de las interacciones para identificar comportamientos inusuales o vulnerabilidades en el sistema. Adicionalmente, deben realizarse pruebas de resiliencia periódicas para asegurar que los modelos de IA sean robustos y confiables, minimizando los riesgos de manipulación, errores o fallos en su funcionamiento.

Por último, es necesario dar cumplimiento a la Circular N° 711 de diciembre de 2023, emitida por la SEGPRES, que establece lineamientos para el uso de herramientas de IA en el sector público. Este marco proporciona directrices para una implementación ética, segura y transparente de estas tecnologías, promoviendo la protección de derechos, la seguridad de la información y la transparencia en el manejo de datos. Asimismo, fomenta la eficiencia y mejora la calidad de los servicios públicos, asegurando que las aplicaciones de IA se alineen con los valores fundamentales de responsabilidad y servicio al ciudadano.

9.2. ANEXO N°2: FACTORES A CONSIDERAR PARA EVALUAR LOS TIPOS DE CANALES DE COMUNICACIÓN

Factor	Descripción Factor	Categorías	Descripción de categorías
Universo objetivo	Hace referencia al público alcanzado con la forma de contactabilidad.	Segmentación específica	Se enfoca en un grupo específico de usuarios con características muy particulares. Los datos segmentados incorporan un mínimo de 3 factores diferentes, que al menos contemple las dimensiones de tiempos de espera y clínica para obtener un grupo específico de usuario a contactar.
		Segmentación diversificada	Segmenta datos considerando uno o dos factores como máximo, estos grupos son menos específicos para estrategias de mayor volumen.
		Masiva	Segmentación de datos dirigida a la totalidad o casi la totalidad del universo de usuarios.
Costo por Interacción	Esta métrica se centra en el costo directo asociado a cada interacción individual con un usuario. Incluye, pero no se limita a: costos de personal, tecnológicos, y de infraestructura necesarios para realizar un contacto efectivo.	Costo bajo	Indica un menor costo por interacción, lo que sugiere una alta eficiencia económica. Este nivel puede ser resultado de una fuerte automatización o de sistemas altamente optimizados que minimizan el uso de recursos elevados.
		Costo medio	Indica un costo promedio por interacción, reflejando una inversión equilibrada en recursos humanos y tecnológicos. Este nivel de costo sugiere una mezcla de personalización y eficiencia, posiblemente ajustándose a estándares de calidad y satisfacción del usuario.
		Costo alto	Señala un costo superior al promedio por interacción, lo que puede indicar una inversión significativa en personalización y calidad de la comunicación. Este nivel puede reflejar una dependencia mayor de recursos humanos y tecnologías avanzadas, justificada por la búsqueda de mejoras en la satisfacción y los resultados del usuario.
Dependiente de Recursos Humanos (RRHH)	Señala si el proceso de contactabilidad depende en gran medida de la ejecución por parte de un funcionario de la red.	Dependiente	Efectividad de la comunicación depende significativamente del personal.
		No dependiente	La comunicación se gestiona a través de sistemas automatizados, sin el requerimiento de recursos humanos.
Tipo de comunicación entre emisor y receptor	El tipo de comunicación entre el emisor y el receptor se refiere a la capacidad de la vía de comunicación para permitir tanto la recepción como la entrega de información de manera fluida. Además, se evalúa la flexibilidad para adaptar el intercambio de información en función de la disponibilidad de datos.	Unidireccional	La comunicación unidireccional ocurre cuando la información fluye en una sola dirección, desde el emisor hacia el receptor, sin que este último tenga la oportunidad de responder o interactuar directamente con el emisor del mensaje recibido. Este tipo de comunicación es típico de los anuncios, las alertas y las notificaciones, donde el objetivo principal es informar o instruir.
		Bidireccional administrativo	En la comunicación bidireccional entre el usuario y el personal administrativo, el emisor y el receptor pueden intercambiar información general (sin detalles sobre información clínica), permitiendo una interacción directa con preguntas, respuestas y retroalimentación con índole administrativa.
		Bidireccional clínico-administrativo	En la comunicación bidireccional entre el usuario y el personal clínico-administrativo, el emisor y receptor pueden intercambiar información más detallada y de índole clínica, permitiendo una interacción directa con preguntas, respuestas y retroalimentación. Este tipo facilita una conversación más detallada y puede adaptarse según la reacción o las necesidades del receptor.

Tipo de comunicación	Este aspecto se refiere a si la modalidad de comunicación posibilita la entrega de información y retroalimentación de manera inmediata al usuario.	Sincrónico	Comunicación en tiempo real. Mayor satisfacción del usuario y resolución inmediata de consultas.
		Asincrónico	Comunicación no simultánea. Mayor flexibilidad para el usuario, pero posibles retrasos en la respuesta.
Oportunidad permanente de información Bidireccional (desde el usuario)	Refleja la disponibilidad y accesibilidad que tiene el usuario para interactuar, hacer consultas, y recibir respuestas en cualquier momento. Este aspecto es crucial para evaluar la efectividad de los canales de comunicación en proporcionar soporte continuo y resolver dudas o problemas de los usuarios.	No cuenta con oportunidad	Indica que no hay disponibilidad para que el usuario inicie comunicación bidireccional. La vía de comunicación solo permite la recepción de información sin ofrecer ninguna opción para que el usuario haga preguntas, busque aclaraciones o reciba asistencia directa.
		Sí cuenta con oportunidad	Refleja que el usuario tiene la capacidad para obtener información de manera bidireccional. Puede contar con medios para realizar consultas o buscar asistencia. Los canales de comunicación están diseñados para ofrecer respuestas en tiempos de respuesta razonables, precisas y personalizadas.
Registros verificables del contacto	Se centra en la capacidad de una vía de comunicación para producir evidencia tangible o digital de que se ha realizado una interacción. Estos registros (Log) son fundamentales para asegurar la transparencia, permitir el seguimiento de las comunicaciones, validar egresos y facilitar procesos de mejora continua.	No cuenta con registro verificable	Indica que la vía de contacto utilizada no proporciona ningún medio para generar o conservar pruebas de la comunicación realizada. Esto puede limitar la capacidad de demostrar que se ha hecho un intento de contacto o de verificar el contenido de la comunicación. Métodos como las campañas publicitarias entran en esta categoría, ya que no entrega posibilidad de registro de la interacción.
		Si cuenta con registro	Denota una capacidad constante y fiable para producir evidencia de cada interacción, independientemente de las circunstancias. Métodos como las cartas certificadas, correos electrónicos con acuse de recibo que registran automáticamente las interacciones, caen dentro de esta categoría, entre otros.
Personalización de la atención	Evalúa hasta qué punto se puede ajustar y adaptar la comunicación a las necesidades, preferencias y características individuales de cada usuario. Este enfoque personalizado no solo mejora la percepción del usuario sobre la calidad del servicio, sino que también puede aumentar significativamente la efectividad de la comunicación y la satisfacción general.	Baja	Refleja un nivel limitado de personalización, donde puede haber un esfuerzo mínimo por adaptar la comunicación a grupos específicos de usuarios basándose en características muy generales o categorías amplias (como la edad o el tipo de servicio utilizado), pero sin un enfoque en la individualización.
		Media	Denota una personalización moderada, donde la comunicación se ajusta en función de información más detallada sobre el usuario, como historial médico, preferencias comunicativas previamente expresadas o comportamientos anteriores. Hay un esfuerzo por hacer que la comunicación sea más relevante y efectiva para el individuo, aunque aún puede haber margen para una mayor individualización.
		Alta	Indica un alto grado de personalización, donde la comunicación se adapta de manera significativa a las necesidades, preferencias, e historia individual del usuario. Esto puede incluir la personalización del tono, contenido, canal de comunicación preferido y oportuno, basado en el conocimiento detallado del usuario.

Administración de confidencialidad de los datos	Se centra en evaluar cómo la vía de comunicación permite manejar y limitar la información que se puede compartir, respetando la confidencialidad y la privacidad de los datos personales y clínicos del usuario. Este enfoque recalca la importancia de equilibrar el acceso a la información necesaria para la atención y el soporte, sin comprometer la seguridad de los datos sensibles.	No Aplica	La comunicación no implica compartir datos personales o sensibles, enfocándose en información general que no requiere consideraciones especiales de privacidad. Ejemplos incluyen campañas publicitarias de salud pública o anuncios educativos.
		Si, entrega confidencialidad	Se permite un nivel de detalle mayor en la información compartida, incluyendo aspectos específicos de la prestación de salud al usuario, bajo estrictas medidas de seguridad. Esto podría incluir información sobre citas, tratamientos programados o recordatorios, asegurando que toda divulgación de datos esté justificada y sea segura.
Atributo para egreso o una excepción o cierre de garantías según normativa GES vigente.	Establece la factibilidad de la vía de comunicación de capturar la información necesaria para validar la generación de la salida del registro de espera de la prestación de salud.	Sí cuenta con factibilidad de egreso o una excepción o cierre de garantías según normativa GES vigente	La vía de comunicación permite la generación de salida del registro debido a que al menos captura la siguiente información: comprobación de la identidad del usuario, seguridad del medio de comunicación (integridad, autenticidad y confidencialidad del mensaje), generación de evidencia que permita comprobar la comunicación, su contenido y conservación, junto con la factibilidad de trazabilidad del mensaje.
		No cuenta con factibilidad de egreso o una excepción o cierre de garantías según normativa GES vigente	La vía de comunicación no permite la generación de salida del registro debido a que no cuenta con lo establecido para su validación según la normativa vigente.

9.3. ANEXO N°3: MATRIZ DE EVALUACION DE CANALES DE COMUNICACIÓN

CONSIDERACIONES	FORMAS DE GESTIÓN DEL CONTACTO													
	CONCURRENCIA DEL USUARIO	VISITA DOMICILIARIA INSTITUCIONAL	VISITA DOMICILIARIA EXTERNALIZADA	LLAMADO TELEFONICO DIRECTO	CARTA CERTIFICADA	MENSAJERIA DE TEXTO (IA)	CORREO ELECTRONICO (IA)	CORREO ELECTRONICO DIRECTO	MENSAJERIA INSTANTÁNEA (IA)	MENSAJERIA INSTANTÁNEA DIRECTA	LLAMADO TELEFONICO (IA)	PORTAL PACIENTE GESTIÓN DE CASO DEL USUARIO	VIA RADIAL	CAMPAÑAS
UNIVERSO OBJETIVO	SEGMENTACIÓN ESPECÍFICA	SEGMENTACIÓN DIVERSIFICADA	SEGMENTACIÓN DIVERSIFICADA	SEGMENTACIÓN ESPECÍFICA	SEGMENTACIÓN DIVERSIFICADA	MASIVA	MASIVA	SEGMENTACIÓN ESPECÍFICA	MASIVA	SEGMENTACIÓN ESPECÍFICA	MASIVA	MASIVA	SEGMENTACIÓN ESPECÍFICA	MASIVA
COSTO POR INTERACCIÓN	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	ALTO	ALTO
DEPENDIENTE DE RRHH	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO
TIPO DE COMUNICACION ENTRE EMISOR Y RECEPTOR	BIDIRECCIONAL CLINICO-ADMNISTRATIVO	BIDIRECCIONAL ADMINISTRATIVA	UNIDIRECCIONAL	BIDIRECCIONAL CLINICO-ADMNISTRATIVO	UNIDIRECCIONAL	UNIDIRECCIONAL	UNIDIRECCIONAL	BIDIRECCIONAL CLINICO-ADMNISTRATIVO	UNIDIRECCIONAL	BIDIRECCIONAL CLINICO-ADMNISTRATIVO	UNIDIRECCIONAL	BIDIRECCIONAL ADMINISTRATIVA	UNIDIRECCIONAL	UNIDIRECCIONAL
TIPO DE TEMPORALIDAD EN COMUNICACION	SINCRONICO	SINCRONICO	SINCRONICO	SINCRONICO	ASINCRONICO	ASINCRONICO	ASINCRONICO	ASINCRONICO	ASINCRONICO	SINCRONICO	ASINCRONICO	ASINCRONICO	ASINCRONICO	ASINCRONICO
OPORTUNIDAD PERMANENTE DE INFOR. BIDIRECCIONAL	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
REGISTROS VERIFICABLES DEL CONTACTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
PERSONALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	BAJA	BAJA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	BAJA
ADMINISTRACION DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA
POSIBILIDAD DE EGRESO O EXCEPCIÓN O CIERRE DE GARANTÍA GES.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SOLO EN AGENDAS Y CITAS EXTRAORDINARIAS	NO

9.4. ANEXO N°4: SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD

La implementación de los scripts de contactabilidad debe ser acorde a las habilitantes disponibles y particularidades de cada contexto en cada establecimiento. Además, se debe considerar la incorporación de modelos de escalas de evaluación acordes a la prestación en espera y la especialidad correspondiente.

9.4.1. SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD PARA EL SUBPROCESO DE VINCULACIÓN

Scripts de la Contactabilidad de Vinculación	• Script 1.1: correo electrónico IA. • Script 1.2: correo electrónico gestionado por una persona. • Script 1.3: mensajería instantánea IA. • Script 1.4: mensajería instantánea gestionada por una persona. • Script 1.5: mensajería de texto (SMS). • Script 1.6: llamado telefónico automatizado por IA. • Script 1.7: llamado telefónico gestionado por una persona. • Script 1.8: portal paciente.

SCRIPT 1.1: VINCULACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO IA

A. ASUNTO DEL CORREO:

"Información importante sobre su atención de salud en el (Nombre del establecimiento)"

B. CUERPO DEL CORREO:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para actualizar su información en nuestro sistema. Para ello, necesitamos que:

- *Confirme si aún presenta la necesidad de salud por la cual está esperando ser atendido/a.*
- *Verifique y actualice sus datos de contacto.*

Para actualizar su información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su pronta respuesta nos permitirá gestionar adecuadamente su solicitud y brindarle la mejor atención posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su atención y cooperación para mantener su información actualizada.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo; asistente virtual]
[Cargo; Unidad]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE Esta casilla de correo electrónico no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este correo. Para más información, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social) solo ignore este mensaje"

C. DETALLES ADICIONALES QUE PUEDEN INCORPORARSE AL FINAL DEL CORREO:

"Para garantizar la seguridad y confidencialidad de su información de salud, le solicitamos que siga las siguientes recomendaciones:

- *No comparta su información personal (como números de identificación, contraseñas o datos bancarios) a través de correo electrónico.*
- *Utilice una contraseña segura para acceder a su cuenta de correo electrónico y a cualquier portal de salud en línea.*
- *Verifique la autenticidad del remitente: nuestros correos oficiales siempre provienen de la dirección [dirección de correo oficial].*
- *Informe inmediatamente si nota alguna actividad sospechosa relacionada con su información de salud o si recibe correos electrónicos sospechosos.*
- *[en el caso de contar con el Compromiso de Vinculación y Comunicación en formato digital y ya firmado por el usuario o persona bajo cuyo cuidado se encuentre, se puede adjuntar al correo electrónico]".*

D. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios los medios de contacto con el establecimiento.

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social)

Recuerde que la casilla de correo electrónico no está habilitada para recibir mensajes, por lo que le solicitamos que no responda a este correo. Para actualizar su información o realizar consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente"

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

(Nombre del establecimiento)"

SCRIPT 1.2: VINCULACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA

A. ASUNTO DEL CORREO:

"Información importante sobre su atención de salud en el (Nombre del establecimiento)"

B. CUERPO DEL CORREO:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para actualizar su información en nuestro sistema. Para ello, necesitamos que:

- *Confirme si aún presenta la necesidad de salud por la cual está esperando ser atendido/a.*
- *Verifique y actualice sus datos de contacto.*

Para actualizar su información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su pronta respuesta nos permitirá gestionar adecuadamente su solicitud y brindarle la mejor atención posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su atención y cooperación para mantener su información actualizada.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta casilla de correo electrónico no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este correo. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), solo ignore este mensaje".

C. DETALLES ADICIONALES QUE PUEDEN INCORPORARSE AL FINAL DEL CORREO:

"Para garantizar la seguridad y confidencialidad de su información de salud, le solicitamos que siga las siguientes recomendaciones:

- *No comparta su información personal (como números de identificación, contraseñas o datos bancarios) a través de correo electrónico.*
- *Utilice una contraseña segura para acceder a su cuenta de correo electrónico y a cualquier portal de salud en línea.*
- *Verifique la autenticidad del remitente: nuestros correos oficiales siempre provienen de la dirección [dirección de correo oficial].*
- *Informe inmediatamente si nota alguna actividad sospechosa relacionada con su información de salud o si recibe correos electrónicos sospechosos.*
- *[en el caso de contar con el Compromiso de Vinculación y Comunicación en formato digital y ya firmado por el usuario o persona bajo cuyo cuidado se encuentre, se puede adjuntar al correo electrónico]".*

D. RESPUESTAS:

Las respuestas que se realicen mediante correo electrónico no deben compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación simple:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Agradecemos su respuesta. Para actualizar su información, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro correo anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]

[Cargo]

[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]

[Cargo]

[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Hemos recibido su solicitud de información adicional. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 1.3: VINCULACIÓN POR MENSAJERÍA INSTANTÁNEA IA

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para actualizar su información en nuestro sistema. Para ello, necesitamos que:

- *Confirme si aún presenta la necesidad de salud por la cual fue registrado/a.*
- *Verifique y actualice sus datos de contacto.*

Para actualizar su información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su pronta respuesta nos permitirá gestionar adecuadamente su solicitud y brindarle la mejor atención posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su atención y cooperación para mantener su información actualizada.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta cuenta de mensajería instantánea no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este mensaje. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), solo ignore este mensaje"

C. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios los medios de contacto con el establecimiento.

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Recuerde que esta cuenta de mensajería instantánea no está habilitada para recibir mensajes, por lo que le solicitamos que no responda a este mensaje. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal]"

Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 1.4: VINCULACIÓN POR MENSAJERÍA INSTANTÁNEA GESTIONADA POR UNA PERSONA.

A. MENSAJE INICIAL:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para actualizar su información en nuestro sistema. Para ello, necesitamos que:

- *Confirme si aún presenta la necesidad de salud por la cual está esperando ser atendido/a.*
- *Verifique y actualice sus datos de contacto.*

Para actualizar su información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su pronta respuesta nos permitirá gestionar adecuadamente su solicitud y brindarle la mejor atención posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos tu atención y cooperación para mantener su información actualizada.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta cuenta de mensajería instantánea no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este mensaje. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), solo ignore este mensaje"

D. RESPUESTAS:

Las respuestas que pueden desarrollarse mediante mensajería instantánea deben considerar que no se puede compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación simple:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Agradecemos su respuesta. Para actualizar su información, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro mensaje anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Hemos recibido su solicitud de información adicional. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 1.5: VINCULACIÓN POR MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS).

Por este medio se debe que considerar que el límite de caracteres permitidos corresponde a 160.

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre usuario del registro de espera o nombre social).

Necesitamos actualizar su información. Para ello, ingrese al portal paciente: [enlace].

(Nombre del establecimiento)"

B. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios los medios de contacto con el establecimiento.

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social).

Ante dudas contactar a su establecimiento de salud al [medio de contacto].

(Nombre del establecimiento)"

SCRIPT 1.6: VINCULACIÓN POR LLAMADO TELEFÓNICO POR IA.

A. MENSAJE INICIAL:

"Bienvenido al sistema de contacto de (Nombre del establecimiento). Esta es una llamada automática. Si usted es (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), presione 1. Si usted es el tutor o representante de (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), presione 2. Si usted no es (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social) ni su representante, presione 3"

B. RESPUESTAS Y FLUJO:

OPCIÓN SELECCIONADA	RESPUESTA
1	*"Gracias por confirmar su identidad. Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para actualizar su información en nuestro sistema. Para ello, necesitamos que:* • Confirme si aún presenta la necesidad de salud por la cual está esperando ser atendido/a. • Verifique y actualice sus datos de contacto. *Para actualizar su información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:* • Portal paciente: [enlace] • Teléfono: [número de teléfono y horarios] • Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]" *Su pronta respuesta nos permitirá gestionar adecuadamente su solicitud y brindarle la mejor atención posible.*
2	*"Gracias. Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para actualizar la información de su representado. Para ello, necesitamos que:* • Confirme si aún presenta la necesidad de salud por la cual está esperando ser atendido/a. • Verifique y actualice los datos de contacto de su representado. *Para actualizar la información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:* • Portal paciente: [enlace] • Teléfono: [número de teléfono y horarios] • Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]"
3	*"Entendemos que usted no es la persona que buscamos. Si usted conoce al (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social) favor avísele que lo estamos intentando ubicar del (Nombre del establecimiento)".*

C. MENSAJE DE CIERRE:

"Gracias por su tiempo. Si necesita más información, puede contactarnos a través de [proporcionar canales de contacto]. Esta llamada ha sido grabada para su seguridad".

D. NOTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:

- Asegurar de que el sistema por IVR (respuesta de voz interactiva) pueda manejar las diferentes opciones y redireccionar a los flujos correspondientes.
- Incluir opciones para repetir los mensajes si el usuario lo necesita.
- Asegurar de que el sistema pueda transferir la llamada a un agente humano si es factible.
- Cumplir con todas las regulaciones de privacidad y protección de datos al manejar información personal.

SCRIPT 1.7: VINCULACIÓN POR LLAMADO TELEFÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. PRESENTACIÓN:

"Buenos días / tardes, le llamo desde (Nombre del establecimiento), mi nombre es (nombre del agente)".

Respuestas:

a.1 Contesta: continuar con etapa B: "Identificación del usuario".

a.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

B. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

"Hablo con el/la Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social)"

Respuestas:

b.1 Contacto con usuario del registro de espera: continuar con etapa **C. "Motivo del contacto".**

b.2 Contacto con tutor: continuar con etapa **D. "Confirmación de usuario correcto:** Solicitud de datos del representante".

b.3 Contacto equivocado: continuar con etapa **E. "Solicitud de información del usuario:** contacto con un tercero".

b.4 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

C. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON USUARIO

"Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social), usted se encuentra en el registro de personas que esperan una prestación de salud de (detalle de la prestación en espera). La razón de este contacto es para confirmar si aún presenta su necesidad de salud, además de actualizar sus datos de contacto en el caso de ser necesario. Lo anterior, permitirá avanzar en la gestión de la resolución de su necesidad de salud, si usted aún la requiere.

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos que nos indique ningún dato de su cuenta bancaria, ni tampoco un número o código que podría llegar a su teléfono.

Si tiene consultas o dudas, puede visitar el sitio web [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social), ¿usted está en espera de una prestación de salud (detalle de la prestación en espera) en el establecimiento (Nombre del establecimiento)?"

Respuestas:

c.1 Si está a la espera. Continuar con etapa **G. "Verificación y actualización de datos personales".**

c.2 No está a la espera. Continuar con etapa **H. "Causal de egreso o excepción o cierre de garantía GES.".**

c.3 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

D. CONFIRMACIÓN DE USUARIO CORRECTO: SOLICITUD DE DATOS DEL REPRESENTANTE

"Sr./Sra. ¿Me podría indicar su nombre completo, RUT, parentesco y teléfonos fijo y móvil?"

Respuestas:

d.1 Contesta: continuar con etapa **F. "Motivo del contacto: contacto con representante".**

d.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

E. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL USUARIO: CONTACTO CON UN TERCERO

"Sr. / Sra. Nombre ¿puede comunicarme o tiene como ubicar a él/la Sr. /Sra. Nombre y apellidos (indicado en el registro de espera)?

Respuestas:

e.1 Contesta: registro del dato entregado y cierre **M. "Cierre del llamado: contacto con un tercero".**

e.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

F. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON REPRESENTANTE

"Sr./Sra. (Nombre del representante), el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) se encuentra en un registro de personas que esperan una prestación de salud en (Nombre de establecimiento). La razón de este contacto es para confirmar si el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) aún presenta la necesidad de salud, además de actualizar los datos de contacto en el caso de ser necesario. Lo anterior, permitirá iniciar la gestión de su solicitud, para la resolución de su necesidad de salud, esto, si el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) aún la requiere.

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos que nos indique ningún dato de su cuenta bancaria, ni tampoco un número o código que podría llegar a su teléfono.

Si tiene consultas o dudas, puede visitar el sitio web [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Sr./Sra. (Nombre representante), ¿el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) está en espera de una prestación de salud (nombre de la prestación en espera según detalle del registro) en el establecimiento?"

Respuestas:

f.1 Si está a la espera. Continuar con etapa **I. "Verificación y actualización de datos personales".**

f.2 No está a la espera. Continuar con etapa **J. "Causal de egreso o excepción o cierre de garantía GES".**

f.3 No contesta/corta llamada: flujo

G. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

"Sr. /Sra. Nombre. Para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos:

- *RUN.*
- *Nombres (tal y como aparecen en su documento de identidad).*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Teléfonos fijo y móviles.*
- *Correo electrónico*
- *Previsión de salud"*

Respuestas:

g.1 Contesta: continuar con etapa **K. "Cierre del llamado: contacto con el usuario".**

g.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

H. CAUSAL DE EGRESO:

"Sr. / Sra. Nombre, ¿nos podría indicar cómo solucionó su necesidad de salud?"

Respuestas:

h.1 Contesta: continuar con etapa **G. Verificación y actualización de datos personales.**

h.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

I. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES: CONTESTA UN REPRESENTANTE.

"Sr. /Sra. Nombre (Nombre representante). Para tener una comunicación efectiva con el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos del Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social):

- *RUN.*
- *Nombres (tal y como aparecen en su documento de identidad).*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Previsión de salud del usuario del registro de espera.*

- *Teléfonos fijo y móviles del representante.*
- *Correo electrónico del representante".*

Respuestas:

i.1 Contesta: continuar con etapa **L. "Cierre del llamado: contacto con representante".**

i.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

J. CAUSAL DE EGRESO O EXCEPCIÓN O CIERRE DE GARANTÍA GES: RESPONDE EL REPRESENTANTE

"Sr. / Sra. Nombre (Nombre representante), ¿nos podría indicar cómo solucionó la necesidad de salud el/la Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social)?"

Respuestas:

j.1 Contesta: continuar con etapa **I. Verificación y actualización de datos personales.**

j.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

K. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON EL USUARIO

"Es importante que nos verifique por qué medio de contacto le es más cómodo u oportuno que lo contactemos y en qué horario. El (Nombre del establecimiento) tomará contacto con usted para la continuidad del proceso asistencial.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]"*

L. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON REPRESENTANTE

"Sr. / Sra. Nombre, hemos registrado los datos. Agradecemos mucho su tiempo.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]"*

M. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre, agradecemos su tiempo".

SCRIPT 1.8: VINCULACIÓN POR PORTAL PACIENTE.

A. INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Despliegue de formulario para cada prestación de salud en espera registrada, mostrar un formulario con las siguientes preguntas:

i. *"¿Usted está aún en espera de la prestación de salud descrita?"*

a. Si la respuesta es "Sí":

i. Se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, etc.). El objetivo principal será recopilar información que permita priorizar efectivamente el caso y evaluar requerimientos adicionales.

ii. Desplegar formulario de autoeficacia[30]: Medir la autoeficacia en usuarios es crucial porque esta percepción influye significativamente en la capacidad del individuo para manejar enfermedades, adherirse a tratamientos y realizar cambios de comportamiento necesarios para mejorar la salud. Una baja percepción está asociada con peores resultados de salud y mayor riesgo de morbimortalidad en las personas[31] (para más detalles del formulario propuesto revisar el Anexo N°7).

iii. Solicitar información sobre licencias médicas por la condición de salud ingresada en los últimos 2 meses.

b. Si la respuesta es "No": Desplegar formulario de egreso o excepción o cierre de garantía GES:

i. Mostrar selección de causales de egreso o excepción o cierre de garantía GES.

ii. Desplegar cuadro informativo sobre el egreso o excepción o cierre de garantía GES, solicitando confirmación.

iii. Mostrar segundo cuadro de verificación para confirmar el egreso o excepción o cierre de garantía GES.

iv. Procedimiento interno post-confirmación:

1. Enviar correo electrónico solicitando confirmación del no requerimiento de la prestación de salud (plazo de 5 días).

2. Realizar dos llamadas telefónicas en un plazo máximo de 5 días en distintos horarios, una de las cuales debe realizarse en horario inhábil.

3. Si no hay respuesta después de 5 días, proceder con el egreso o excepción o cierre de garantía GES basado en lo informado en el portal.

---

[30] Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy Scale. En J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON.

[31] González, C., & Calderón, C. (2009). Autoeficacia y su relación con la adhesión al tratamiento en pacientes crónicos en Chile. Revista Médica de Chile, 137(9), 1173-1180.

B. SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Proporcionar un campo para que el usuario registre información adicional.

i. *"¿Requiere algún tipo de información respecto a su prestación en espera?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar: Anular cita, confirmar cita, consultar estado de cita médica.*

ii. *"¿Requiere que el establecimiento se ponga en contacto?" Opciones: Sí, No*

iii. *"¿Cuál es su preferencia para ser contactado?" Opciones: Teléfono, Correo electrónico, Mensaje de texto, otro (especificar).*

iv. *"¿Cuál es el mejor momento para contactarle?" Opciones: Mañana, Tarde, Noche, Fin de semana, Horario laboral, Señalar horario y día.*

v. *"¿Cuál es su número de teléfono/correo electrónico actual?" (campo para actualizar información de contacto)*

C. SOLICITUDES ESPECÍFICAS

i. *"¿Tiene alguna preocupación específica que le gustaría resolver con el establecimiento?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

ii. *"¿Hay algún cambio reciente en su estado de salud que deba informarnos?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iii. *"¿Tiene alguna necesidad especial o preferencia que debamos considerar?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iv. *"¿Prefiere citas presenciales o telemedicina?" Opciones: presenciales, telemedicina, ambas.*

v. *"¿Requiere asistencia para su cita ya programada?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

vi. *"¿Le gustaría sugerir alguna mejora en nuestro servicio?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

D. CANALES DE COMUNICACIÓN

Mostrar de forma clara y visible los siguientes medios de contacto:

"Si tiene alguna pregunta o consulta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

a. *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
b. *Correo electrónico: [correo electrónico]*
c. *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
d. *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]"*

9.4.2. SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD PARA EL SUBPROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Scripts de la Contactabilidad de Monitoreo y seguimiento	• Script 2.0: correo electrónico gestionado por una persona. • Script 2.1: mensajería instantánea gestionada por una persona. • Script 2.2: mensajería de texto (SMS). • Script 2.3: llamado telefónico gestionado por una persona. • Script 2.4: portal paciente.

SCRIPT 2.0: MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR CORREO ELECTRÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. ASUNTO DEL CORREO:

"Seguimiento importante de su prestación de salud en (Nombre del establecimiento)"

B. CUERPO DEL CORREO:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para realizar un seguimiento personalizado durante su espera para recibir la atención que requiere.

Para poder brindarle un plan de atención más adaptado a sus necesidades actuales, le invitamos a actualizar su información personal de salud. Nos interesa conocer en detalle:

- *Si aún presenta la necesidad de salud por la cual fue registrado/a.*
- *Que verifique y actualice sus datos de contacto.*
- *[Para establecer un plan de gestión de la espera personalizado se deben considerar el tipo de prestación y especialidad, de esta forma se pueden incorporar modelos de escalas para conocer, por ejemplo, el estado de salud actual del usuario, experiencia en la gestión diaria de su salud, redes de apoyo con las que cuenta, percepción sobre el proceso de atención, entre otros].*

Para proporcionar esta información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su participación es fundamental para ofrecerle un cuidado más integral y adaptado a sus necesidades individuales.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su colaboración en este proceso de mejora continua de su atención de salud.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]

[Cargo]

[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta casilla de correo electrónico no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este correo. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera), solo ignore este mensaje".

C. DETALLES ADICIONALES QUE PUEDEN INCORPORARSE AL FINAL DEL CORREO:

"Para garantizar la seguridad y confidencialidad de su información de salud, le solicitamos que siga las siguientes recomendaciones:

- *No comparta su información personal (como números de identificación, contraseñas o datos bancarios) a través de correo electrónico.*
- *Utilice una contraseña segura para acceder a su cuenta de correo electrónico y a cualquier portal de salud en línea.*
- *Verifique la autenticidad del remitente: nuestros correos oficiales siempre provienen de la dirección [dirección de correo oficial].*
- *Informe inmediatamente si nota alguna actividad sospechosa relacionada con su información de salud o si recibe correos electrónicos sospechosos.*
- *[en el caso de contar con el Compromiso de Vinculación y Comunicación en formato digital y ya firmado por el usuario o persona bajo cuyo cuidado se encuentre, se puede adjuntar al correo electrónico].*

D. RESPUESTAS:

En las respuestas que se realicen mediante correo electrónico no se puede compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación si mple:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Agradecemos su respuesta. Para actualizar su información, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro correo anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]

[Cargo]

[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,
[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Hemos recibido su solicitud de información adicional. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,
[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 2.1: MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR MENSAJERÍA INSTANTÁNEA GESTIONADA POR UNA PERSONA.

A. MENSAJE INICIAL:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para realizar un seguimiento personalizado durante su espera para recibir la atención que requiere.

Para poder brindarle un plan de atención más adaptado a sus necesidades actuales, le invitamos a actualizar su información personal de salud. Nos interesa conocer en detalle:

- *Si aún presenta la necesidad de salud por la cual está esperando ser atendido/a.*
- *Que verifique y actualice sus datos de contacto.*

- *[para establecer un plan de gestión de la espera personalizado se deben considerar el tipo de prestación y especialidad, de esta forma se pueden incorporar modelos de escalas para conocer, por ejemplo, el estado de salud actual del usuario, experiencia en la gestión diaria de su salud, redes de apoyo con las que cuenta, percepción sobre el proceso de atención, entre otros].*

Para proporcionar esta información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su participación es fundamental para ofrecerle un cuidado más integral y adaptado a sus necesidades individuales.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su colaboración en este proceso de mejora continua de su atención de salud.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta cuenta de mensajería instantánea no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este mensaje. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera), solo ignore este mensaje"

D. RESPUESTAS:

Las respuestas que pueden desarrollarse mediante mensajería instantánea deben considerar que no se puede compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación simple:

"Estimado/a [Nombre del usuario],

Agradecemos su respuesta. Para actualizar su información, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro mensaje anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a [Nombre del usuario],

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Hemos recibido su solicitud de información adicional. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,
[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 2.2: MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS).

Por este medio se debe que considerar que el límite de caracteres permitidos corresponde a 160.

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre usuario del registro de espera).

Necesitamos actualizar su información. Para ello, ingrese al portal paciente: [enlace].

(Nombre del establecimiento)"

C. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios los medios de contacto con el establecimiento.

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera).

Ante dudas contactar a su establecimiento de salud al [medio de contacto].

(Nombre del establecimiento)"

SCRIPT 2.3: MONITOREO Y SEGUIMIENTO LLAMADO TELEFÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. PRESENTACIÓN:

"Buenos días / tardes, le llamo desde (Nombre del establecimiento), mi nombre es (Nombre del agente)".

Respuestas:

a.1 Contesta: continuar con etapa B: "Identificación del usuario".

a.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

B. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

"Hablo con el/la Sr./Sra. (Nombre completo del usuario tal y como consta en el registro de espera)"

Respuestas:

b.1 Contacto con usuario del registro de espera: continuar con etapa **C. "Motivo del contacto".**

b.2 Contacto con tutor: continuar con etapa **D. "Confirmación de usuario correcto: Solicitud de datos del representante".**

b.3 Contacto equivocado: continuar con etapa **E. "Solicitud de información del usuario: contacto con un tercero".**

b.4 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

C. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON USUARIO

"Sr./Sra. (Nombre usuario), le llamo desde (Nombre del establecimiento) para realizar un seguimiento personalizado durante su espera para recibir la atención de salud que consiste en (nombrar detalle según el registro de la prestación en espera).

Nuestro objetivo es brindarle un plan de atención más adaptado a sus necesidades actuales. Esto incluye: [se describe el plan de gestión de la espera personalizado se deben considerar el tipo de prestación y especialidad, de esta forma se pueden incorporar modelos de escalas para conocer, por ejemplo, el estado de salud actual del usuario, experiencia en la gestión diaria de su salud, redes de apoyo con las que cuenta, percepción sobre el proceso de atención, entre otros].

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos datos bancarios ni códigos de seguridad. Si tiene dudas, puede visitar [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Lo anterior, permitirá iniciar la gestión de su solicitud, para la resolución de su necesidad de salud, si es que usted aún la requiere".

Luego consultar:

"Sr./Sra. (Nombre usuario), ¿usted está en espera de una prestación de salud (detalle de la prestación en espera) en el establecimiento (Nombre del establecimiento)?"

Respuestas:

c.1 Si está a la espera. Continuar con etapa **G. "Verificación y actualización de datos personales y seguimiento".**

c.2 No está a la espera. Continuar con etapa **H. "Causal de egreso o excepción o cierre de garantía GES".**

c.3 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

D. CONFIRMACIÓN DE USUARIO CORRECTO: SOLICITUD DE DATOS DEL REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. ¿Me podría indicar su nombre completo, RUT, parentesco con (nombre del usuario registrado en espera), y teléfonos fijo y móvil?"

Respuestas:

d.1 Contesta: continuar con etapa **F. "Motivo del contacto: contacto con representante".**

d.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

E. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL USUARIO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre ¿puede comunicarme o tiene como ubicar a el/la Sr. /Sra. Nombre y apellidos (indicado en el registro de espera)?

Respuestas:

e.1 Contesta: registro del dato entregado y cierre **M. "Cierre del llamado: contacto con un tercero".**

e.2 No contesta: No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

F. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. (Nombre del representante), le llamo desde (Nombre del establecimiento) para realizar un seguimiento personalizado durante la espera para recibir la atención de salud que requiere el/la Sr./ Sra. (Nombre del usuario del registro de espera).

Nuestro objetivo es brindarle un plan de atención más adaptado a las necesidades actuales de Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera). Esto incluye: [se describe el plan de gestión de la espera personalizado se deben considerar el tipo de prestación y especialidad, de esta forma se pueden incorporar modelos de escalas para conocer, por ejemplo, el estado de salud actual del usuario, experiencia en la gestión diaria de su salud, redes de apoyo con las que cuenta, percepción sobre el proceso de atención, entre otros]. Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos datos bancarios ni códigos de seguridad. Si tiene dudas, puede visitar [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Lo anterior, permitirá iniciar la gestión de la solicitud, para la resolución de la necesidad de salud, esto, si el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera) aún la requiere"

Luego consultar:

"Sr./Sra. (Nombre representante), ¿el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera) está en espera de una prestación de salud (nombre de la prestación en espera según detalle del registro) en el establecimiento?"

Respuestas:

f.1 Si está a la espera. Continuar con etapa **I. "Verificación y actualización de datos personales y seguimiento".**

f.2 No está a la espera. Continuar con etapa **J. "Causal de egreso o excepción o cierre de garantía GES".**

f.3 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

G. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES.

"Sr. /Sra. Nombre. Para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos:

- *RUN.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Teléfonos fijo y móviles.*
- *Correo electrónico*
- *Previsión de salud.*

Para poder brindarle un plan de atención más adaptado a sus necesidades actuales, vamos a realizar algunas preguntas:

- *Conocer su estado de salud actual:*
  - *Para establecer un plan de gestión de la espera personalizado se deben considerar el tipo de prestación y especialidad, de esta forma se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, etc.). El objetivo*

principal será recopilar información que permita priorizar efectivamente el caso y evaluar requerimientos adicionales.

- *Desplegar formulario de autoeficacia: Medir la autoeficacia en usuarios es crucial porque esta percepción influye significativamente en la capacidad del individuo para manejar enfermedades, adherirse a tratamientos y realizar cambios de comportamiento necesarios para mejorar la salud. Una baja percepción está asociada con peores resultados de salud y mayor riesgo de morbimortalidad en las personas (para más detalles del formulario propuesto revisar el Anexo N°7).*
- *¿Ha tenido licencias médicas por la condición de salud (nombre de la prestación en espera según detalle del registro) en los últimos 2 meses?*
- *¿Cuenta con apoyo de familiares, amigos o recursos comunitarios?, de ser así, ¿Cuáles?*

Respuestas:

g.1 Contesta: continuar con etapa **K. "Cierre del llamado: contacto con el usuario".**

g.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

H. CAUSAL DE EGRESO O EXCEPCIÓN O CIERRE DE GARANTÍA GES:

"Sr. / Sra. Nombre, ¿nos podría indicar cómo solucionó su necesidad de salud?"

Respuestas:

h.1 Contesta: continuar con etapa **G. Verificación y actualización de datos personales.**

h.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

I. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES: CONTESTA UN REPRESENTANTE.

"Sr. /Sra. Nombre (No mbre representante). Para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos del Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera):

- *RUN.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Relación con el usuario en registro de espera.*
- *Previsión de salud del usuario del registro de espera.*
- *Teléfonos fijo y móviles del representante.*
- *Correo electrónico del representante".*

Además, para poder brindarle un plan de atención más adaptado a las necesidades actuales de Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera), vamos a realizar algunas preguntas:

- *Conocer el estado de salud actual del Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera):*
  - *Para establecer un plan de gestión de la espera personalizado se deben considerar el tipo de prestación y especialidad, de esta forma se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse dependiendo*

del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, etc.). El objetivo principal será recopilar información que permita priorizar efectivamente el caso y evaluar requerimientos adicionales.

- *Desplegar formulario de autoeficacia: Medir la autoeficacia en usuarios es crucial porque esta percepción influye significativamente en la capacidad del individuo para manejar enfermedades, adherirse a tratamientos y realizar cambios de comportamiento necesarios para mejorar la salud. Una baja percepción está asociada con peores resultados de salud y mayor riesgo de morbimortalidad en las personas (para más detalles del formulario propuesto revisar el Anexo N°7).*
- *¿El/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera) ha tenido licencias médicas por la condición de salud (nombre de la prestación en espera según detalle del registro) en los últimos 2 meses?*
- *¿Cuenta con apoyo de familiares, amigos o recursos comunitarios?, de ser así, ¿Cuáles?*

Respuestas:

i.1 Contesta: continuar con etapa **L. "Cierre del llamado: contacto con representante".**

i.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

J. CAUSAL DE EGRESO O EXCEPCIÓN O CIERRE DE GARANTÍA GES: RESPONDE EL REPRESENTANTE.

"Sr. / Sra. Nombre (Nombre representante), ¿nos podría indicar cómo solucionó la necesidad de salud el/la Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera)?"

Respuestas:

j.1 Contesta: continuar con etapa **I. Verificación y actualización de datos personales.**

j.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

K. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON EL USUARIO.

"Es importante que nos verifique por qué medio de contacto le es más cómodo u oportuno que lo contactemos y en qué horario. El (Nombre del establecimiento) tomará contacto con usted para la continuidad del proceso asistencial.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]"*

L. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON REPRESENTANTE.

"Sr. / Sra. Nombre, hemos registrado los datos. Agradecemos mucho su tiempo.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]"*

M. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre, agradecemos su tiempo".

SCRIPT 2.4: MONITOREO Y SEGUIMIENTO PORTAL PACIENTE.

A. INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Despliegue de formulario para cada prestación de salud en espera registrada, mostrar un formulario con las siguientes preguntas:

ii. *"¿Usted está aún en espera de la prestación de salud descrita?"*

a. *Si la respuesta es "Sí":*

i. *Para establecer un plan de gestión de la espera personalizado se deben considerar el tipo de prestación y especialidad, de esta forma se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, etc.). El objetivo principal será recopilar información que permita priorizar efectivamente el caso y evaluar requerimientos adicionales.*

ii. *Desplegar formulario de autoeficacia[32]: Medir la autoeficacia en usuarios es crucial porque esta percepción influye significativamente en la capacidad del individuo para manejar enfermedades, adherirse a tratamientos y realizar cambios de comportamiento necesarios para mejorar la salud. Una baja percepción está asociada con peores resultados de salud y mayor riesgo de morbimortalidad en las personas[33] (para más detalles del formulario propuesto revisar el Anexo N°7).*

iii. *Solicitar información sobre licencias médicas por la condición de salud ingresada en los últimos 2 meses.*

b. *Si la respuesta es "No": Desplegar formulario de egreso o excepción o cierre de garantía GES:*

i. *Mostrar selección de causales de egreso o excepción o cierre de garantía GES.*

ii. *Desplegar cuadro informativo sobre el egreso del registro, solicitando confirmación.*

iii. *Mostrar segundo cuadro de verificación para confirmar el egreso o excepción o cierre de garantía GES.*

iv. *Procedimiento interno post-confirmación:*

[32] Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy Scale. En J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON.

[33] González, C., & Calderón, C. (2009). Autoeficacia y su relación con la adhesión al tratamiento en pacientes crónicos en Chile. Revista Médica de Chile, 137(9), 1173-1180.

1. *Enviar correo electrónico solicitando confirmación del no requerimiento de la prestación de salud (plazo de 5 días).*
2. *Realizar dos llamadas telefónicas en un plazo máximo de 5 días.*
3. *Si no hay respuesta después de 5 días, proceder con el egreso o excepción o cierre de garantía GES basado en lo informado en el portal.*

B. SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Proporcionar un campo para que el usuario registre información adicional.

i. *"¿Requiere algún tipo de información respecto a su prestación en espera?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar: Anular cita, confirmar cita, consultar estado de cita médica.*

ii. *"¿Requiere que el establecimiento se ponga en contacto?" Opciones: Sí, No*

iii. *"¿Cuál es su preferencia para ser contactado?" Opciones: Teléfono, Correo electrónico, Mensaje de texto, otro (especificar).*

iv. *"¿Cuál es el mejor momento para contactarle?" Opciones: Mañana, Tarde, Noche, Fin de semana, Horario laboral, Señalar horario y día.*

v. *"¿Cuál es su número de teléfono/correo electrónico actual?" (Campo para actualizar información de contacto)*

C. SOLICITUDES ESPECÍFICAS

i. *"¿Tiene alguna preocupación específica que le gustaría resolver con el establecimiento?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

ii. *"¿Hay algún cambio reciente en su estado de salud que deba informarnos?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iii. *"¿Tiene alguna necesidad especial o preferencia que debamos considerar?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iv. *"¿Prefiere citas presenciales o telemedicina?" Opciones: presenciales, telemedicina, ambas.*

v. *"¿Requiere asistencia para su cita ya programada?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

vi. *"¿Le gustaría sugerir alguna mejora en nuestro servicio?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

D. CANALES DE COMUNICACIÓN

Mostrar de forma clara y visible los siguientes medios de contacto:

"Si tiene alguna pregunta o consulta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

e. Teléfono: [número de teléfono y horarios]

f. Correo electrónico: [correo electrónico]

g. Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]

h. Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]"

9.4.3. SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD PARA EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE AGENDAS Y CITAS

Scripts de la Contactabilidad de Agendas y Citas	Agendamiento: • Script 3.0: correo electrónico gestionado por una persona. • Script 3.1: mensajería instantánea gestionada por una persona. • Script 3.2: mensajería de texto (SMS). • Script 3.3: llamado telefónico gestionado por una persona. • Script 3.4: portal paciente. Confirmación de citas: • Script 4.0: correo electrónico IA. • Script 4.1: correo electrónico gestionado por una persona. • Script 4.2: mensajería instantánea IA. • Script 4.3: mensajería instantánea gestionada por una persona. • Script 4.4: mensajería de texto (SMS). • Script 4.5: llamado telefónico automatizado por IA. • Script 4.6: llamado telefónico gestionado por una persona. • Script 4.7: portal paciente.

AGENDAMIENTO

En este evento de contactabilidad es relevante enviar un recordatorio y/o comprobante de la cita consensuada al usuario por los medios disponibles.

SCRIPT 3.0: AGENDAMIENTO POR CORREO ELECTRÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. ASUNTO DEL CORREO:

"Cupo disponible para su prestación de salud en el (Nombre del establecimiento)"

B. CUERPO DEL CORREO:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para informarle que tenemos un cupo disponible para la prestación de salud que usted está esperando.

Para poder brindarle los detalles específicos de la cita disponible, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales puede confirmar o rechazar la cita, recibir información sobre la preparación necesaria para su atención y obtener detalles.

Es de vital importancia que responda lo antes posible para asegurar su atención.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*

- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su pronta respuesta,

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta casilla de correo electrónico no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este correo. Para más información, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera), solo ignore este mensaje"

C. DETALLES ADICIONALES QUE PUEDEN INCORPORARSE AL FINAL DEL CORREO:

"Para garantizar la seguridad y confidencialidad de su información de salud, le solicitamos que siga las siguientes recomendaciones:

- *No comparta su información personal (como números de identificación, contraseñas o datos bancarios) a través de correo electrónico.*
- *Utilice una contraseña segura para acceder a su cuenta de correo electrónico y a cualquier portal de salud en línea.*
- *Verifica la autenticidad del remitente: nuestros correos oficiales siempre provienen de la dirección [dirección de correo oficial].*
- *Informa inmediatamente si nota alguna actividad sospechosa relacionada con su información de salud o si recibe correos electrónicos sospechosos.*
- *Cualquier cambio en su cita quedará registrado en nuestros sistemas.*
- *Nuestra central de llamados podría contactarle para confirmar su cita [indicar teléfonos del centro de llamados]. En ese caso, podría confirmar o rechazar la atención."*

D. RESPUESTAS:

Las respuestas que pueden desarrollarse mediante correo electrónico deben considerar que no se puede compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación simple:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Agradecemos su respuesta. Para agendar su cita, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro correo anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para agendar su cita, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,
[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Hemos recibido su solicitud de información adicional. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,
[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 3.1: AGENDAMIENTO POR MENSAJERÍA INSTANTÁNEA GESTIONADA POR UNA PERSONA.

A. MENSAJE INICIAL:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para informarle que tenemos un cupo disponible para la prestación de salud que usted está esperando.

Para poder brindarle los detalles específicos de la cita disponible, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales puede confirmar o rechazar la cita, recibir información sobre la preparación necesaria para su atención y obtener detalles.

Es de vital importancia que responda lo antes posible para asegurar su atención.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su pronta respuesta,

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta cuenta de mensajería instantánea no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este mensaje. Para más información, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), le rogamos que ignore este mensaje"

D. RESPUESTAS:

Las respuestas que pueden desarrollarse mediante mensajería instantánea deben considerar que no se puede compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación simple:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Agradecemos su respuesta. Para agendar su cita, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro mensaje anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Gracias por su interés en agendar su cita. Le recordamos que debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Hemos recibido su solicitud de agendamiento. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]

[Cargo]

[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 3.2: AGENDAMIENTO POR MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS).

Por este medio se debe que considerar que el límite de caracteres permitidos corresponde a 160.

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre usuario del registro de espera o nombre social).

Necesitamos agendar su cita. Para ello, ingrese al portal paciente: [enlace].

(Nombre del establecimiento)"

B. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios los medios de contacto con el establecimiento.

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera/nombre social).

Ante dudas contactar a su establecimiento de salud al [medio de contacto].

(Nombre Establecimiento)"

SCRIPT 3.3: AGENDAMIENTO POR LLAMADO TELEFÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. PRESENTACIÓN:

"Buenos días / tardes, le llamo desde (Nombre del establecimiento), mi nombre es (Nombre del agente)".

Respuestas:

a.1 Contesta: continuar con etapa **B: "Identificación del usuario".**

a.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

B. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

"Hablo con el/la Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social)"

Respuestas:

b.1 Contacto con usuario del registro de espera: continuar con etapa **C. "Motivo del contacto".**

b.2 Contacto con tutor: continuar con etapa **D. "Confirmación de usuario correcto: Solicitud de datos del representante".**

b.3 Contacto equivocado: continuar con etapa **E. "Solicitud de información del usuario: contacto con un tercero".**

b.4 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

C. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON USUARIO

"Sr./Sra. (Nombre usuario/nombre social), le llamo porque tenemos un cupo disponible para la prestación de salud de (detalle de la prestación en espera) que usted está esperando en nuestro establecimiento.

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos que nos indique ningún dato de su cuenta bancaria, ni tampoco un número o código que podría llegar a su teléfono.

Si tiene consultas o dudas, puede visitar el sitio web [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social), ¿usted aún requiere está prestación de salud (detalle de la prestación en espera) en el establecimiento (Nombre del establecimiento)?"

Respuestas:

c.1 Si está a la espera. Continuar con etapa G**. "Verificación, actualización de datos personales y agendamiento".**

c.2 No está a la espera. Continuar con etapa **H. "Causal de egreso o excepción o cierre de garantía GES.".**

c.3 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

D. CONFIRMACIÓN DE USUARIO CORRECTO: SOLICITUD DE DATOS DEL REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. ¿Me podría indicar su nombre completo, RUT, parentesco y Teléfonos fijo y móvil?"

Respuestas:

d.1 Contesta: continuar con etapa **F. "Motivo del contacto: contacto con representante".**

d.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

E. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL USUARIO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre ¿puede comunicarme o tiene como ubicar a el/la Sr. /Sra. Nombre y apellidos (indicado en el registro de espera)?

Respuestas:

e.1 Contesta: registro del dato entregado y cierre **M. "Cierre del llamado: contacto con un tercero".**

e.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

F. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. (Nombre del representante), el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera) se encuentra en una base de datos del establecimiento de personas que esperan una prestación de salud. La razón de este contacto es para informarle que tenemos un cupo disponible para la prestación de salud de (detalle de la prestación en espera) que el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera) está esperando en nuestro establecimiento.

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos que nos indique ningún dato de su cuenta bancaria, ni tampoco un número o código que podría llegar a su teléfono.

Si tiene consultas o dudas, puede visitar el sitio web [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Sr./Sra. (Nombre representante), ¿el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera) aún requiere la prestación de salud (nombre de la prestación en espera según detalle del registro) en el establecimiento?"

Respuestas:

f.1 Si está a la espera. Continuar con etapa **I. "Verificación, actualización de datos personales y agendamiento".**

f.2 No está a la espera. Continuar con etapa **J. "Causal de egreso o excepción o cierre de garantía GES".**

f.3 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

G. VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES Y AGENDAMIENTO.

"Sr. /Sra. Nombre. Antes de informarle sobre la cita, debemos verificar los siguientes datos para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud:

- *RUN.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Teléfonos fijo y móviles.*
- *Correo electrónico*
- *Previsión de salud.*

Luego continuar con el ofrecimiento del cupo disponible:

"Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social), tenemos un cupo disponible para su atención el día (fecha), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). El profesional que lo atenderá es (nombre del profesional). ¿Acepta esta fecha y hora para su atención?"

Respuestas:

g.1 Acepta cupo: continuar con etapa **K. "Instrucciones para la cita".**

g.2 No acepta el cupo: ofrecer alternativas si están disponibles o registrar el motivo del rechazo (postergación si corresponde según normativas vigentes).

g.3 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

H. CAUSAL DE EGRESO O EXCEPCIÓN O CIERRE DE GARANTÍA GES:

"Sr. / Sra. Nombre, ¿nos podría indicar cómo solucionó su necesidad de salud?"

Respuestas:

h.1 Contesta: continuar con etapa G. Verificación y actualización de datos personales.

h.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

I. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES: CONTESTA UN REPRESENTANTE.

"Sr. /Sra. Nombre (Nombre representante). Antes de informarle sobre la cita, debemos verificar los siguientes del Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social):

- *RUN.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Previsión de salud del usuario del registro de espera.*
- *Teléfonos fijo y móviles del representante.*
- *Correo electrónico del representante.*

Luego continuar con el ofrecimiento del cupo disponible:

"Sr./Sra. (Nombre representante), tenemos un cupo disponible para la atención del Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) el día (fecha), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). El profesional que lo atenderá es (nombre del profesional). ¿Acepta esta fecha y hora para la atención?"

Respuestas:

g.1 Acepta cupo: continuar con etapa **K. "Instrucciones para la cita".**

g.2 No acepta el cupo: ofrecer alternativas si están disponibles o registrar el motivo del rechazo (postergación si corresponde según normativas vigentes).

g.3 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

J. CAUSAL DE EGRESO O EXCEPCIÓN O CIERRE DE GARANTÍA GES: RESPONDE EL REPRESENTANTE.

"Sr. / Sra. Nombre (Nombre representante), ¿nos podría indicar cómo solucionó la necesidad de salud el/la Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social)?"

Respuestas:

j.1 Contesta: continuar con etapa **I. Verificación y actualización de datos personales.**

j.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

K. INSTRUCCIONES PARA LA CITA.

"Muchas gracias por su tiempo. Para la cita que agendamos, por favor tener en consideración lo siguiente:

- *Debe presentarse con un mínimo de 15 minutos de anticipación.*
- *Preparación para la cita: [informar la preparación necesaria dependiendo de la prestación de salud en espera].*
- *[Deberes del usuario con respecto a su atención de salud, según normativa vigente].*
- *[Aspectos administrativos a realizar antes de la atención]"*

Continuar con etapa L. Cierre del llamado: contacto con el usuario o M. Cierre del llamado: contacto con representante dependiendo del caso.

L. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON EL USUARIO.

"Sr./Sra. (Nombre usuario), hemos registrado su cita y actualizado sus datos [reforzar detalles de la hora agendada]. Si necesita cambiar o cancelar su cita, por favor háganoslo saber con al menos 24 horas de anticipación.

Si tiene alguna pregunta o necesita cambiar o cancelar su cita, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Sr. / Sra. Nombre, agradecemos su tiempo"

M. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON REPRESENTANTE.

"Sr. / Sra. Nombre, hemos registrado la cita del Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) [reforzar detalles de la hora agendada]. Si necesita cambiar o cancelar la cita, por favor háganoslo saber con al menos 24 horas de anticipación.

Si tiene alguna pregunta o necesita cambiar o cancelar la cita, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible].*

Sr. / Sra. Nombre, agradecemos su tiempo"

M. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre, agradecemos su tiempo".

SCRIPT 3.4: AGENDAMIENTO POR VINCULACIÓN POR PORTAL PACIENTE.

A. INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Despliegue de formulario para cada prestación de salud en espera registrada, mostrar un formulario con las siguientes preguntas:

i. *"¿Usted está aún en espera de la prestación de salud descrita?"*
   a. Si la respuesta es "Sí":
      i. AGENDAMIENDO: Informar sobre cupo disponible: "Tenemos un cupo disponible para la prestación de salud que tiene pendiente. ¿Desea agendar una cita para [fecha y hora del cupo disponible]?" Opciones: Sí, No.

1. Si la respuesta es "Sí": Proceder con el agendamiento y proporcionar detalles de la cita (fecha y hora, lugar específico, profesional que lo atenderá, preparación previa).
2. Si la respuesta es "No": Ofrecer alternativas si están disponibles o registrar el motivo del rechazo (postergación si corresponde según normativas vigentes).
3. Enviar comprobante de cita mediante correo electrónico y mensajería instantánea, dependiendo de disponibilidad.

b. Si la respuesta es "No": Desplegar formulario de egreso o excepción o cierre de garantía GES:

i. Mostrar selección de causales de egreso o excepción o cierre de garantía GES.

ii. Desplegar cuadro informativo sobre el egreso o excepción o cierre de garantía GES, solicitando confirmación.

iii. Mostrar segundo cuadro de verificación para confirmar el egreso o excepción o cierre de garantía GES.

iv. Procedimiento interno post-confirmación:

1. Enviar correo electrónico solicitando confirmación del no requerimiento de la prestación de salud (plazo de 5 días).
2. Realizar dos llamadas telefónicas en un plazo máximo de 5 días.
3. Si no hay respuesta después de 5 días, proceder con el egreso o excepción o cierre de garantía GES basado en lo informado en el portal.

B. SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Proporcionar un campo para que el usuario registre información adicional.

i. *"¿Requiere algún tipo de información respecto a su prestación en espera?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar: Anular cita, confirmar cita, consultar estado de cita médica.*

ii. *"¿Requiere que el establecimiento se ponga en contacto?" Opciones: Sí, No*

iii. *"¿Cuál es su preferencia para ser contactado?" Opciones: teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, otro (especificar).*

iv. *"¿Cuál es el mejor momento para contactarle?" Opciones: mañana, tarde, noche, fin de semana, horario laboral, señalar horario y día.*

v. *"¿Cuál es su número de teléfono/correo electrónico actual?" (Campo para actualizar información de contacto)*

C. SOLICITUDES ESPECÍFICAS

i. *"¿Tiene alguna preocupación específica que le gustaría resolver con el establecimiento?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

ii. *"¿Hay algún cambio reciente en su estado de salud que deba informarnos?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iii. *"¿Tiene alguna necesidad especial o preferencia que debamos considerar?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iv. *"¿Prefiere citas presenciales o telemedicina?" Opciones: presenciales, telemedicina, ambas.*

v. *"¿Requiere asistencia para su cita ya programada?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

vi. *"¿Le gustaría sugerir alguna mejora en nuestro servicio?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

D. CANALES DE COMUNICACIÓN

Mostrar de forma clara y visible los siguientes medios de contacto:

"Si tiene alguna pregunta o consulta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

a. *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*

b. *Correo electrónico: [correo electrónico]*

c. *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*

d. *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]"*

**Se debe enviar un comprobante al correo electrónico del usuario con la información registrada.*

E. INSTRUCCIONES PARA LA CITA.

"Muchas gracias por su tiempo. Para la cita que agendamos, por favor tener en consideración lo siguiente:

- *Debe presentarse con un mínimo de 15 minutos de anticipación.*
- *Preparación para la cita: [informar la preparación necesaria dependiendo de la prestación de salud en espera].*
- *[Deberes del usuario con respecto a su atención de salud, según normativa vigente].*
- *[Aspectos administrativos a realizar antes de la atención]"*

CONFIRMACIÓN DE CITAS

SCRIPT 4.0: CONFIRMACIÓN DE CITAS POR CORREO ELECTRÓNICO IA.

A. ASUNTO DEL CORREO:

"Aviso: confirmación de su cita en el (Nombre del establecimiento)"

B. CUERPO DEL CORREO:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social).

Tiene una atención agendada con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:

- *CONFIRMAR HORA [botón para dar click e informar la confirmación de citas].*
- *ANULAR HORA [botón para dar click e informar la anulación de citas].*

Es muy importante que confirme o anule su cita a la mayor brevedad posible. La confirmación nos permite asegurarnos de que recibirá la atención necesaria a tiempo, mientras que la anulación nos ayuda a ofrecer su espacio a otras personas que puedan necesitarlo. Su colaboración es esencial para mejorar la eficiencia de nuestro servicio y garantizar que todos nuestros usuarios reciban el mejor cuidado posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su atención y cooperación,

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social) solo ignore este mensaje"

C. DETALLES ADICIONALES QUE PUEDEN INCORPORARSE AL FINAL DEL CORREO:

"Para garantizar la seguridad y confidencialidad de su información de salud, le solicitamos que siga las siguientes recomendaciones:

- *No comparta su información personal (como números de identificación, contraseñas o datos bancarios) a través de correo electrónico.*
- *Utilice una contraseña segura para acceder a su cuenta de correo electrónico y a cualquier portal de salud en línea.*
- *Verifica la autenticidad del remitente: nuestros correos oficiales siempre provienen de la dirección [dirección de correo oficial].*
- *Informa inmediatamente si nota alguna actividad sospechosa relacionada con su información de salud o si recibe correos electrónicos sospechosos.*
- *Cualquier cambio en su cita quedará registrado en nuestros sistemas".*

D. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios la confirmación o anulación de su cita:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social),

Gracias por su interés en confirmar o anular su cita con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en

(lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:

- *CONFIRMAR HORA [botón para dar click e informar la confirmación de citas].*
- *ANULAR HORA [botón para dar click e informar la anulación de citas].*

Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

(Nombre del establecimiento)"

D1. RESPUESTA A UNA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A LA CITA AGENDADA:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social),

Su hora queda CONFIRMADA. La atención será el (día) a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento) con (detalle de la prestación en espera agendada).

Para su cita agendada, favor tener en consideración lo siguiente:

- *Debe presentarse con un mínimo de 15 minutos de anticipación.*
- *Preparación para la cita: [informar la preparación necesaria dependiendo de la prestación de salud en espera].*
- *[Deberes del usuario con respecto a su atención de salud, según normativa vigente].*
- *[Aspectos administrativos a realizar antes de la atención]"*

Muchas gracias por su tiempo".

D2. RESPUESTA A UNA ANULACIÓN DE CITA:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social),

Su hora queda ANULADA. Si necesita reagendar o buscar otra hora, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Muchas gracias por su tiempo".

SCRIPT 4.1: CONFIRMACIÓN DE CITAS POR CORREO ELECTRÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. ASUNTO DEL CORREO:

"Aviso: confirmación de su cita en el (Nombre del establecimiento)"

B. CUERPO DEL CORREO:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social).

Tiene una atención agendada con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:

- *CONFIRMAR HORA [botón para dar click e informar la confirmación de citas].*
- *ANULAR HORA [botón para dar click e informar la anulación de citas].*

Es muy importante que confirme o anule su cita a la mayor brevedad posible. La confirmación nos permite asegurarnos de que recibirá la atención necesaria a tiempo, mientras que la anulación nos ayuda a ofrecer su espacio a otras personas que puedan necesitarlo. Su colaboración es esencial para mejorar la eficiencia de nuestro servicio y garantizar que todos nuestros usuarios reciban el mejor cuidado posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su atención y cooperación,

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social) le rogamos que ignore este mensaje"

C. DETALLES ADICIONALES QUE PUEDEN INCORPORARSE AL FINAL DEL CORREO:

"Para garantizar la seguridad y confidencialidad de su información de salud, le solicitamos que siga las siguientes recomendaciones:

- *No comparta su información personal (como números de identificación, contraseñas o datos bancarios) a través de correo electrónico.*
- *Utilice una contraseña segura para acceder a su cuenta de correo electrónico y a cualquier portal de salud en línea.*
- *Verifique la autenticidad del remitente: nuestros correos oficiales siempre provienen de la dirección [dirección de correo oficial].*
- *Informe inmediatamente si nota alguna actividad sospechosa relacionada con su información de salud o si recibe correos electrónicos sospechosos.*
- *Cualquier cambio en su cita quedará registrado en nuestros sistemas".*

D. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios la confirmación o anulación de su cita:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social),

Gracias por su interés en confirmar o anular su cita con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:

- *CONFIRMAR HORA [botón para dar click e informar la confirmación de citas].*
- *ANULAR HORA [botón para dar click e informar la anulación de citas].*

Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

(Nombre del establecimiento)"

D1. RESPUESTA A UNA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A LA CITA AGENDADA:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social),

Su hora queda CONFIRMADA. La atención será el (día) a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento) con (detalle de la prestación en espera agendada).

Para su cita agendada, favor tener en consideración lo siguiente:

- *Debe presentarse con un mínimo de 15 minutos de anticipación.*
- *Preparación para la cita: [informar la preparación necesaria dependiendo de la prestación de salud en espera].*
- *[Deberes del usuario con respecto a su atención de salud, según normativa vigente].*
- *[Aspectos administrativos a realizar antes de la atención].*

Muchas gracias por su tiempo".

D2. RESPUESTA A UNA ANULACIÓN DE CITA:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social),

Su hora queda ANULADA. Si necesita reagendar o buscar otra hora, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Muchas gracias por su tiempo".

SCRIPT 4.2: CONFIRMACIÓN DE CITAS POR MENSAJERÍA INSTANTÁNEA IA.

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social). Le escribimos desde el (Nombre del establecimiento) para recordarle que tiene una cita agendada con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:

- *CONFIRMAR HORA [indicar opción para la confirmación de citas].*
- *ANULAR HORA [indicar opción para la anulación de citas].*

En caso de no poder asistir, por favor avísenos para ofrecer esta cita a otro usuario que la esté necesitando.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su atención y cooperación,

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), solo ignore este mensaje"

C. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios la confirmación o anulación de su cita:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social),

Gracias por su interés en confirmar o anular su cita con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:

- *CONFIRMAR HORA [indicar opción para la confirmación de citas].*
- *ANULAR HORA [indicar opción para la anulación de citas].*

Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

(Nombre del establecimiento)"

D1. RESPUESTA A UNA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A LA CITA AGENDADA:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social),

Su hora queda CONFIRMADA. La atención será el (día) a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento) con (detalle de la prestación en espera agendada).

Para su cita agendada, favor tener en consideración lo siguiente:

- *Debe presentarse con un mínimo de 15 minutos de anticipación.*
- *Preparación para la cita: [informar la preparación necesaria dependiendo de la prestación de salud en espera].*
- *[Deberes del usuario con respecto a su atención de salud, según normativa vigente].*
- *[Aspectos administrativos a realizar antes de la atención].*

Muchas gracias por su tiempo".

D2. RESPUESTA A UNA ANULACIÓN DE CITA:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social),

Su hora queda ANULADA. Si necesita reagendar o buscar otra hora, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Muchas gracias por su tiempo".

SCRIPT 4.3: CONFIRMACIÓN DE CITAS POR MENSAJERÍA INSTANTÁNEA GESTIONADA POR UNA PERSONA

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social). Le escribimos desde el (Nombre del establecimiento) para recordarle que tiene una cita agendada con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:

- *CONFIRMAR HORA [indicar opción para la confirmación de citas].*
- *ANULAR HORA [indicar opción para la anulación de citas].*

En caso de no poder asistir, por favor avísenos para ofrecer esta cita a otro usuario que la esté necesitando.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su atención y cooperación,

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), le rogamos que ignore este mensaje"

C. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios la confirmación o anulación de su cita:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social),

Gracias por su interés en confirmar o anular su cita con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:

- *CONFIRMAR HORA [indicar opción para la confirmación de citas].*
- *ANULAR HORA [indicar opción para la anulación de citas].*

Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

(Nombre del establecimiento)"

D1. RESPUESTA A UNA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA A LA CITA AGENDADA:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social),

Su hora queda CONFIRMADA. La atención será el (día) a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento) con (detalle de la prestación en espera agendada).

Para su cita agendada, favor tener en consideración lo siguiente:

- *Debe presentarse con un mínimo de 15 minutos de anticipación.*
- *Preparación para la cita: [informar la preparación necesaria dependiendo de la prestación de salud en espera].*
- *[Deberes del usuario con respecto a su atención de salud, según normativa vigente].*
- *[Aspectos administrativos a realizar antes de la atención].*

Muchas gracias por su tiempo".

D2. RESPUESTA A UNA ANULACIÓN DE CITA:

"Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social),

Su hora queda ANULADA. Si necesita reagendar o buscar otra hora, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Muchas gracias por su tiempo".

SCRIPT 4.4: CONFIRMACIÓN DE CITAS POR MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS).

Por este medio se debe que considerar que el límite de caracteres permitidos es de 160.

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre usuario del registro de espera/nombre social).

Necesitamos CONFIRMAR o ANULAR su cita. Para ello, ingrese al portal paciente: [enlace].

(Nombre del establecimiento)"

B. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios los medios de contacto con el establecimiento.

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social).

Ante dudas contactar a su establecimiento de salud al [medio de contacto].

(Nombre del establecimiento)"

SCRIPT 4.5: CONFIRMACIÓN DE CITAS POR LLAMADO TELEFÓNICO POR IA.

A. MENSAJE INICIAL:

"Bienvenido al sistema de contacto de (Nombre del establecimiento). Esta es una llamada automática. Si usted es (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), presione 1. Si usted es el tutor o representante de (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), presione 2. Si usted no es (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social) ni su representante, presione 3"

B. RESPUESTAS Y FLUJO:

OPCIÓN SELECCIONADA	RESPUESTA
1	*"Gracias por confirmar su identidad. Le escribimos desde el (Nombre del establecimiento) para recordarle que tiene una cita agendada con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:* • *(Opción 1): CONFIRMAR HORA: Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social). Su hora queda CONFIRMADA. La atención será el (día) a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento) con (detalle de la prestación en espera agendada).* • *(Opción 2): ANULAR HORA: Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social). Su hora queda ANULADA. Si necesita reagendar o buscar otra hora, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales [indicar canales].* *En caso de no poder asistir, por favor avísenos para ofrecer esta cita a otro usuario que la esté necesitando.*

2	*"Gracias. Le escribimos desde el (Nombre del establecimiento) para recordarle que su representado tiene una cita agendada con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:* • *(Opción 1): CONFIRMAR HORA: Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social). Su hora queda CONFIRMADA. La atención será el (día) a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento) con (detalle de la prestación en espera agendada).* • *(Opción 2): ANULAR HORA: Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social). Su hora queda ANULADA. Si necesita reagendar o buscar otra hora, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales [indicar canales].*
3	*"Entendemos que usted no es la persona que buscamos. Si usted conoce al (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social) favor avísele que lo estamos intentando ubicar del (Nombre del establecimiento)".*

C. MENSAJE DE CIERRE:

"Gracias por su tiempo. Si necesita más información, puede contactarnos a través de [proporcionar canales de contacto]. Esta llamada ha sido grabada para su seguridad".

D. NOTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:

- Asegurar de que el sistema por IVR (respuesta de voz interactiva) pueda manejar las diferentes opciones y redireccionar a los flujos correspondientes.
- Incluir opciones para repetir los mensajes si el usuario lo necesita.
- Asegurar de que el sistema pueda transferir la llamada a un agente humano si es factible.
- Cumplir con todas las regulaciones de privacidad y protección de datos al manejar información personal.

SCRIPT 4.6: CONFIRMACIÓN DE CITAS POR LLAMADO TELEFÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. PRESENTACIÓN:

"Buenos días / tardes, le llamo desde (Nombre del establecimiento), mi nombre es (nombre del agente)".

Respuestas:

a.1 Contesta: continuar con etapa B: "Identificación del usuario".

a.2 No contesta/corta llamada: registrar.

B. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

"Hablo con el/la Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera/nombre social)"

Respuestas:

b.1 Contacto con usuario del registro de espera: continuar con etapa **C. "Motivo del contacto".**

b.2 Contacto con tutor: continuar con etapa **D. "Confirmación de usuario correcto: Solicitud de datos del representante".**

b.3 Contacto equivocado: continuar con etapa **E. "Solicitud de información del usuario: contacto con un tercero".**

b.4 No contesta/corta llamada: registrar.

C. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON USUARIO

"Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social), le llamo desde el (Nombre del establecimiento) para recordarle que tiene una cita agendada con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento).

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos que nos indique ningún dato de su cuenta bancaria, ni tampoco un número o código que podría llegar a su teléfono.

Si tiene consultas o dudas, puede visitar el sitio web [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social), ¿usted desea mantener su cita agendada?"

Respuestas:

c.1 Confirma cita. Continuar con etapa **G. "Confirmación de cita".**

c.2 Anula cita. Continuar con etapa **H. "Anulación de cita".**

c.3 No contesta/corta llamada: registro.

D. CONFIRMACIÓN DE USUARIO CORRECTO: SOLICITUD DE DATOS DEL REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. ¿Me podría indicar su nombre completo, RUT, parentesco y teléfonos fijo y móvil?"

Respuestas:

d.1 Contesta: continuar con etapa **F. "Motivo del contacto: contacto con representante".**

d.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

E. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL USUARIO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre ¿puede comunicarme o tiene como ubicar a el/la Sr. /Sra. Nombre y apellidos (indicado en el registro de espera)?

Respuestas:

e.1 Contesta: registro del dato entregado y cierre **M. "Cierre del llamado: contacto con un tercero".**

e.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

F. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. (Nombre del representante), le llamo desde el (Nombre del establecimiento) para recordarle que el/la Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social) tiene una cita agendada con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento).

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos que nos indique ningún dato de su cuenta bancaria, ni tampoco un número o código que podría llegar a su teléfono.

Si tiene consultas o dudas, puede visitar el sitio web [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Sr./Sra. (Nombre del representante) ¿usted desea mantener la cita agendada?"

Respuestas:

f.1 Confirma cita. Continuar con etapa **G. "Confirmación de cita".**

f.2 Anula cita. Continuar con etapa **H. "Anulación de cita".**

f.3 No contesta/corta llamada: registro.

G. CONFIRMACIÓN DE CITA.

"Sr. /Sra. Nombre. Para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos:

- *RUN.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Teléfonos fijo y móviles.*
- *Correo electrónico*
- *Previsión de salud"*

La hora queda CONFIRMADA. La atención será el (día) a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento) con (detalle de la prestación en espera agendada).

Para su cita agendada, favor tener en consideración lo siguiente:

- *Debe presentarse con un mínimo de 15 minutos de anticipación.*
- *Preparación para la cita: [informar la preparación necesaria dependiendo de la prestación de salud en espera].*
- *[Deberes del usuario con respecto a su atención de salud, según normativa vigente].*
- *[Aspectos administrativos a realizar antes de la atención]"*

H. ANULACIÓN DE CITA:

"Sr. /Sra. Nombre (Nombre representante). Para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos del Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social):

- *RUN.*
- *DV.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*

- *Previsión de salud del usuario del registro de espera.*
- *Teléfonos fijo y móviles del representante.*
- *Correo electrónico del representante".*

La hora queda ANULADA. Si necesita reagendar o buscar otra hora, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Muchas gracias por su tiempo".

I. CAUSAL DE EGRESO O EXCEPCIÓN O CIERRE DE GARANTÍA GES:

En el caso de que se pesquise que el usuario no requiere la prestación de salud agendada, se debe continuar flujo para salida del registro:

"Sr. / Sra. Nombre, ¿nos podría indicar cómo solucionó su necesidad de salud?"

Respuestas:

h.1 Contesta: flujo de salidas de sistemas de registros de espera para prestaciones de salud vía gestión de contactabilidad.

h.2 No contesta/corta llamada: registro.

M. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre, agradecemos su tiempo".

SCRIPT 4.7: CONFIRMACIÓN DE CITAS POR PORTAL PACIENTE.

A. INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Despliegue de formulario para cada prestación de salud en espera registrada, mostrar un formulario con las siguientes preguntas:

i. *"¿Usted está aún en espera de la prestación de salud descrita?"*

a. *Si la respuesta es "Sí":*

i. CONFIRMACIÓN o ANULACIÓN de la cita: *Se debe enviar un comprobante con la información registrada a su correo electrónico o mensajería instantánea.*

"Tiene una atención agendada con (detalle de la agenda: que incluya nombre del profesional y detalle de la prestación de salud), el día (día de la atención agendada), a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento). Por favor, seleccione una de las siguientes opciones para CONFIRMAR o LIBERAR la hora:

- *CONFIRMAR HORA [botón para dar click e informar la confirmación de citas].*

  Se despliega la información de la cita confirmada: "Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social). Su hora queda CONFIRMADA. La atención será el (día) a las (hora), en (lugar específico dentro del establecimiento)

con (detalle de la prestación en espera agendada). Para su cita agendada, favor tener en consideración lo siguiente:

- *Debe presentarse con un mínimo de 15 minutos de anticipación.*
- *Preparación para la cita: [informar la preparación necesaria dependiendo de la prestación de salud en espera].*
- *[Deberes del usuario con respecto a su atención de salud, según normativa vigente].*
- *[Aspectos administrativos a realizar antes de la atención]"*
  Muchas gracias por su tiempo".

- ***ANULAR HORA** [Botón para dar click e informar la anulación de citas].*

  "Estimado/a (Nombre completo del usuario del registro de espera/ nombre social). Su hora queda ANULADA. Si necesita reagendar o buscar otra hora, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales [indicar canales]. Muchas gracias por su tiempo".

b. *Si la respuesta es "No": Desplegar formulario de egreso o excepción o cierre de garantía GES:*

   i. *Mostrar selección de causales de egreso o excepción o cierre de garantía GES.*

   ii. *Desplegar cuadro informativo sobre el egreso o excepción o cierre de garantía GES, solicitando confirmación.*

   iii. *Mostrar segundo cuadro de verificación para confirmar el egreso o excepción o cierre de garantía GES.*

   iv. *Procedimiento interno post-confirmación:*

      1. *Enviar correo electrónico solicitando confirmación del no requerimiento de la prestación de salud (plazo de 5 días).*
      2. *Realizar dos llamadas telefónicas en un plazo máximo de 5 días.*
      3. *Si no hay respuesta después de 5 días, proceder con el egreso o excepción o cierre de garantía GES basado en lo informado en el portal.*

B. SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Proporcionar un campo para que el usuario registre información adicional.

i. *"¿Requiere algún tipo de información respecto a su prestación en espera?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar: Anular cita, confirmar cita, consultar estado de cita médica.*

ii. *"¿Requiere que el establecimiento se ponga en contacto?" Opciones: Sí, No*

iii. *"¿Cuál es su preferencia para ser contactado?" Opciones: teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, otro (especificar).*

iv. *"¿Cuál es el mejor momento para contactarle?" Opciones: mañana, tarde, noche, fin de semana, horario laboral, señalar horario y día.*

v. *"¿Cuál es su número de teléfono/correo electrónico actual?" (Campo para actualizar información de contacto)*

C. SOLICITUDES ESPECÍFICAS

i. *"¿Tiene alguna preocupación específica que le gustaría resolver con el establecimiento?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta esSí, proporcionar campo para especificar.*

ii. *"¿Hay algún cambio reciente en su estado de salud que deba informarnos?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iii. *"¿Tiene alguna necesidad especial o preferencia que debamos considerar?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iv. *"¿Prefiere citas presenciales o telemedicina?" Opciones: presenciales, telemedicina, ambas.*

v. *"¿Requiere asistencia para su cita ya programada?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

vi. *"¿Le gustaría sugerir alguna mejora en nuestro servicio?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

D. CANALES DE COMUNICACIÓN

Mostrar de forma clara y visible los siguientes medios de contacto:

"Si tiene alguna pregunta o consulta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

a. *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*

b. *Correo electrónico: [correo electrónico]*

c. *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*

d. *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]"*

9.4.4. SCRIPTS DE CONTACTABILIDAD PARA EL SUBPROCESON DE POST ATENCIÓN

Scripts de la Contactabilidad de Post Atención	• Script 5.0: correo electrónico gestionado por una persona. • Script 5.1: mensajería instantánea gestionada por una persona. • Script 5.2: mensajería de texto (SMS). • Script 5.3: llamado telefónico gestionado por una persona. • Script 5.4: repositorio digital (portal paciente)

SCRIPT 5.0: POST ATENCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. ASUNTO DEL CORREO:

"Seguimiento importante post atención en el (Nombre del establecimiento)"

B. CUERPO DEL CORREO:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para realizar un seguimiento personalizado después de la atención que recibió.

Como parte de nuestro compromiso con su bienestar, le invitamos a proporcionarnos una actualización sobre su estado de salud posterior a la atención. Nos interesa conocer en detalle:

- *Si fue atendido/a.*
- *Que verifique y actualice sus datos de contacto.*

- *[dependiendo de la prestación en espera y especialidad, se pueden incorporar modelos de escalas para conocer, por ejemplo, el estado de salud actual del usuario, experiencia en la gestión diaria de su salud, redes de apoyo con las que cuenta, percepción sobre el proceso de atención, entre otros].*

Para proporcionar esta información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su participación es fundamental para asegurar la continuidad de su cuidado y detectar cualquier necesidad de seguimiento adicional.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su colaboración en este proceso de seguimiento post atención.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta casilla de correo electrónico no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este correo. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera), solo ignore este mensaje"

C. DETALLES ADICIONALES QUE PUEDEN INCORPORARSE AL FINAL DEL CORREO:

"Para garantizar la seguridad y confidencialidad de su información de salud, le solicitamos que siga las siguientes recomendaciones:

- No comparta su información personal (como números de identificación, contraseñas o datos bancarios) a través de correo electrónico.
- Utilice una contraseña segura para acceder a su cuenta de correo electrónico y a cualquier portal de salud en línea.
- Verifique la autenticidad del remitente: nuestros correos oficiales siempre provienen de la dirección [dirección de correo oficial].
- Informe inmediatamente si nota alguna actividad sospechosa relacionada con su información de salud o si recibe correos electrónicos sospechosos.

D. RESPUESTAS:

Las respuestas que pueden desarrollarse mediante correo electrónico deben considerar que no se puede compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación simple:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Agradecemos su respuesta. Para actualizar su información, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro correo anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Hemos recibido su solicitud de información adicional. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 5.1: POST ATENCIÓN POR MENSAJERÍA INSTANTÁNEA GESTIONADA POR UNA PERSONA.

A. MENSAJE INICIAL:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para realizar un seguimiento personalizado después de la atención que recibió.

Como parte de nuestro compromiso con su bienestar, le invitamos a proporcionarnos una actualización sobre su estado de salud posterior a la atención. Nos interesa conocer en detalle:

- *Si fue atendido/a.*
- *Que verifique y actualice sus datos de contacto.*
- *[dependiendo de la prestación en espera y especialidad, se pueden incorporar modelos de escalas para conocer, por ejemplo, el estado de salud actual del usuario, experiencia en la gestión diaria de su salud, redes de apoyo con las que cuenta, percepción sobre el proceso de atención, entre otros].*

Para proporcionar esta información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su participación es fundamental para asegurar la continuidad de su cuidado y detectar cualquier necesidad de seguimiento adicional.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su colaboración en este proceso de seguimiento post atención.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

D. RESPUESTAS:

Las respuestas que pueden desarrollarse mediante mensajería instantánea deben considerar que no se puede compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación simple:

"Estimado/a [Nombre del usuario],

Agradecemos su respuesta. Para actualizar su información, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro mensaje anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a [Nombre del usuario],

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Hemos recibido su solicitud de información adicional. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 5.2: POST ATENCIÓN POR MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS).

Por este medio se debe que considerar que el límite de caracteres permitidos es de 160.

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre usuario del registro de espera).

Necesitamos actualizar su información. Para ello, ingrese al portal paciente: [enlace].

(Nombre del establecimiento)"

C. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios los medios de contacto con el establecimiento.

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera).

Ante dudas contactar a su establecimiento de salud al [medio de contacto].

(Nombre del establecimiento)"

SCRIPT 5.3: POST ATENCIÓN POR LLAMADO TELEFÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. PRESENTACIÓN:

"Buenos días / tardes, le llamo desde (Nombre del establecimiento), mi nombre es (nombre del agente)".

Respuestas:

a.1 Contesta: continuar con etapa **B: "Identificación del usuario".**

a.2 No contesta/corta llamada: cierre del proceso de contactabilidad.

B. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

"Hablo con el/la Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera)"

Respuestas:

b.1 Contacto con usuario del registro de espera: continuar con etapa **C. "Motivo del contacto".**

b.2 Contacto con tutor: continuar con etapa **D. "Confirmación de usuario correcto: Solicitud de datos del representante".**

b.3 Contacto equivocado: continuar con etapa **E. "Solicitud de información del usuario: contacto con un tercero".**

b.4 No contesta/corta llamada: cierre del proceso de contactabilidad.

C. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON USUARIO

"Sr./Sra. (Nombre usuario), le llamo desde (Nombre del establecimiento) para realizar un seguimiento personalizado después de la atención que recibió (nombrar prestación en espera).

Como parte de nuestro compromiso con su bienestar, le invitamos a proporcionarnos una actualización sobre su estado de salud posterior a la atención. Esto incluye conocer su estado de

salud general, cómo maneja su condición, el apoyo con el que cuenta, su bienestar emocional y su experiencia con la atención recibida.

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos datos bancarios ni códigos de seguridad. Si tiene dudas, puede visitar [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Luego consultar:

"Sr./Sra. (Nombre usuario), ¿usted fue atendido/a por (detalle de la prestación en espera) en el establecimiento (Nombre del establecimiento)?"

Respuestas:

c.1 Si fue atendido. Continuar con etapa **G. "Verificación y actualización de datos personales y seguimiento".**

c.2 No fue atendido. Continuar con etapa **H. "Protocolo de inasistencias".**

c.3 No contesta/corta llamada: cierre del proceso de contactabilidad.

D. CONFIRMACIÓN DE USUARIO CORRECTO: SOLICITUD DE DATOS DEL REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. ¿Me podría indicar su nombre completo, RUT, parentesco y teléfonos fijo y móvil?"

Respuestas:

d.1 Contesta: continuar con etapa **F. "Motivo del contacto: contacto con representante".**

d.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

E. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL USUARIO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre ¿puede comunicarme o tiene como ubicar a el/la Sr. /Sra. Nombre y apellidos (indicado en el registro de espera)?

Respuestas:

e.1 Contesta: registro del dato entregado y cierre **L. "Cierre del llamado: contacto con un tercero".**

e.2 No contesta/corta llamada: cierre del proceso de contactabilidad.

F. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. (Nombre del representante), le llamo desde (Nombre del establecimiento) para realizar un seguimiento personalizado después de la atención que recibió el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera).

Como parte de nuestro compromiso con el bienestar de nuestros usuarios, le invitamos a proporcionarnos una actualización sobre el estado de salud de el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera) posterior a la atención. Esto incluye conocer el estado de salud general, cómo maneja su condición, el apoyo con el que cuenta, su bienestar emocional y la experiencia con la atención recibida.

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos datos bancarios ni códigos de seguridad. Si tiene dudas, puede visitar [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Luego consultar:

"Sr./Sra. (Nombre representante), ¿el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera) fue atendido/a por la prestación de salud (nombre de la prestación en espera según detalle del registro) en el establecimiento (Nombre del establecimiento)?"

Respuestas:

f.1 Si fue atendido/a. Continuar con etapa **I. "Verificación y actualización de datos personales y seguimiento".**

f.2 No fue atendido/a. Continuar con etapa **H. "Protocolo de inasistencias".**

f.3 No contesta/corta llamada: cierre del proceso de contactabilidad.

G. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES.

"*Sr. /Sra. Nombre. Para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos:*

- *RUN.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Teléfonos fijo y móviles.*
- *Correo electrónico*
- *Previsión de salud.*

Su participación es fundamental para asegurar la continuidad de su cuidado y detectar cualquier necesidad de seguimiento adicional. Para esto vamos a realizar algunas preguntas:

- *¿Tiene alguna duda sobre como seguir las indicaciones entregadas? [Revisión de indicaciones entregadas y resolución de dudas o consultas]*
- *¿Hay algo que no le haya quedado claro sobre las indicaciones recibidas? ¿Tiene alguna pregunta adicional? [Informar sobre hitos posteriores según indicación médica]*
- *¿Está al tanto de las próximas fechas importantes en su plan de tratamiento, como citas de seguimiento o exámenes programados? ¿Hay algún aspecto de su cuidado o recuperación para el que sienta que necesita apoyo adicional? [Requerimiento de prestaciones complementarias o necesidades adicionales].*
- *¿Hay algún aspecto de la atención que recibió sobre el que le gustaría obtener más información o aclaración? [Resolución de dudas o consultas relacionadas a la atención recibida o indicaciones entregadas].*
- *¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo podríamos mejorar nuestro servicio basándose en su experiencia?*
- *[adicional: Se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, satisfacción usuaria, etc.)].*

Respuestas:

g.1 Contesta: continuar con etapa **J. "Cierre del llamado: contacto con el usuario".**

g.2 No contesta/corta llamada: cierre del proceso de contactabilidad.

H. PROTOCOLO DE INASISTENCIAS: Se debe revisar internamente si corresponde a inasistencias reiteradas de acuerdo con la OOTT para el Proceso de Gestión de Agendas y Citas y Normativas de las Garantías Explícitas en Salud (GES) vigentes.

De acuerdo con lo registrado, se procede a agendar nuevamente o proceder con la salida del registro por inasistencias reiteradas.

I. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES: CONTESTA UN REPRESENTANTE.

"Sr. /Sra. Nombre (Nombre representante). Para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos del Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro):

- *RUN.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Relación con el usuario en el registro de espera.*
- *Previsión de salud del usuario del registro de espera.*
- *Teléfonos fijo y móviles del representante.*
- *Correo electrónico del representante".*

Su participación es fundamental para asegurar la continuidad del cuidado de (nombre del usuario en registro de espera) y detectar cualquier necesidad de seguimiento adicional. Para esto vamos a realizar algunas preguntas sobre la atención recibida por el Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro):

- *¿Tiene alguna duda sobre como seguir las indicaciones entregadas? [Revisión de indicaciones entregadas y resolución de dudas o consultas]*
- *¿Hay algo que no le haya quedado claro sobre las indicaciones recibidas? ¿Tiene alguna pregunta adicional? [Informar sobre hitos posteriores según indicación médica]*
- *¿Está al tanto de las próximas fechas importantes en el plan de tratamiento, como citas de seguimiento o exámenes programados? ¿Hay algún aspecto del cuidado o recuperación para el que sienta que necesita apoyo adicional? [Requerimiento de prestaciones complementarias o necesidades adicionales].*
- *¿Hay algún aspecto de la atención que recibió el Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro) sobre el que le gustaría obtener más información o aclaración? [Resolución de dudas o consultas relacionadas a la atención recibida o indicaciones entregadas].*
- *¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo podríamos mejorar nuestro servicio basándose en la experiencia?*
- *[adicional: Se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, satisfacción usuaria, etc.)].*

Respuestas:

i.1 Contesta: continuar con etapa **K. "Cierre del llamado: contacto con representante".**

i.2 No contesta/corta llamada: cierre del proceso de contactabilidad.

J. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON EL USUARIO.

"Es importante que nos verifique por qué medio de contacto le es más cómodo u oportuno que lo contactemos y en qué horario, en caso de ser necesario.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]"*

K. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON REPRESENTANTE.

"Sr. / Sra. Nombre, hemos registrado los datos. Agradecemos mucho su tiempo.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]"*

L. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre, agradecemos su tiempo".

SCRIPT 5.4: POST ATENCIÓN POR PORTAL PACIENTE.

A. INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Despliegue de formulario para cada prestación de salud en espera registrada, mostrar un formulario con las siguientes preguntas:

i. *"¿Usted recibió la atención de salud (Detalle de la prestación en espera agendada)?*
   a. *Si la respuesta es "Sí": Desplegar preguntas para asegurar la continuidad del cuidado y detectar cualquier necesidad de seguimiento adicional:*
      i. *¿Tiene alguna duda sobre como seguir las indicaciones entregadas? [Revisión de indicaciones entregadas y resolución de dudas o consultas] Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar.*
      ii. *¿Hay algo que no le haya quedado claro sobre las indicaciones recibidas? ¿Tiene alguna pregunta adicional? [Informar sobre hitos posteriores según indicación médica] Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar.*

iii. *¿Está al tanto de las próximas fechas importantes en su plan de tratamiento, como citas de seguimiento o exámenes programados? ¿Hay algún aspecto de su cuidado o recuperación para el que sienta que necesita apoyo adicional? [Requerimiento de prestaciones complementarias o necesidades adicionales] Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar.*

iv. *¿Hay algún aspecto de la atención que recibió sobre el que le gustaría obtener más información o aclaración? [Resolución de dudas o consultas relacionadas a la atención recibida o indicaciones entregadas]. Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar.*

v. *¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo podríamos mejorar nuestro servicio basándose en su experiencia? Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar.*

vi. *[adicional: Se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, satisfacción usuaria, etc.)].*

b. *Si la respuesta es "No": Desplegar preguntas para verificar detalles de la inasistencia del usuario.*

i. *¿Cuál fue el motivo por el cual no asistió a su cita? Mostrar selección de opciones: Olvido de la cita, confusión de la fecha u hora, problemas de salud que impidieron su asistencia, otros: especificar.*

ii. *Desplegar cuadro informativo sobre el egreso, excepción o cierre de garantía, por inasistencias reiteradas.*

iii. *Si corresponde reagendar según normativa vigente, proceder con el agendamiento y proporcionar detalles de la cita (fecha y hora, lugar específico, profesional que lo atenderá, preparación previa).*

B. SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Proporcionar un campo para que el usuario registre información adicional.

i. *"¿Requiere algún tipo de información respecto a su prestación en espera?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, especificar: Anular cita, confirmar cita, consultar estado de cita médica.*

ii. *"¿Requiere que el establecimiento se ponga en contacto?" Opciones: Sí, No*

iii. *"¿Cuál es su preferencia para ser contactado?" Opciones: teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, otro (especificar).*

iv. *"¿Cuál es el mejor momento para contactarle?" Opciones: mañana, tarde, noche, fin de semana, horario laboral, señalar horario y día.*

v. *"¿Cuál es su número de teléfono/correo electrónico actual?" (campo para actualizar información de contacto)*

C. SOLICITUDES ESPECÍFICAS

i. *"¿Tiene alguna preocupación específica que le gustaría resolver con el establecimiento?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

ii. *"¿Hay algún cambio reciente en su estado de salud que deba informarnos?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iii. *"¿Tiene alguna necesidad especial o preferencia que debamos considerar?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iv. *"¿Prefiere citas presenciales o telemedicina?" Opciones: presenciales, telemedicina, ambas.*

v. *"¿Requiere asistencia para su cita ya programada?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

vi. *"¿Le gustaría sugerir alguna mejora en nuestro servicio?" Opciones: Sí, No. Si la respuesta es Sí, proporcionar campo para especificar.*

D. CANALES DE COMUNICACIÓN

Mostrar de forma clara y visible los siguientes medios de contacto:

"Si tiene alguna pregunta o consulta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

a. *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*

b. *Correo electrónico: [correo electrónico]*

c. *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*

d. *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]"*

9.4.5. SCRIPTS PARA LA GESTIÓN DE LA NO CONTACTABILIDAD

Scripts para la gestión de la no contactabilidad	• Script 6.0: correo electrónico. • Script 6.1: mensajería instantánea. • Script 6.2: mensajería de texto. • Script 6.3: llamado telefónico gestionado por una persona. • Script 6.4: portal paciente • Script 6.5: visitas domiciliarias institucionales. • Script 6.6: visitas domiciliarias externalizadas. • Script 6.7: carta certificada. • Script 6.8: radiodifusión. De forma adicional se puede implementar el uso de redes sociales, campañas publicitarias, comunicación con enlaces comunitarios, tales como; juntas de vecinos, bomberos, carabineros, etc.

SCRIPT 6.0: CORREO ELECTRÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA

A. ASUNTO DEL CORREO:

"Información importante sobre su prestación de salud del (Nombre del establecimiento)"

B. CUERPO DEL CORREO:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para actualizar su información en nuestro sistema. Para ello, necesitamos que:

- *Confirme si aún presenta la necesidad de salud por la cual está esperando ser atendido/a.*
- *Verifique y actualice sus datos de contacto.*

Para actualizar su información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su pronta respuesta nos permitirá gestionar adecuadamente su solicitud y brindarle la mejor atención posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su atención y cooperación para mantener su información actualizada.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]

[Cargo]

[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta casilla de correo electrónico no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este correo. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), solo ignore este mensaje"

C. DETALLES ADICIONALES QUE PUEDEN INCORPORARSE AL FINAL DEL CORREO:

"Para garantizar la seguridad y confidencialidad de su información de salud, le solicitamos que siga las siguientes recomendaciones:

- *No comparta su información personal (como números de identificación, contraseñas o datos bancarios) a través de correo electrónico.*
- *Utilice una contraseña segura para acceder a su cuenta de correo electrónico y a cualquier portal de salud en línea.*
- *Verifique la autenticidad del remitente: nuestros correos oficiales siempre provienen de la dirección [dirección de correo oficial].*
- *Informe inmediatamente si nota alguna actividad sospechosa relacionada con su información de salud o si recibe correos electrónicos sospechosos.*
- *[en el caso de contar con el Compromiso de Vinculación y Comunicación en formato digital y ya firmado por el usuario o persona bajo cuyo cuidado se encuentre, se puede adjuntar al correo electrónico].*

D. RESPUESTAS:

Las respuestas que se realicen mediante correo electrónico deben considerar que no se puede compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación simple:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Agradecemos su respuesta. Para actualizar su información, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro correo anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre socia),

Hemos recibido su solicitud de información adicional. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para actualizar su información en nuestro sistema. Para ello, necesitamos que:

- *Confirme si aún presenta la necesidad de salud por la cual está esperando ser atendido/a.*
- *Verifique y actualice sus datos de contacto.*

Para actualizar su información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su pronta respuesta nos permitirá gestionar adecuadamente su solicitud y brindarle la mejor atención posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos su atención y cooperación para mantener su información actualizada.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta cuenta de mensajería instantánea no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este mensaje. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), le rogamos que ignore este mensaje"

C. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios los medios de contacto con el establecimiento.

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Recuerde que esta cuenta de mensajería instantánea no está habilitada para recibir mensajes, por lo que le solicitamos que no responda a este mensaje. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal]"

Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 6.1: MENSAJERÍA INSTANTÁNEA GESTIONADA POR UNA PERSONA.

A. MENSAJE INICIAL:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento) para actualizar su información en nuestro sistema. Para ello, necesitamos que:

- *Confirme si aún presenta la necesidad de salud por la cual está esperando ser atendido/a.*
- *Verifique y actualice sus datos de contacto.*

Para actualizar su información, por favor utilice uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Su pronta respuesta nos permitirá gestionar adecuadamente su solicitud y brindarle la mejor atención posible.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*

Agradecemos tu atención y cooperación para mantener su información actualizada.

Atentamente,

[Nombre ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]

IMPORTANTE: Esta cuenta de mensajería instantánea no está habilitada para recibir mensajes. Por favor, NO responda este mensaje. Para actualizar su información o consultas, por favor ingrese al portal paciente en [URL del portal] o utilice los canales de contacto mencionados anteriormente.

Este mensaje es enviado desde una cuenta oficial de (Nombre del establecimiento).

En caso de que esta comunicación no esté dirigida a usted o no conozca a (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social), le rogamos que ignore este mensaje"

D. RESPUESTAS:

Las respuestas que pueden desarrollarse mediante mensajería instantánea deben considerar que no se puede compartir información sensible, tal como, el estado de salud físico o mental.

D1. Respuesta a una confirmación simple:

"Estimado/a (Nombre del usuario),

Agradecemos su respuesta. Para actualizar su información, le recordamos utilizar los canales institucionales mencionados en nuestro mensaje anterior.

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D2. Respuesta a una intención de actualizar datos:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Gracias por su interés en actualizar su información. Le recordamos que, para realizar cualquier cambio en sus datos o estado, debe utilizar uno de los siguientes canales institucionales:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Por favor, use estos medios para garantizar la seguridad y precisión de su información.

Cordialmente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

D3. Respuesta a una solicitud de más información:

"Estimado/a (Nombre del usuario o nombre social),

Hemos recibido su solicitud de información adicional. Para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio.

Le invitamos a utilizar nuestros canales institucionales para obtener la información que necesita:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

A través de estos canales, podremos verificar su identidad y proporcionarle la información pertinente sobre su caso.

Atentamente,

[Nombre del ejecutivo]
[Cargo]
[Nombre del establecimiento]"

SCRIPT 6.2: MENSAJERÍA DE TEXTO (SMS).

Por este medio se debe que considerar que el límite de caracteres permitidos corresponde a 160.

A. MENSAJE INICIAL

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre usuario del registro de espera o nombre social).
Necesitamos actualizar su información. Para ello, ingrese al portal paciente: [enlace].
(Nombre del establecimiento)"

B. RESPUESTAS:

Se programan respuestas automáticas para informar a los usuarios los medios de contacto con el establecimiento.

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social).
Ante dudas contactar a su establecimiento de salud al [medio de contacto].
(Nombre del establecimiento)"

SCRIPT 6.3: LLAMADO TELEFÓNICO GESTIONADO POR UNA PERSONA.

A. PRESENTACIÓN:

"Buenos días / tardes, le llamo desde (Nombre del establecimiento), mi nombre es (nombre del agente)".

Respuestas:

a.1 Contesta: continuar con etapa B: "Identificación del usuario".

a.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

B. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

"Hablo con el/la Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social)"

Respuestas:

b.1 Contacto con usuario del registro de espera: continuar con etapa C. "Motivo del contacto".

b.2 Contacto con tutor: continuar con etapa D. "Confirmación de usuario correcto: Solicitud de datos del representante".

b.3 Contacto equivocado: continuar con etapa E. "Solicitud de información del usuario: contacto con un tercero".

b.4 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

C. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON USUARIO

"Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social), usted se encuentra en el registro del (nombre del establecimiento), del establecimiento, de personas que esperan una prestación de salud de (detalle de la prestación en espera). La razón de este contacto es para confirmar si aún presenta su necesidad de salud, además de actualizar sus datos de contacto en el caso de ser necesario. Lo anterior, permitirá gestionar la resolución de su necesidad de salud, si usted aún la requiere.

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos que nos indique ningún dato de su cuenta bancaria, ni tampoco un número o código que podría llegar a su teléfono.

Si tiene consultas o dudas, puede visitar el sitio web [indicar portal de paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social), ¿usted está en espera de una prestación de salud (detalle de la prestación en espera) en el establecimiento (Nombre del establecimiento)?"

Respuestas:

c.1 Si está a la espera. Continuar con etapa G. "Verificación y actualización de datos personales".

c.2 No está a la espera. Continuar con etapa H. "Causal de egreso o excepción o cierre de garantía GES".

c.3 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

D. CONFIRMACIÓN DE USUARIO CORRECTO: SOLICITUD DE DATOS DEL REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. ¿Me podría indicar su nombre completo, RUT, parentesco y Teléfonos fijo y móvil?"

Respuestas:

d.1 Contesta: continuar con etapa F. "Motivo del contacto: contacto con representante".

d.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

E. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL USUARIO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre ¿puede comunicarme o tiene como ubicar a él/la Sr. /Sra. Nombre y apellidos (indicado en el registro de espera)?

Respuestas:

e.1 Contesta: registro del dato entregado y cierre M. "Cierre del llamado: contacto con un tercero".

e.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

F. MOTIVO DEL CONTACTO: CONTACTO CON REPRESENTANTE.

"Sr./Sra. (Nombre del representante), el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) se encuentra en el registro de personas que esperan una prestación de salud en la institución. La razón de este contacto es para confirmar si el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) sigue necesitando la atención de salud, además de actualizar los datos de contacto en el caso de ser necesario. Lo anterior, permitirá gestionar la resolución de su

necesidad de salud, esto, si el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) aún la requiere.

Antes de continuar, le informo que esta llamada será grabada. No solicitaremos que nos indique ningún dato de su cuenta bancaria, ni tampoco un número o código que podría llegar a su teléfono.

Si tiene consultas o dudas, puede visitar el sitio web [indicar portal paciente o página institucional] o llamar al [indicar teléfono institucional].

Sr./Sra. (Nombre representante), ¿el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) está en espera de una prestación de salud (nombre de la prestación en espera según detalle del registro) en el establecimiento?"

Respuestas:

f.1 Si está a la espera. Continuar con etapa I. "Verificación y actualización de datos personales".

f.2 No está a la espera. Continuar con etapa J. "Causal de egreso o excepción o cierre de garantía GES".

f.3 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

G. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES.

"Sr. /Sra. Nombre. Para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos:

- *RUN.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Teléfonos fijo y móviles.*
- *Correo electrónico*
- *Previsión de salud"*

Respuestas:

g.1 Contesta: continuar con etapa K. "Cierre del llamado: contacto con el usuario".

g.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

H. CAUSAL DE EGRESO:

"Sr. / Sra. Nombre, ¿nos podría indicar cómo solucionó su necesidad de salud?"

Respuestas:

h.1 Contesta: continuar con etapa G. Verificación y actualización de datos personales.

h.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

I. VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES: CONTESTA UN REPRESENTANTE.

"Sr. /Sra. Nombre (Nombre representante). Para tener una comunicación efectiva entre usted y el establecimiento de salud, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos del Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social):

- *RUN.*
- *Nombres.*
- *Primer apellido.*
- *Segundo apellido.*
- *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número.*
- *Relación con el usuario en registro de espera.*
- *Previsión de salud del usuario del registro de espera.*
- *Teléfonos fijo y móviles del representante.*
- *Correo electrónico del representante".*

Respuestas:

i.1 Contesta: continuar con etapa L. "Cierre del llamado: contacto con representante".

i.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

J. CAUSAL DE EGRESO O EXCEPCIÓN O CIERRE DE GARANTÍA GES: RESPONDE EL REPRESENTANTE.

"Sr. / Sra. Nombre (Nombre representante), ¿nos podría indicar cómo solucionó la necesidad de salud el/la Sr./Sra. Nombre (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social)?"

Respuestas:

j.1 Contesta: continuar con etapa I. Verificación y actualización de datos personales.

j.2 No contesta/corta llamada: flujo de no contactabilidad.

K. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON EL USUARIO.

"Es importante que nos verifique por qué medio de contacto le es más cómodo u oportuno que lo contactemos y en qué horario. El (Nombre del establecimiento) tomará contacto con usted para la continuidad del proceso asistencial.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]"*

L. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON REPRESENTANTE.

"Sr. / Sra. Nombre, hemos registrado los datos. Agradecemos mucho su tiempo.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*

- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]"*

M. CIERRE DEL LLAMADO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre, agradecemos su tiempo, si usted llega a tomar contacto con el Sr. / Sra. Nombre (nombre del usuario del registro de espera), favor informe que estamos intentando ubicarlo desde el (nombre del establecimiento)".

SCRIPT 6.4: PORTAL PACIENTE.

A. INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Despliegue de formulario para cada prestación de salud en espera registrada, mostrar un formulario con las siguientes preguntas:

i. *"¿Usted está aún en espera de la prestación de salud descrita?"*

   a. *Si la respuesta es "Sí":*

      i. *Se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, etc.). El objetivo principal será recopilar información que permita priorizar efectivamente el caso y evaluar requerimientos adicionales.*

      ii. *Desplegar formulario de autoeficacia[34]: Medir la autoeficacia en usuarios es crucial porque esta percepción influye significativamente en la capacidad del individuo para manejar enfermedades, adherirse a tratamientos y realizar cambios de comportamiento necesarios para mejorar la salud. Una baja percepción está asociada con peores resultados de salud y mayor riesgo de morbimortalidad en las personas[35] (para más detalles del formulario propuesto revisar el Anexo N°7).*

      iii. *Solicitar información sobre licencias médicas por la condición de salud ingresada en los últimos 2 meses.*

   b. *Si la respuesta es "No": Desplegar formulario de egreso o excepción o cierre de garantía GES:*

      i. *Mostrar selección de causales de egreso o excepción o cierre de garantía GES.*

      ii. *Desplegar cuadro informativo sobre el egreso o excepción o cierre de garantía GES, solicitando confirmación.*

      iii. *Mostrar segundo cuadro de verificación para confirmar el egreso o excepción o cierre de garantía GES.*

      iv. *Procedimiento inte*mo post-confirmación:

         1. *Enviar correo electrónico solicitando confirmación del no requerimiento de la prestación de salud (plazo de 5 días).*

         2. *Realizar dos llamadas telefónicas en un plazo máximo de días, en días y horarios diferentes, una de las cuales debe ser en horario inhábil.*

         3. *Si no hay respuesta después de 5 días, proceder con el egreso o excepción o cierre de garantía GES basado en lo informado en el portal.*

---

[34] Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy Scale. En J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON.

[35] González, C., & Calderón, C. (2009). Autoeficacia y su relación con la adhesión al tratamiento en pacientes crónicos en Chile. Revista Médica de Chile, 137(9), 1173-1180.

B. SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO:

Proporcionar un campo para que el usuario registre información adicional.

i. *"¿Requiere algún tipo de información respecto a su prestación en espera?" Opciones: Sí, No. Si es Sí, especificar: Anular cita, confirmar cita, consultar estado de cita médica.*

ii. *"¿Requiere que el establecimiento se ponga en contacto?" Opciones: Sí, No*

iii. *"¿Cuál es su preferencia para ser contactado?" Opciones: Teléfono, Correo electrónico, Mensaje de texto, otro (especificar).*

iv. *"¿Cuál es el mejor momento para contactarle?" Opciones: Mañana, Tarde, Noche, Fin de semana, Horario laboral, Señalar horario y día.*

v. *"¿Cuál es su número de teléfono/correo electrónico actual?" (Campo para actualizar información de contacto)*

C. SOLICITUDES ESPECÍFICAS

i. *"¿Tiene alguna preocupación específica que le gustaría resolver con el establecimiento?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si es Sí, proporcionar campo para especificar.*

ii. *"¿Hay algún cambio reciente en su estado de salud que deba informarnos?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iii. *"¿Tiene alguna necesidad especial o preferencia que debamos considerar?" Opciones: Sí, No, Prefiero no decir. Si es Sí, proporcionar campo para especificar.*

iv. *"¿Prefiere citas presenciales o telemedicina?" Opciones: Presenciales, Telemedicina, Ambas.*

v. *"¿Requiere asistencia para su cita ya programada?" Opciones: Sí, No. Si es Sí, proporcionar campo para especificar.*

vi. *"¿Le gustaría sugerir alguna mejora en nuestro servicio?" Opciones: Sí, No. Si es Sí, proporcionar campo para especificar.*

D. NOTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE VINCULACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO

"Atención: Se requiere su contacto urgente.

El establecimiento de salud necesita comunicarse con usted. Por favor, actualice sus datos de contacto o póngase en contacto con nosotros, a través de los siguientes canales:

a. *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*

b. *Correo electrónico: [correo electrónico]*

c. *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*

d. *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Tiempo restante para responder: 30 días"

**Se debe incorporar el estado de la notificación (fecha de notificación inicial, recordatorio y último aviso).*

Imagen referencial:

E. CANALES DE COMUNICACIÓN

Mostrar de forma clara y visible los siguientes medios de contacto:

"Si tiene alguna pregunta o consulta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

a. *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
b. *Correo electrónico: [correo electrónico]*
c. *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
d. *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]"*

SCRIPT 6.5: VISITAS DOMICILIARIAS INSTITUCIONALES.

En las visitas domiciliarias realizadas por personal institucional se debe recabar la mayor cantidad de información necesaria para dar continuidad a los procesos asistenciales posteriores. Los datos sensibles deben resguardarse y solo informar detalles de la prestación de salud a la persona del registro de espera o su representante (persona bajo cuyo cuidado se encuentre).

A. PREPARACIÓN PREVIA A LA VISITA.

a.1 Revisar la información del usuario.

a.2 Preparar el formulario de contacto (registro de la visita domiciliaria) y el Compromiso de Vinculación y Comunicación (COVICOM).

a.3 Verificar la dirección y los datos de contacto.

B. PRESENTACIÓN.

Al llegar al domicilio registrado, el responsable de la visita debe identificarse y explicar el motivo de la visita, según el siguiente protocolo:

"Buenos días/tardes. Mi nombre es (nombre del responsable de la visita) del (Nombre del establecimiento). Estamos realizando visitas para verificar y actualizar información sobre una prestación de salud pendiente del Sr./Sra. (nombre del usuario del registro de espera). ¿Podría hablar con (nombre del usuario del registro de espera o nombre social) o con un representante?"

Respuestas:

b.1 Contacto con usuario del registro de espera o representante: continuar con etapa C. "Datos de la visita domiciliaria".

b.2 Contacto equivocado: continuar con etapa D. "Solicitud de información del usuario: contacto con un tercero".

b.4 No se concreta visita domiciliaria: flujo de no contactabilidad. Registrar el motivo (Domicilio no corresponde, no hay nadie en la vivienda, no acepta visita, dirección no existe, otro motivo).

C. REGISTRO DE LA VISITA DOMICILIARIA Y COVICOM.

Se debe confirmar, actualizar y registrar la siguiente información, junto con la aplicación del COVICOM:

1. Identificación del usuario del registro de espera:

"Sr. /Sra. Nombre. Para tener una comunicación efectiva, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos:

i. *RUN.*
ii. *Nombres.*
iii. *Primer apellido.*
iv. *Segundo apellido.*
v. *Nombre social.*
vi. *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número, referencias de la ubicación en zonas rurales o extremas.*
vii. *Teléfonos fijo y móviles.*
viii. *Correo electrónico.*
ix. *Los mismos datos del representante si corresponde, incluyendo el parentesco".*
x. *Previsión de salud del usuario del registro de espera.*

2. Verificación la persistencia de la necesidad de salud registrada:

Si la persona que responde es el usuario del registro de espera consultar:

"Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social), ¿usted está en espera de una prestación de salud (detalle de la prestación en espera) en el (Nombre del establecimiento)?"

Si la persona que responde es el representante:

"Sr./Sra. (Nombre representante), ¿el/la Sr./Sra. (Nombre del usuario del registro de espera o nombre social) está en espera de una prestación de salud (detalle de la prestación en espera) en el (Nombre del establecimiento)?"

Respuestas:

c.1 Si está a la espera.

c.2 No está a la espera.

Continuar con el registro según el ítem 3.

3. Registro del requerimiento de la prestación de salud en espera:

i. Registro del requerimiento de la/s prestación/es de salud.
ii. Si no requiere la prestación, registro de la causal de egreso o excepción o cierre de garantía GES que corresponda.
iii. Detalles del contacto efectuado y confirmación de comprensión de la información entregada por el usuario o su representante.
iv. Fecha y hora de la visita.
v. Información de responsable que realiza la visita.

D. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL USUARIO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre ¿puede comunicarme o tiene como ubicar a él/la Sr. /Sra. Nombre y apellidos (indicado en el registro de espera)?"

Respuestas:

e.1 Entrega información o comunica con el usuario del registro de espera: registrar información de contacto entregada o continuar con ítem **C. REGISTRO DE LA VISITA DOMICILIARIA.**

e.2 Domicilio equivocado: flujo de no contactabilidad.

E. CIERRE.

"Muchas gracias por su atención.

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el (Nombre del establecimiento) a través de los siguientes canales:

- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Correo electrónico: [correo electrónico]*
- *Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]"*

F. FORMATO.

REGISTRO DE VISITA DOMICILIARIA EXTERNALIZADAS								
Información de la/s prestación/es en espera								
Fecha de la visita								
¿Se concreta visita?		Sí				No		
Si la respuesta es No, registrar motivo:		Domicilio incorrecto		Vivienda deshabitada		No acepta visita		Dirección no existe
		Otro motivo:						
1. Identificación del usuario								
Nombre completo								
RUN y dv								
Domicilio (Región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número)								
Teléfonos fijo y móviles								
Correo electrónico								
Previsión de salud								
2. Identificación del representante/persona bajo cuyo cuidado se encuentre								
Nombre completo								
RUN y dv								
Teléfonos fijo y móviles								
Correo electrónico								
Parentesco								
3. Datos de la prestación en espera								
Requiere atención		Sí				No		
Si la respuesta es No, registrar motivo:		Usuario rechaza atención						
		Usuario se atendió en extra-sistema						
		Otro motivo:						
Observaciones de la visita								
Firma usuario o representante								
4. Compromiso de Vinculación y Comunicación (Indicar si se aplicó)		Sí				No		
5. Responsable que realiza la visita								
Nombre completo								
RUN y dv								
Firma								

SCRIPT 6.6: VISITAS DOMICILIARIAS EXTERNALIZADAS.

En las visitas domiciliarias realizadas por personal externo a la institución se debe recabar la mayor cantidad de información necesaria para dar continuidad a los procesos asistenciales posteriores, sin compartir información sensible sobre el caso.

A. PREPARACIÓN PREVIA A LA VISITA.

a.1 Revisar la información del usuario.

a.2 Preparar el formulario de contacto (registro de la visita domiciliaria) y el Compromiso de Vinculación y Comunicación (COVICOM).

a.3 Verificar la dirección y los datos de contacto.

B. PRESENTACIÓN.

Al llegar al domicilio registrado, el responsable de la visita debe identificarse y explicar el motivo de la visita, según el siguiente protocolo:

"Buenos días/tardes. Mi nombre es (nombre del responsable de la visita). Vengo en representación del (Nombre del establecimiento). Estamos realizando visitas para verificar y actualizar información del Sr./Sra. (nombre del usuario del registro de espera). ¿Podría hablar con (nombre del usuario del registro de espera o nombre social) o con un representante?"

Respuestas:

b.1 Contacto con usuario del registro de espera o representante: continuar con etapa **C. "Datos de la visita domiciliaria".**

b.2 Contacto equivocado: continuar con etapa **D. "Solicitud de información del usuario: contacto con un tercero".**

b.4 No se concreta visita domiciliaria: flujo de no contactabilidad.. Registrar el motivo (Domicilio no corresponde, no hay nadie en la vivienda, no acepta visita, dirección no existe, otro motivo).

C. REGISTRO DE LA VISITA DOMICILIARIA.

Se debe confirmar, actualizar y registrar la siguiente información:

1. Identificación del usuario del registro de espera:

"Sr. /Sra. Nombre. Para tener una comunicación efectiva, es muy importante que podamos verificar los siguientes datos:

i. *RUN.*

ii. *Nombres.*

iii. *Primer apellido.*

iv. *Segundo apellido.*

v. *Nombre social.*

vi. *Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número. Referencias geográficas en zonas extremas o rurales.*

vii. *Teléfonos fijo y móviles.*

viii. *Correo electrónico.*

ix. *Previsión de salud del usuario del registro de espera.*

x. *Los mismos datos del representante si corresponde, incluyendo el parentesco".*

2. Notificación para la actualización de la prestación de salud en espera:

Si la persona que responde es el usuario del registro de espera consultar:

"Sr./Sra. (Nombre usuario o nombre social). Para actualizar su información de salud le solicitamos encarecidamente que utilice alguno de estos canales institucionales para contactarse con el (Nombre del establecimiento):

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Otros: [Especificar]*

Esto, para proteger su privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio"

Si la persona que responde es el representante:

"Sr./Sra. (Nombre representante), Para actualizar la información de salud de (Nombre usuario del registro de espera o nombre social) le solicitamos encarecidamente que utilice alguno de estos canales institucionales para contactarse con el (Nombre del establecimiento):

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Otros: [Especificar]*

Esto, para proteger la privacidad y asegurar la precisión de la información, no podemos discutir detalles específicos por este medio"

3. Registros adicionales de los datos de la visita:

i. Fecha y hora de la visita.

ii. Detalles del contacto efectuado y confirmación de comprensión de la información entregada por el usuario o su representante.

iii. Información de responsable que realiza la visita.

iv. Aplicar el COVICOM.

D. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL USUARIO: CONTACTO CON UN TERCERO.

"Sr. / Sra. Nombre ¿puede comunicarme o tiene como ubicar a él/la Sr. /Sra. Nombre y apellidos (indicado en el registro de espera)?"

Respuestas:

e.1 Entrega información o comunica con el usuario del registro de espera: registrar información de contacto entregada o continuar con ítem **C. REGISTRO DE LA VISITA DOMICILIARIA.**

e.2 Domicilio equivocado: flujo de no contactabilidad.

E. CIERRE:

"Dada la importancia del asunto, le solicitamos encarecidamente que utilice alguno de estos canales institucionales para contactarse con el (Nombre del establecimiento):

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Otros: [Especificar]*

Le informamos que tiene un plazo máximo de 30 días para responder a esta notificación por los canales que se le indicaron. La falta de respuesta dentro del plazo establecido resultará en el cierre de su caso por no contacto.

Agradecemos su pronta respuesta a este asunto y esperamos su colaboración para resolverlo de manera satisfactoria.

Atentamente,

[Nombre del responsable]
[Unidad responsable]
[Nombre del establecimiento]"

F. FORMATO.

REGISTRO DE VISITA DOMICILIARIA INSTITUCIONAL								
Fecha de la visita								
¿Se concreta visita?		Sí				No		
Si la respuesta es No, registrar motivo:		Domicilio incorrecto		Vivienda deshabitada		No acepta visita		Dirección no existe
		Otro motivo:						
1. Identificación del usuario								
Nombre completo								
RUN y dv								
Domicilio (Región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle y número)								
Teléfonos fijo y móviles								
Correo electrónico								
Previsión de salud								
2. Identificación del representante								
Nombre completo								
RUN y dv								
Teléfonos fijo y móviles								
Correo electrónico								
Parentesco								

Observaciones de la visita				
Firma usuario o representante				
3. Compromiso de Vinculación y Comunicación (Indicar si se aplicó)		Sí		No
4. Responsable que realiza la visita				
Nombre completo				
RUN y dv				
Firma				

SCRIPT 6.7: CARTA CERTIFICADA.

A. ENCABEZADO:

(Nombre del establecimiento). (Dirección del establecimiento). (Unidad responsable del envío de la carta). (Fecha). (Correlativo).

B. DATOS DEL DESTINATARIO:

(Nombre completo del usuario del registro de espera y nombre social). (RUN). (Dirección del usuario).

C. CUERPO DE LA CARTA:

"Estimado/a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Junto con saludarle, por el medio de la presente carta, desde el (Nombre del establecimiento) le informamos que nos ha sido imposible tomar contacto con usted mediante los datos de contacto que figuran en nuestros sistemas (adjuntar datos de contacto: números telefónicos, correo electrónico, otros). Esto, con el propósito de gestionar de forma urgente su prestación de salud pendiente.

Por este motivo, requerimos su atención inmediata y le solicitamos encarecidamente que utilice alguno de estos canales institucionales para contactarse con el (Nombre del establecimiento) y actualizar su información:

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*
- *Otros: [especificar]*

*Le informamos que tiene un **plazo máximo de 30 días** para responder a esta notificación por los canales que se le indicaron. La falta de respuesta dentro del plazo establecido resultará en el cierre de su caso por no contacto.*

D. CIERRE:

"Agradecemos su pronta respuesta y esperamos su colaboración para resolverlo de manera satisfactoria.

Atentamente,

[Nombre del responsable]

[Cargo]

[Nombre del establecimiento]

E. NOTA FINAL:

"Esta es una notificación formal enviada por correo certificado. Por favor, conserve este documento para sus registros. La confidencialidad de esta comunicación está protegida por ley".

SCRIPT 6.8: RADIODIFUSIÓN.

A. MENSAJE:

"Atención, este es un mensaje importante para el/la Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social).

Nos ponemos en contacto desde (Nombre del establecimiento).

Se solicita a Sr./Sra. (Nombre completo del usuario del registro de espera o nombre social) que se comunique con el (nombre del establecimiento). Existe un asunto urgente que requiere su presencia.

Por favor, utilice alguno de estos canales institucionales para contactarse con el (Nombre del establecimiento).

- *Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]*
- *Teléfono: [número de teléfono y horarios]*
- *Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]*

Gracias por su atención"

9.5. ANEXO N°5: FORMATO PARA EL COMPROMISO DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN (COVICOM)

Estimado(a) usuario(a):

El presente documento tiene como objetivo brindarle información clara y transparente sobre el proceso de espera para su prestación de salud. Es importante que conozca los datos relevantes y asuma la responsabilidad de mantenerse ubicable durante este período.

Es fundamental que lea detenidamente el contenido y, al final del documento, complete los datos solicitados para confirmar que ha comprendido la información proporcionada y autorizar los medios por los cuales nos comunicaremos con usted o su representante legal. Ante cualquier cambio, asegúrese de notificarlo oportunamente para evitar inconvenientes en nuestra comunicación.

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier inquietud que pueda surgir durante este proceso.

I. Sección Informativa

1. Información disponible sobre los procesos de gestión de los registros de espera:
   a. Procesos de Gestión de Registros de Espera: *[incluir información relevante sobre los procesos de gestión del registro de espera, tiempos estimados de respuesta y/o solicitudes].*
   b. Los tiempos de espera estimados varían según el tipo de atención, especialidad y la disponibilidad de recursos. Puede consultar el tiempo de espera promedio para su caso en [enlace al portal paciente si corresponde].
   c. Si tiene alguna duda o consulta sobre su proceso de atención, puede contactarnos a través de los canales de comunicación indicados en este documento.

2. Canales de comunicación bidireccionales: Puede comunicarse con el establecimiento a través de los siguientes canales:
   a. Teléfono: [número de teléfono y horarios]
   b. Correo electrónico: [correo electrónico]
   c. Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]
   d. Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]
   e. Portal paciente: [enlace, forma de ingreso, información disponible]
3. Sus derechos y deberes en relación con las actividades vinculadas con su atención de salud:

   Derechos:
   a. Usted tiene derecho a recibir información completa, oportuna, veraz y comprensible sobre su estado de salud, los procedimientos médicos que se le realizarán, y el establecimiento público o privado que las llevará a cabo.
   b. Que el profesional que realiza la atención tenga acceso a información personal necesaria, para determinar u otorgar los beneficios de salud que a usted le corresponda.
   c. Ser informado sobre los medios tecnológicos y la conectividad necesaria, así como las acciones que deben realizar para comunicarse correctamente con el establecimiento de salud.
   d. Puede presentar reclamos o consultas si considera que sus derechos han sido vulnerados.

   Deberes:
   a. Es importante que entregue información veraz acerca de su identidad y sus síntomas.
   b. Debe informarse sobre los procedimientos de reclamos y consultas establecidos y acerca del funcionamiento del establecimiento.
   c. Es responsable de mantener su información de su dirección y datos de contacto actualizados para que podamos comunicarnos con usted cuando sea necesario.

II. Atenciones digitales por telemedicina:

Por favor, confirme si acepta la posibilidad de recibir atención digital por telemedicina. Lo anterior facilitará las gestiones posteriores que se puedan desarrollar en la red asistencial. Importante: esta confirmación no reemplaza el proceso de aceptación o desistimiento de atención digital definidos bajo dicha modalidad.

1. Acepto atenciones por telemedicina _____
2. No acepto las atenciones por telemedicina _____
3. **Sección de confirmación de comprensión de la información entregada:** firma el usuario o la persona bajo cuyo cuidado se encuentre.

Por favor, confirme su comprensión explícita de la información proporcionada:

- Nombre del Usuario: _____
- R.U.N: _____
- Nombre del representante: _____
- R.U.N. del representante: _____
- Relación con el usuario [por ejemplo, padre, madre, tutor legal, etc.]: _____

Confirmo que he recibido y comprendido la información proporcionada, y que asumo la responsabilidad de mantener actualizados los datos de contacto.

Confirmo que he recibido y comprendido la información proporcionada respecto al uso de mi información personal para determinar u otorgar beneficios de salud y cumplir objetivos sanitarios, incluyendo la posibilidad que dicha información sea utilizada para la gestionar atenciones en diferentes prestadores de la red tanto públicos como privados,

Autorizo al establecimiento a comunicarse conmigo y/o mi representante a los siguientes medios (indicar preferencias de contacto):

Datos de contacto:

a. Teléfonos: [números de teléfonos] _____
b. Correo electrónico: _____
c. Domicilio [especificar domicilio] _____
d. Otro: _____

Preferencia de contacto por orden del 1 al 5 (siendo el número 1 de mayor preferencia):

_____ Teléfonos

_____ Correo electrónico

_____ Mensajería instantánea

_____ Mensajería instantánea SMS

_____ Otro

_____	_____
Firma del usuario o representante	Fecha

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LOS DATOS DE CONTACTO, POSTERIOR A LA FECHA DE APLICACIÓN DEL COVICOM, DEBE SER REGISTRADA Y ANEXADA A ESTE DOCUMENTO.

IMPORTANTE:

El registro debe ejecutarse, de forma preferencial, al momento de la vinculación y debe realizarse individualmente por cada prestación en espera que tenga la persona. La información recabada debe quedar debidamente documentada en el historial del usuario en el sistema local, disponible y resguardado durante todo el proceso de referencia y contrarreferencia. El usuario puede solicitar una copia adicional de este documento en cualquier momento.

Es importante enfatizar que, es necesario que la Red Asistencial **mantenga actualizado, tanto el COVICOM, como los datos de contacto de los usuarios,** a fin de captar las preferencias de comunicación y atención.

9.6. ANEXO N°6: REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PORTALES PACIENTE

Los portales de pacientes son sitios web que pueden actuar como repositorios digitales, permitiendo a los usuarios acceder a su información de salud personal de forma segura. Además, los portales pueden facilitar la interacción entre los usuarios y los establecimientos de salud, proporcionando una plataforma centralizada para la gestión de datos de salud, comunicación bidireccional y el acceso a servicios de salud en línea. En el contexto de la agenda de modernización del Estado, estos portales representan un avance significativo hacia la digitalización y eficiencia de los servicios públicos, mejorando la accesibilidad y la calidad de la atención de salud para los ciudadanos.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Las condiciones para la implementación de portales de pacientes están descritas en el Decreto N°1 que aprueba la norma técnica sobre sistemas y sitios web de los órganos de la administración del estado[36]. Este decreto establece que los sistemas y sitios web deben ser desarrollados o implementados de manera tal que garanticen la disponibilidad y la accesibilidad de la información, así como el debido resguardo de los derechos de los titulares de datos personales, asegurando la interoperabilidad de los contenidos, funciones y prestaciones ofrecidas por el respectivo órgano de la Administración del Estado, independientemente de las plataformas, hardware y software utilizados. A continuación, se detallan los requerimientos mínimos que debe contener el portal que pueden mejorar la experiencia del usuario.

1. La implementación de portales de pacientes debe cumplir con una serie de condiciones de seguridad:

A continuación, se detallan las condiciones claves para asegurar la protección de los datos de los usuarios:

Aspectos normativos:

a. Cumplimiento con la Ley 19.628 (Protección de la Vida Privada): el portal debe garantizar que los datos personales del usuario sean procesados de acuerdo con los principios de minimización de datos y finalidad específica, es decir, los datos solo deben ser utilizados para los fines específicos para los que fueron recolectados (como la atención médica). Los usuarios deben otorgar su consentimiento explícito para el tratamiento de sus datos a través de mecanismos claros y accesibles.

b. Cumplimiento con la Ley 20.584 (Derechos y Deberes de los Pacientes): el portal debe garantizar que los usuarios sean informados sobre el tratamiento de sus datos personales y brindarles la posibilidad de acceder, modificar y eliminar su información de manera transparente. Las políticas de privacidad deben ser claras y fáciles de entender, de acuerdo con los derechos de los pacientes en Chile.

c. Cumplimiento con la Ley N° 21.663 (Ley Marco de Ciberseguridad), que proporciona un marco para asegurar la ciberseguridad de infraestructuras críticas.

d. Cumplimiento de la Ley N° 21.180 Ley de Transformación Digital del Estado, que establece directrices para la modernización de los procesos y servicios digitales en instituciones públicas.

e. Cumplimiento del Decreto Supremo N° 7, que establece una Norma Técnica de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, en concordancia con la Ley N° 21.180 sobre Transformación

[36] Secretaría General de la Presidencia. (2015). Decreto 1 Aprueba Norma Técnica sobre sistemas y sitios web de los órganos de la administración del estado. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1078308

Digital del Estado. Que tiene el objetivo de definir estándares mínimos de seguridad y ciberseguridad para todos los órganos de la administración pública en Chile, contribuyendo a la protección de los datos personales y a la seguridad de la información en los sistemas digitales gubernamentales.

f. Cumplimiento con la Política General de Seguridad y Ciberseguridad del Ministerio de Salud, de Resolución Exenta N° 1465 año 2023 y el Instructivo de Ciberseguridad para Sector Salud, a través de la Resolución Exenta N° 785 año 2021, que entregan los lineamientos para la implementación de una línea base de Seguridad de la información y ciberseguridad, para las Instituciones del Sector.

g. Cumplimiento a las Políticas y Procedimientos vigentes de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud, publicadas en el link https://www.minsal.cl/seguridad_de_la_informacion/.

Condiciones de Seguridad:

a. El acceso al portal debe estar protegido por mecanismos de autenticación robustos, como autenticación de dos factores (2FA), para prevenir accesos no autorizados. De acuerdo con lo indicado en el Instructivo Presidencial de Transformación Digital, las instituciones del Estado deberán utilizar Clave Única, la cual es un proveedor de identidad digital de Chile que funciona como mecanismo de autenticación para que los ciudadanos puedan acceder a distintas plataformas y servicios del Estado utilizando una sola contraseña.

b. Todos los datos transmitidos y almacenados en el portal deben estar cifrados, utilizando estándares de cifrado modernos (como TLS 1.3 para la transmisión y AES AES-256, para el almacenamiento), para proteger la confidencialidad de la información personal y de salud.

c. Los permisos de acceso a la información del portal deben ser estrictamente controlados. Solo el personal autorizado (médicos, otros profesionales de la salud, administradores) debe tener acceso a los datos de salud. Los roles de usuario deben estar claramente definidos para limitar el acceso a la información según las necesidades.

d. El portal debe contar con registros de auditoría que permitan hacer un seguimiento detallado de quién accedió a qué información y cuándo, para detectar posibles accesos no autorizados o actividades sospechosas.

e. El portal debe contar con un plan de respaldo y recuperación ante desastres, asegurando que los datos del usuario sean recuperables en caso de incidentes, tales como fallos de sistema o ciberataques. Los respaldos deben realizarse de manera regular y almacenarse en un entorno seguro.

f. El personal encargado de gestionar el portal debe recibir capacitación constante en ciberseguridad y en el manejo adecuado de la información confidencial de los usuarios. Esto incluye la identificación de "phishing" y otros tipos de ataques cibernéticos.

g. El portal debe someterse a auditorías de seguridad regulares y evaluaciones de vulnerabilidad para identificar posibles puntos débiles y corregirlos antes de que puedan ser explotados por atacantes. La plataforma debe realizar pruebas de penetración periódicas y contar con herramientas de detección de intrusos (IDS) para monitorear el tráfico en tiempo real y detectar actividades sospechosas.

h. Para fortalecer la seguridad, el portal debe alinearse con estándares internacionales de seguridad como ISO 27001 (Gestión de la Seguridad de la Información) y ISO 27799 (Seguridad

de la Información en la Salud), así como las mejores prácticas recomendadas por organismos como la HIPAA (en el caso de tener interacciones con usuarios internacionales) y las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la protección de datos en salud.

i. El portal debe permitir la comunicación entre los usuarios y el personal de salud a través de canales seguros, como mensajería cifrada o videoconferencias con cifrado de extremo a extremo, para garantizar que la información sensible no sea interceptada.

j. El portal debe ser actualizado regularmente con parches de seguridad para corregir vulnerabilidades de software y evitar que sean aprovechadas por atacantes. Las actualizaciones deben ser gestionadas de manera controlada para minimizar el riesgo de interrupciones.

2. Información del portal paciente:

a. Términos y condiciones para el acceso y uso de la plataforma.

b. Política de privacidad: conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y sus modificaciones posteriores, no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

3. Administrador del portal:

a. Según el Artículo 10 del Decreto N°123, cada órgano de la Administración del Estado deberá designar un administrador técnico y un administrador de contenido de sus sistemas web y sitios web. El administrador de contenido de los sistemas web y plataformas web deberá monitorear el contenido y prestaciones que se brindan por su intermedio como proceso continuo, para mejorar la calidad de estas últimas.

4. Visualización y actualización de datos: formulario en línea que cuente con la siguiente información, según normativa vigente N°820.

a. Datos personales básicos: Solo visualización, si existe algún error en la información debe indicarse el medio por el cual el usuario debe notificarlo.
   - RUN.
   - Nombres.
   - Primer apellido.
   - Segundo apellido.
   - Fecha de nacimiento.
   - Previsión y PRAIS.

b. Datos de contactabilidad: deben poder actualizarse.
   - Domicilio del usuario: región, ciudad, comuna, condición de ruralidad, nombre de la calle, número y referencias adicionales que permitan la localización del domicilio.
   - Teléfonos fijo y móviles.
   - Correo electrónico.
   - Otros: redes sociales, etc.

5. Autorizaciones o consentimientos firmados por el usuario: obtener el Compromiso de Comunicación y Vinculación (COVICOM). Este documento puede ser llenado por el funcionario/a si el usuario no puede completarlo por sí mismo. Asimismo, el documento podría ser firmado "a ruego del usuario" por el funcionario, en el caso de que la persona no pueda firmar (ver Anexo N°5).

6. Visualización de sus prestaciones en espera:

a. Visualización de tiempos de espera: especialidad, prestación, establecimiento resolutor, fecha de ingreso al registro de espera. Informando al usuario "su establecimiento resolutor tiene una mediana de espera de X días para su prestación de salud".

b. Se debe desplegar la información para cada prestación en espera registrada del usuario.

7. Información y requerimientos del usuario sobre sus prestaciones de salud en espera: se despliega formulario para que el usuario actualice la información de cada prestación en espera registrada, con las siguientes preguntas.

a. ¿Usted está aún en espera de la prestación descrita?

- Si la respuesta es Sí:
  - Se recomienda la incorporación de modelos de escalas de evaluación, como encuestas breves, que pueden integrarse dependiendo del contexto local, el objetivo específico de la comunicación y la prestación en espera (por ejemplo: escalas de evaluación de calidad de vida, estado de salud, etc.).
    - » Desplegar formulario de autoeficacia[37]: medir la autoeficacia en usuarios es crucial porque esta percepción influye significativamente en la capacidad del individuo para manejar enfermedades, adherirse a tratamientos y realizar cambios de comportamiento necesarios para mejorar la salud. Una baja percepción está asociada con peores resultados de salud y mayor riesgo de morbimortalidad en las personas[38] (para más detalles del formulario propuesto revisar el Anexo N°7).
- Si la respuesta es No, desplegar formulario con el siguiente listado de motivos de egreso o excepción o cierre de garantía GES:
  - Despliegue de los siguientes motivos de salidas de registro:
    - a.1. Rechazo o renuncia de la atención.
    - a.2. Atención ya realizada de forma particular.
    - a.3. Otros motivos.
  - En el caso de las respuestas a.1 y a.2, se debe desplegar un cuadro informando al usuario que su caso será egresado, exceptuado o cerrado del registro de espera según su indicación, solicitando la confirmación de la acción que está registrando. Un segundo cuadro de verificación debe desplegarse cuando la persona indica confirmar el egreso o excepción o cierre de garantía GES.
  - Una vez registrada la solicitud de salida del registro por el usuario en el portal paciente, se debe realizar el siguiente procedimiento interno para verificar la información:

[37] Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy Scale. En J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON.

[38] González, C., & Calderón, C. (2009). Autoeficacia y su relación con la adhesión al tratamiento en pacientes crónicos en Chile. Revista Médica de Chile, 137(9), 1173-1180.

» Envío de correo electrónico a la cuenta informada por el usuario solicitando confirmación del no requerimiento de la prestación de salud registrada, con un plazo de hasta 5 días para que el usuario confirme o niegue el egreso o excepción o cierre de garantía GES informado en el portal paciente.

» Además, se realizarán dos llamadas telefónicas a los teléfonos registrados en el portal paciente por el usuario para verificar el egreso o excepción o cierre de garantía GES. Las llamadas deben realizarse en un plazo máximo de cinco días desde informado el egreso o excepción o cierre de garantía GES por el usuario en el portal.

» Si tras los intentos de contacto mediante correo electrónico y llamadas telefónicas en el plazo establecido de 5 días, en días y horarios diferentes, una de las cuales debe ser en horario inhábil. Si no se logra ubicar al usuario, se procederá a egresar el caso considerando lo informado previamente por el usuario en el portal paciente.

- En el caso de otros motivos de salidas de registro (a.3), el establecimiento deberá tomar contacto con la persona en el menor tiempo posible, para verificar la información.

b. Solicitudes y requerimientos del usuario: ítem para que el usuario registre información.

CONTACTABILIDAD

¿Requiere algún tipo de información respecto a su prestación en espera?

Sí, No

Si es Sí, señalar tipo de información requiere: anular cita, confirmar cita, consultar de su estado de cita médica.

¿Requiere que el establecimiento se ponga en contacto?

Sí, No

¿Por qué medio desea que lo contactemos (teléfono, correo electrónico, mensaje de texto) para resolver su solicitud?

Teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, cualquiera.

¿Cuál es el mejor momento para contactarle?

Mañana, tarde, noche, fin de semana, horario laboral, señalar horario y día

Por favor verifique sus datos de contacto y actualícelos de ser necesario:

(Despliegue de la información de contacto). Editar o confirmar.

SOLICITUD

¿Tiene alguna preocupación específica que le gustaría resolver con el establecimiento?

Sí, No, Prefiero no decir.

Si la respuesta es Sí, señalar cual

¿Hay algún cambio reciente en su estado de salud que deba informarnos?

Sí, No, Prefiero no decir.

Si la respuesta es Sí, señalar cual

¿Tiene alguna necesidad especial o preferencia que debamos considerar?

Sí, No, Prefiero no decir.

Si la respuesta es Sí, se debe indicar cual es la necesidad especial

¿Prefiere citas presenciales o telemedicina?

Presenciales, telemedicina, ambas.

¿Requiere asistencia para su cita ya programada?

Sí, No,

Si la respuesta es Sí, se debe indicar cual es la asistencia que requiere

¿Le gustaría sugerir alguna mejora en nuestro servicio?

Sí, No, Especificar.

8. Canales de comunicación con la Red de Atención: se deben indicar los medios de contacto con el establecimiento en el caso de dudas o consultas relacionadas a su prestación de salud.

a. Teléfono: [número de teléfono y horarios]
b. Correo electrónico: [correo electrónico]
c. Mensajería instantánea: [plataforma de mensajería]
d. Atención presencial: [ubicación y horario de atención presencial]
e. Incluir funcionalidades como notificaciones y un sistema de respuesta para facilitar la interacción.

9. Sistema de notificaciones en línea:

a. Notificar al usuario sobre intentos de contactabilidad por parte del establecimiento de salud.
b. Enviar recordatorios de citas médicas y otra información relevante.
c. Permitir al usuario configurar las preferencias de notificación (ej. correo electrónico, notificaciones).

10. Características opcionales:

a. Geolocalización de usuarios con domicilios inexactos, como domicilios rurales sin numeración o campamentos, para precisar su ubicación. Los usuarios pueden indicar su domicilio exacto por medio de esta función.
b. Integración con dispositivos o aplicaciones móviles para el seguimiento de la salud del usuario.
c. Funcionalidades de telemedicina, como videollamadas o consultas en línea con profesionales de la salud.

9.7. ANEXO N°7: PROPUESTA DE CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA[39]

Estimado/a usuario,

Solicitamos a continuación que responda 10 preguntas para conocer su capacidad de automanejo frente a situaciones relacionadas con su salud. No es una prueba; no hay respuestas correctas o incorrectas. Sus respuestas nos ayudarán a orientar mejor su atención.

Instrucciones:

Se presentan diez afirmaciones. Lea cada una cuidadosamente y seleccione la opción que mejor describa su nivel de acuerdo con cada afirmación. Para cada una de las siguientes preguntas, por favor marque con una la casilla que mejor corresponda a su respuesta. No hay respuestas correctas o incorrectas; lo importante es que refleje su percepción personal.

1. Creo que puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo suficiente (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

2. Si alguien se me opone, puedo encontrar los medios y las maneras de conseguir lo que quiero (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

3. Puedo mantener la calma cuando enfrento dificultades porque confío en mis habilidades de afrontamiento (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

[39] Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures in health psychology: A user's portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON.

4. Soy capaz de enfrentarme a cualquier situación inesperada (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

5. Gracias a mis capacidades, sé cómo manejar situaciones imprevistas (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

6. Puedo resolver problemas difíciles si trato lo suficiente (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

7. Siempre encuentro una solución cuando me enfrento a problemas (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

8. Generalmente, puedo manejar lo que me pasa (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

9. Puedo enfrentarme a una situación inesperada con recursos propios (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

10. Cuando me enfrento a un problema, generalmente puedo pensar en una solución (marque una opción).

- ☐ 1 (No es cierto en absoluto)
- ☐ 2 (Poco cierto)
- ☐ 3 (Moderadamente cierto)
- ☐ 4 (Es totalmente cierto)

Instrucciones para el evaluador: Sume los puntajes de cada respuesta para obtener una puntuación total de autoeficacia del usuario. La puntuación puede variar entre 10 y 40 puntos, donde una puntuación más alta indica una mayor autoeficacia/automanejo.

9.8. ANEXO N°8: INDICADORES PARA EL PROCESO DE CONTACTABILIDAD

Indicador N°1:

- Nombre del indicador: Porcentaje de usuarios contactados efectivamente en el evento de vinculación.
- Frecuencia de medición: Mensual.
- Composición del indicador: N° de usuarios contactados efectivamente en el evento de vinculación / N° de usuarios totales a vincular *100.

Indicador N°2:

- Nombre del indicador: Porcentaje de usuarios contactados efectivamente en el evento de monitoreo y seguimiento.
- Frecuencia de medición: Mensual.
- Composición del indicador: N° de usuarios en proceso de seguimiento y monitoreo / N° de usuarios totales vinculados con necesidad de atención *100.

Indicador N°3:

- Nombre del indicador: Porcentaje de usuarios contactados efectivamente en el evento de agendas y citas.
- Frecuencia de medición: Mensual.
- Composición del indicador: N° de usuarios contactados con citación efectiva/ N° de usuarios totales definidos para el agendamiento *100.

Indicador N°4:

- Nombre del indicador: Porcentaje de usuarios contactados efectivamente en el evento de post atención.
- Frecuencia de medición: Mensual.
- Composición del indicador: N° de usuarios contactados efectivamente en el evento de post atención / N° de usuarios totales atendidos en base a la agenda *100.

Indicador N°5:

- Nombre del indicador: Porcentaje de confirmaciones de citas enviadas.
- Frecuencia de medición: Mensual.
- Composición del indicador: N° de usuarios a los cuales se les envió confirmación de citas/ N° de usuarios totales agendados *100.

Indicador N°6:

- Nombre del indicador: Número de COVICOM aplicados.
- Frecuencia de medición: Mensual.
- Composición del indicador: N° de formularios “Compromisos de Vinculación y Comunicación” aplicados.

Indicador N°7:

- Nombre del indicador: Porcentaje de casos pendientes sin vinculación en registros de espera.
- Frecuencia de medición: Mensual.
- Composición del indicador: casos pendientes en sistemas de registros de espera sin vinculación en los últimos 6 meses/total de casos en registros de espera pendientes*100

Indicador N°8:

- Nombre del indicador: Porcentaje de usuarios no ubicables (Para catalogar a un usuario como inubicable se debe haber seguido el flujo de no contactabilidad que corresponda según el contexto)
- Frecuencia de medición: Mensual.
- Composición del indicador: N° de usuarios catalogados como inubicables /N° de usuarios totales a contactar *100.

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile